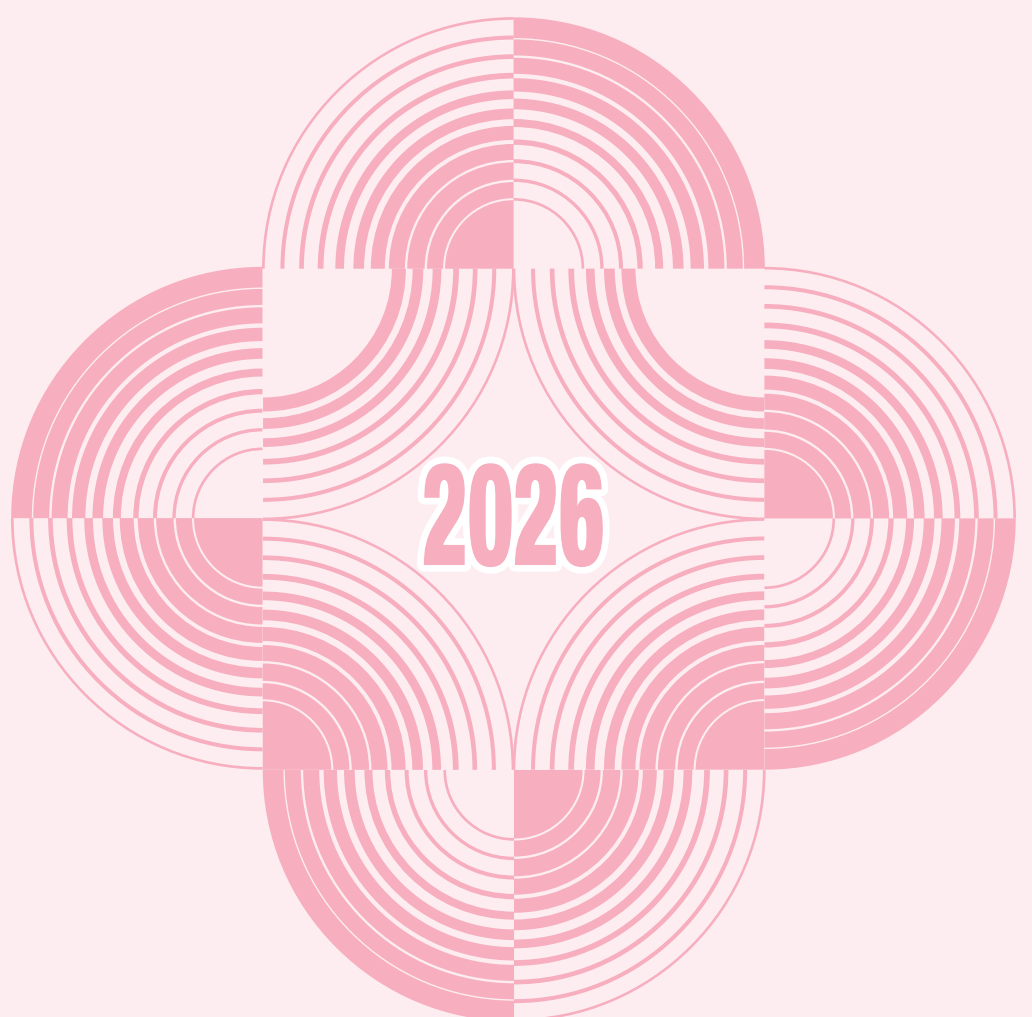


生命保険講座

生命保険総論



2026



一般社団法人

生命保険協会

【受験にあたって】

○試験の実施方法

生命保険業界共通教育試験および生命保険講座試験は、C B T（Computer Based Testing）で実施されます。C B Tは、P C画面に表示された試験問題に、マウス操作により回答する方式です。

W E B上に掲載の「C B T体験版」「C B Tによる受験の仕方」で、操作方法および試験当日の試験会場に会場から退場するまでの流れを事前に確認可能となっております。

<https://www.prometric-jp.com/personal/seiho/guide/>



○主な注意事項

試験日当日の主な注意事項は、次のとおりです。

1. 受験票および本人確認書類の用意

受験にあたっては、受験票および所定の本人確認書類（注）が必要となります。

（注）以下の条件を満たす本人確認書類を提示できないと受験できません。条件を満たす本人確認書類を用意できない場合には、事前に生命保険会社、もしくは所属の保険代理店に連絡してください。

【前提条件】

- ・原本であること（コピーおよび電子媒体は不可）
- ・氏名が明記されていて受験票の氏名と相違がないこと
- ・有効期限内であること
- ・以下A群およびB群の顔写真で本人確認ができること

【有効な組み合わせ】

■ 1点のみで受験可能（A群より1点）

【A群】 *顔写真付き

- ・運転免許証（公安委員会発行のものに限る）
- ・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
- ・パスポート
- ・在留カード、特別永住者証明書（外国人登録証を含む）
- ・個人番号カード（マイナンバーカード）
- ・身体障害者手帳（精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を含む）

■ 2点の組み合わせで受験可能（B群より1点＋C群より1点）

その他の確認書類の組み合わせは不可

【B群】 *顔写真付き

- ・社員証（*1）
- ・学生証（*2）

＋

【C群】

- ・資格確認書（*3）
- ・クレジットカード（自署名があること）

（*1）社員証（募集人登録証を含む）

- ・企業名または団体名が記載されていること
- ・顔写真がプラスチックカードに印刷されていること。または、貼付された顔写真に割印、エンボス、ラミネート加工（社員証全体ではなく、顔写真部分のみでも可）のいずれかの処理がされていること

(＊２) 学生証

- ・中学校，高等学校，高等専門学校，大学，公的機関が設置する職業訓練学校，都道府県知事が認可する専門学校が発行したもの
- ・顔写真が印刷されていること

(＊３) 資格確認書

- ・2024年12月2日以降に，従来の健康保険証に代わって保険者から交付されるもの

2. 試験会場の確認・集合時刻の確認

- ①受験票に記載されている集合時刻までに来場してください（受験規定を読み，受付で本人確認をするため5分前に集合するよう心がけてください）。
- ②集合時刻までに来場できなかった場合には欠席扱いとなり受験できません。あらかじめ交通経路や所要時間を確認しておいてください（遅刻または欠席により受験しなかった場合，受験手数料は返金しません）。
- ③来場の際は，公共交通機関をご利用ください。無断駐車は絶対に行わないでください。

3. 試験会場への資料等の持込み不可

- ①試験室内には私物の持ち込みはできません。貴重品や大きな手荷物のご持参はお控えください。
- ②本人確認書類以外のすべての持ち物（受験票，テキスト，携帯電話，腕時計など）は会場に配置されているロッカーに収納します。なお，携帯電話は必ず電源を切った状態でロッカーに収納してください。
- ③机上にはノートボードとペンがセットされています。ノートボードは，試験中のメモ用紙としてご利用いただけます。
- ④試験室は試験監督員，および監視カメラによりモニタリングされています。不正行為が発覚した場合，試験室から即時に退室していただきます。

4. C B Tにおける操作方法

初めて受験する場合には，パソコンの操作，試験問題の出題形式および当日の受付の流れについて，「C B T体験版」(<https://www.prometric-jp.com/personal/seiho/guide/>)を事前にご確認ください。



目 次

第1章 生命保険の仕組み

1. 危険と保険	2
(1) 現代生活と保険	2
(2) 保険理論における危険	3
(3) 保険の対象となる危険の種類	4
(4) 生命保険の対象となる危険とその特色	5
2. 生命保険契約の意義と性質	7
(1) 生命保険契約の特殊性	7
(2) 生命保険契約の性質	9
3. 生命保険契約の要素	12
(1) 保険者	12
(2) 保険契約者	13
(3) 被保険者	13
(4) 保険金受取人	14
(5) 保険事故	14
(6) 保険期間	14
(7) 保険金額	14
(8) 保険料	15
4. 生命保険の技術的基礎	15
(1) 死亡表	15
(2) 危険の選択	16
(3) 保険料	19

(4) 責任準備金	24
(5) 契約者配当	27
5. 生命保険の基本型と現在の主な商品	31
(1) 生命保険商品の基本型	31
(2) 現在の主な生命保険商品・制度	32

第2章 保険の生成・発展

1. 保険の歴史的発展	52
(1) 古代社会	52
(2) 封建社会	52
(3) ギルドと海上冒険貸借	53
(4) 資本主義社会	54
2. イギリスにおける生命保険の発展—近代的生命保険の誕生— …	55
(1) 賦課式保険の問題点	56
(2) エクイタブル・ソサエティーの誕生	57
(3) 友愛組合	58
(4) 黄金時代から泡沫会社時代へ アクチュアリー協会の誕生 …	59
3. アメリカにおける生命保険事業の発展	60
(1) 19世紀末までの発展	60
(2) 不没収法の制定	61
(3) アームストロング調査	63
(4) 20世紀前半における生命保険事業の発展	64
(5) 第二次大戦後の生命保険事業	65
(6) 金融革命の進展と生命保険事業	67

4. 日本における生命保険の発展	71
(1) 近代的生命保険の導入	72
(2) 日清, 日露戦争前後	73
(3) 第一次大戦前後	75
(4) 保険種類の変遷	77
(5) 第二次大戦	77
(6) 戦後混乱期から再建への足どり	78
(7) 生命保険事業の革新	80
(8) 生命保険事業の現状	84

第3章 生命保険と社会経済

1. 国民経済における生命保険	103
(1) 世帯加入状況	103
(2) 保有契約と国民所得との関連	105
(3) 保険料支出性向	105
(4) 保険金・給付金の支払い	106
(5) 国際比較	107
2. 金融機関としての生命保険会社	108
(1) 生命保険会社の資金の性格	108
(2) 資産運用の原則	108
(3) 資産運用の現状	111
3. 社会保障と生命保険	114
(1) 生活設計の原則と方法	114
(2) 私的保障と社会保障	119

(3) 公的年金制度	126
(4) 公的医療保険	136
(5) 介護保険制度	139

第4章 生命保険会社の経営に関する法的規制

1. 生命保険業の監督の必要性和その方法	148
2. 保険業法	149
(1) 経緯	149
(2) 概要	149
(3) 相互会社と株式会社	160

第5章 民間生命保険の隣接業界

1. 生命共済事業	165
(1) 共済と保険	165
(2) JA共済(全国共済農業協同組合連合会)	166
(3) こくみん共済coop〈全労済〉	169
(4) 各都道府県民共済(全国生協連(都道府県民共済グループ))	170
2. 簡易保険とその他の隣接業界	172
(1) 簡易保険の歴史と現状	172
(2) 損害保険	174
(3) 銀行・信託・証券業界	175
(4) 少額短期保険業	176

第6章 民間生命保険会社の今後のあり方

1. 変貌する経営環境	179
(1) 経済・産業構造の変化	179
(2) 社会構造の変化	181
(3) 消費構造の変化	184
(4) IT技術の進展によるネットワーク社会の到来	186
(5) 金融の自由化・国際化	187
2. 新たな対応に向けて	190
(1) 商 品	190
(2) サービス	193
(3) 販売体制	195
(4) 生保業界におけるシステム動向	197
(5) 資産運用	200
(6) 国際化	202

第1章 生命保険の仕組み

学習のポイント

保険の対象となる危険の基本的な性格を捉えるとともに、生命保険の技術的な基礎となっている原理、また生命保険契約の特殊性、性質について概観したうえで、現在販売されている保険商品の種類、機能および性質について理解する。

重要項目

- 保険の対象となる危険の条件
- 生命保険の対象となる危険の特色
- 保険約款の意義
- 生命保険契約の法的性質
- 死亡表
- 危険選択の必要性
- 自然保険料と平準保険料
- 保険料の構成
- 責任準備金の意義
- 契約者配当の意義
- 生命保険商品の基本型
- 個人保険、団体保険の種類と特質

1. 危険と保険

(1) 現代生活と保険

われわれの経済生活は無数の危険（リスク）に取り巻かれている。個人や世帯の経済面においては、風水害・地震・火災などの天災，詐欺・盗難などの人災，不況による事業の失敗などの社会経済的な災難，さらには世帯主の失業・疾病・傷害等による収入の中断，高度障害・死亡による収入の途絶，家族の疾病・傷害医療費用，教育・結婚費用，高齢者の扶養費用負担等，一家の経済的安定を乱し，困窮，没落の原因となる危険がある。そればかりでなく，他人の身元引受から生じた損害，車の運転の事故による他人の身体，財産に与えた損害の賠償責任を負わねばならなくなる，といった責任負担の問題も起こりうる。

このような危険は，個人や世帯ばかりでなく企業をも脅かしている。企業の取引に伴う様々な危険——製品・材料の輸送途上における災害はもちろん，売掛金の回収不能，相手方の契約解除や不履行の危険——をはじめとして，巨大化，複雑化した機械設備を装備した工場等での故障，事故，従業員の労働災害，さらには廃棄物等による公害の損害賠償責任の問題等，企業は内と外からの絶えざる脅威に対し，その防衛策に気を配らなければならない。

われわれはこのような無数の危険と闘い，これを克服しようと努力している。労働災害や公害を防止するための機械設備の開発，諸災害によってもたらされる経済的損失を補填するための保険制度の発展，社会不安

回避のための社会保険・社会保障、景気変動に対する金融・財政政策を通じてのコントロール技術の進歩、さらには国際紛争を解決するための国際連合などの諸機関による国際的利害の調整の努力等、人類の安全保障を求める努力は続く。それは、克服が不可能であり、避けられぬ必然・運命とかつては考えられていた危険を、人間の合理的知性と人間性に基づき、制御しようとする努力である。そのような危険対策の一手段として保険は位置づけられる。

(2) 保険理論における危険

危険対策のまず第一は、危険の防止あるいは危険の回避である。例えば、住宅火災の危険の場合、火災の未然防止に努めるとともに、火災が発生しても大事に至る前にこれを初期段階で防止できる体制を整えておくことが大事である。

危険対策は保険と密接な関係があるが、保険は危険自体を防止、回避するための危険対策ではなく、危険が現実化した時に生じる経済的損失、負担を軽減、回復するための危険対策である。

故意や突発的な火災による飛行機や船舶、建物の喪失、病気や事故による世帯主の死亡等の不幸な出来事は、企業や家庭に計り知れない経済的打撃を与える。このような打撃で企業や家庭は危機に瀕し、崩壊する場合もある。したがって、こうした経済的打撃や負担を軽減するための何らかの対策を講じておかねばならない。

あらかじめそのための資金を蓄積しておくことも一つの方法であろうし、また、他からの救援を受けることも一つの方法であろう。しかし、この二つの方法は、いずれも不都合がある。他からの救援を受けることは、自己責任の経済主体としての企業や家族が当然の権利として期待できるものではない。また、危険に備えて自力で資金の準備をする方法で

は、いつ起こるか分からぬ危険に対して間に合わぬ場合も出てこよう。

保険においては保険契約者と保険者という当事者があり、保険契約者は自分自身または第三者の経済的打撃や負担のカバーのための資金を蓄積する代わりに保険者に保険料を支払うことによって、いつ危険が現実化しても保険者が直ちにそれをカバーしてくれることを当然の権利として期待することができる。保険料を支払った時から、危険の発生により経済的打撃や負担が生じても、あたかもそれがなかったと同じもとの状態まで回復ができるところに保険の効用がある。

(3) 保険の対象となる危険の種類

保険の対象となる危険の種類は二つある。一つはその発生を防止しようとしても、ある程度以上は不可能であるという意味で経済主体による制御を超えているもの、もう一つは個体としての危険発生頻度の変動幅が大きいため、合理的、経済的な予測が不可能であるという意味で経済主体の制御を超えているものである。

このような危険については、保険契約者は、保険を付することによって保険料支出の形で危険により被る損失の填補を行う。被保険体（保険事故の対象物件または対象者）の被った危険から派生する経済的損失は保険者に肩代わりされる。保険者の危険引受けが可能となるためには、同様な危険を多数引き受けることにより、危険の発生頻度の変動幅を縮小させ、平均経験率を得る必要がある。確率論における大数の法則に基づき、危険を被る対象物（母数）が多いほど危険の発生頻度の変動幅は小さくなる。危険により被る経済的損失が保険金額として貨幣で計算され、危険の程度が危険度として数量化されれば、保険金額と危険度の積として危険評価額は数量化可能となる。

(4) 生命保険の対象となる危険とその特色

保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年（平成22年）4月に施行された。

さて、生命保険の対象となる危険には一般的には以下のものがあり、前述のとおり、その危険の発生から被る経済的危険の担保となるのが生命保険である。

① 死亡危険 ② 生存危険

死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも経済的死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。

死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う損害額を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は主観的な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ一定額に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。

生存危険とは、生存することにより経済的損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは年金給付がある。

傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては「傷害疾病定額保険契約」として典型契約としての地位が与えられ、同保険契約は「人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」（保険法第2条）と規定されている。

傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、

就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険と異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することではなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。

生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではない。このため、生命保険に対するニーズは潜在的である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。

死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、後述する平準保険料対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、金融機関としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ養老保険の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。

2. 生命保険契約の意義と性質

(1) 生命保険契約の特殊性

現代生活における生命保険は、他の商取引と同じく近代経済社会の原則に従い、保険契約者と保険者との間の自由な判断と意思に基づく経済取引として実現される。

したがって、生命保険の取引についても契約自由の原則に支配されるため、取引を行うかどうか、契約の内容としての給付と反対給付に関する債権債務関係についても、保険契約者と保険者の合意が前提となる。

しかし、生命保険の経済的本質や技術的基礎、さらには広く大衆を顧客対象としている取引の実体から、その法的領域については特殊性が生じる。

その第1が、生命保険取引に関する規則を定めた保険法であり、第2が、契約内容を一定の条項に定型化した普通保険約款である。

商法は、商行為としての保険（株式会社形態の保険会社が行う保険）を規律対象としつつ、相互保険（相互会社形態の保険会社が行う保険）にも準用される形となっていたが、いわゆる共済は商法の規律対象ではなく保険約款に関する商法の規定は類推適用に留まると解されていた。しかし、保険法においては、保険契約者と実質的に同じ地位に置かれている共済契約者の保護の観点から、共済契約も保険法の適用対象とされている。

さて、生命保険は一般の多くの人々を相手として取引され、かつ、この取引の内容は専門的、技術的事項を含んでいるため、この保険取引を行う保険会社は処理の効率化のため、あらかじめ保険法に規定されていない事

項をも含んだ標準的な契約内容の条項を作成しておく必要がある。

そして、契約に当たっては別段の約定がない限り、この標準的契約条項、すなわち普通保険約款を内容として取引する方法を採用しているので、通常保険契約の締結は約款を承認するか否かの合意によって決まることになる。

しかし、一般に、生命保険契約の締結に際して保険契約の申込者が保険約款の各条項を知ったうえで理解し納得しているとは限らない。そこで、生命保険会社があらかじめ作成した保険約款が保険契約者を拘束するか否かについてが問題となるが、一般的には保険約款には拘束力があるとされている。その根拠については、法規規範説、意思推定説、慣習法説、白地慣習法説等の種々の見解がある。

このように、保険約款に拘束力があるとされる背景には、保険契約の申込者の理解や納得のない場合に保険約款の効力が生じないとすることは、大量かつ定型的取引を要する生命保険契約の実態に合わないとの判断が前提にあるためと考えられる。

しかし、生命保険会社が、技術的な性格を有する保険制度についての専門家であるのに対し、保険契約者は、一般的には保険制度についての専門的な知識を持ち合わせていないのが実情であり、このような状況にあっては、保険契約者は、どのような保険契約を契約するか否かの自由は持ってはいても、契約しようとする保険種類の保険約款の各条項をいちいち承認するか否かの裁量は難しく、結果的には、契約しようとする保険約款の拘束を受けてしまうことになる。

したがって、生命保険会社が自らの利益のみしか考えず一方的に有利な条項を作ることをしないよう、保険約款について国による監督を行い、保険契約者の利益を保護する必要性が生じてくるのである。事実、上記

のような保険契約の特殊性に鑑みて、保険業法上、保険約款について法的規制が実施されている。

ところで、前述の生命保険に関する法律や保険約款が、生命保険会社と保険契約者との間でどのような順位によって適用されるかをみると、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね保険法、民法の順に適用される。

(注) 詳細はテキスト「約款と法律」参照。

(2) 生命保険契約の性質

① 生命保険契約の定義

日本の生命保険契約は保険法によって定義されている。第2条によれば、保険契約は「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付（生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあつては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。）を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料（共済掛金を含む。以下同じ。）を支払うことを約する契約」とされ、その中で生命保険契約は「保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの（傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く）」とされている。

このように、生命保険契約は、「保険事故が人の生死であること」、「その支払い金額は契約で定められた一定の金額であること」に特色がある。

ちなみに、損害保険契約については、保険法第2条で、「保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するもの」とされている。すなわち、損害保険契約では、「実損填補」がその契約の特色となっているわけである。

傷害疾病保険契約については、商法においては明確な規定がなかったが、保険法においては次のように規定された。まず「保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」を「傷害疾病定額保険契約」と位置づけ、生命保険、損害保険から独立させたうえで法規定を置いた（保険法第4章 傷害疾病定額保険）。一方、「保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害（当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。）をてん補することを約するもの」を「傷害疾病損害保険契約」と位置づけつつも、その実損填補性に鑑み、損害保険契約の法規定に従うものとした（保険法第2章 損害保険）。

なお、保険業法第3条では、保険法とは別に、生命保険業、損害保険業を定義している。この中で疾病や傷害に関する「第三分野の保険」については、生命保険事業、損害保険事業のいずれにおいても取扱い可能な保険として規定されており、両事業における取扱いが明確化されている。

（旧）保険業法では、「第三分野の保険」についての明確な定義が置かれていなかったため、両事業の論争の的ともなっていた経緯があり、行政の裁量による棲み分けで対応がなされてきたが、現在では生損両業界がそれぞれの特性を活かしつつ真正面から競合する分野となっている。

② 生命保険契約の主な法的性質

保険法に基づく生命保険契約の法的な性質のうち主なものは次のとおりである。

ア) 有償^{ゆうしょう}契約性

有償契約とは、契約当事者が互いに対価的な意味を有する出捐（しゅつえん）をなす契約である。保険者は保険事故が発生した場

合に、保険金受取人に保険金を支払うことを約束することにより、保険金受取人の経済的生活の不安を除去、軽減するのであり、これに対する報酬として保険契約者は保険者に保険料を支払う。すなわち、生命保険契約は保険者の危険負担と保険契約者の保険料支払いとをそれぞれ対価的な給付と反対給付とする有償契約である。

イ) 双務^{そうむ}契約性

双務契約とは、契約当事者の双方が互いに対価的な意味を有する債務を負担する契約である。保険者は保険事故の発生を条件または期限とする保険金支払債務を負担し、これに対し保険契約者は保険料支払債務を負担している。したがって、生命保険契約は保険金支払債務と保険料支払債務とが対価関係になる双務契約といえる。

ウ) 諾成^{だくせい}契約性

諾成契約とは、契約当事者双方の合意によって成立する契約（目的物の引き渡し等が不要）である。生命保険契約も、契約当事者双方の合意のみによって成立することから諾成契約である。

エ) 不要式契約性

不要式契約とは、契約に際し一定の要式が必要でない契約である。生命保険契約も、保険法上、一定の要式を要するとはしておらず、不要式契約である。もちろん、生命保険契約の締結に当たって、実際上は申込書の提出や保険証券の発行が伴うけれども、これらは大量事務処理の便宜上行うものであり、これをもって生命保険契約が要式契約であるとはいえない。

オ) 射倖^{しゃじやう}契約性

射倖契約とは、契約当事者のなすべき給付義務が契約成立当初から偶然の事情に依拠している契約である。生命保険契約も、保険金

支払義務の発生や保険料支払義務の履行が、保険事故の発生時期の偶然性に左右されることから、射倖契約であるとされている。

力) 善意契約性

生命保険契約は善意（good faith）の契約である。前述したように生命保険が射倖契約の性格を持つ以上、賭博的行為に悪用されたりあるいは道徳的危険を誘発したりするおそれがあるので、通常の契約をはるかにこえる信義・誠実の原則が要求されるわけである。

被保険者が自殺した時や、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時などにおける保険者の免責、さらに告知義務制度などは生命保険契約の善意契約性から認められているのである。

キ) 付合^{ふごう}契約性

付合契約とは、契約当事者の一方があらかじめ定めた契約条項を相手方が包括的に承認することによって成立する。したがって、事実上相手方はその契約条項に従わざるをえない。生命保険契約も、大量の定型的取引を行い、またその技術性、専門性ゆえに、生命保険会社があらかじめ定めた保険約款をもとに契約を締結しているわけであり、付合契約である。

3. 生命保険契約の要素

保険法第2条の生命保険契約に関する定義から、生命保険契約が有効に成立するための要素を抽出してみよう。

(1) 保険者

生命保険契約の当事者として、契約の対象となっている危険を引き受け、契約事故が発生した場合に保険金の支払義務を負う者を保険者とい

う。日本の保険業法においては、生命保険契約の引き受けができる者は、資本金または基金10億円以上の株式会社または相互会社であって、内閣総理大臣の免許を受けたものに限られる（2006年（平成18年）4月施行の保険業法改正によって「少額短期保険業者」制度が創設されたが、これについては後述する）。

（２）保険契約者

生命保険契約の当事者として保険者の相手方となり保険契約を締結し、保険料支払義務を負う者を保険契約者という。保険契約者の資格については別段の制限はなく、個人であると法人であることを問わず、また行為能力者であると否とを問わない。もちろん、制限行為能力者—例えば未成年者—が保険契約者となって生命保険契約を締結する場合には、父母などの法定代理人の同意が必要となる。

（３）被保険者

生命保険契約において、その人の生死などが保険事故とされる者を被保険者という。被保険者の資格については個人であることのほかは別段の制限はない。

しかし、誰を被保険者とするかを定めることは必要である。そして1契約における被保険者は必ずしも1人であることを必要としない。例えば、夫婦、親子、共同事業者等を被保険者として、そのうちの1人が死亡した場合に他の者が保険金受取人となる連生保険も可能である。また、被保険者は必ずしも固定的であることを必要としない。官公庁、会社、労働組合その他の団体が保険契約者となって、一定基準に適合する範囲内の不特定多数人を包括的に一団として被保険者とする生命保険も可能であり、これを団体生命保険という。

(4) 保険金受取人

保険者と保険契約者との間に成立した生命保険契約により、保険事故が発生した場合に、保険金の支払いを受ける者として定められた者を保険金受取人という。保険金受取人の資格については何らの制限はなく、個人であると法人であると、また行為能力者であると否とを問わない。

(5) 保険事故

保険者は相手方または第三者（被保険者）の生死などに関して一定の金額を保険金受取人に対して支払うべきことを約束するのであって、この相手方または第三者の生死などが生命保険における保険事故である。

(6) 保険期間

保険者が保険事故の発生により保険金を支払う責任を負うのは、一定期間内に保険事故が発生した場合においてである。この期間を保険期間という。生存保険においては保険期間満了時の生存を給付事由とするためその始期は実際上問題にならず、また終身保険にあつては保険期間の終期は不定である。

死亡保険や生死混合保険における保険期間の始期については、保険約款において第1回保険料払込みの日または被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日から始まると定めることが多く、また死亡保険や生死混合保険の保険期間の終期は一定の年月を経過した時、または被保険者が一定の年齢に達した時というように定めるのが通例である。

(7) 保険金額

保険期間内に保険事故が発生すると、保険者は一定の金額を支払うべき責任を負うのであり、この金額が保険金額である。保険金額は保険者と保険契約者との合意によって自由に定められ、保険事故が発生した場合、保険者は保険金受取人が保険事故の発生によって実際に損害を被っ

たか否か、またはその額のいかんを問わず、あらかじめ定められた保険金額を支払う義務を負う。この点、実際の損害額に応じて支払われるべき保険金額の割合が定められる損害保険と異なるのである。

(8) 保険料

保険契約の一方の当事者である保険契約者は、保険者が危険を負担していることに対して、保険事故発生の可能性に応じたものとして保険料を支払う。保険料の額は、契約当事者の合意によって定められるが、通常それは保険金額、保険期間および保険料払込期間に応じ、かつ被保険者の年齢（保険事故発生の確率）や性別を考慮に入れて決定される。

4. 生命保険の技術的基礎

(1) 死亡表

国民生命表と経験生命表

死亡表はある集団に属する人間のある期間内の生死を観察し、年齢別年間死亡率を把握したもので、それには一般人口の集団を対象とする国民生命表と生命保険の被保険者のような特定人口集団を対象とする経験生命表がある。

国民生命表は全体のほか、地方、職業、性別等の区分による死亡率を示し、人口問題、高齢者問題等を考える際の基礎資料となる。

経験生命表は生命保険、社会保険等の特定集団の経験に基づいて作成され、単なる年齢別合計死亡率のみでなく、集団での在籍年数をも考慮した死亡率を示す場合がある。この場合、例えば生命保険の被保険者集団にあっては加入時に健康状態等に関する保険会社の危険選択をうけるため、加入後経過年数が短い集団の死亡率は同年齢の合計死亡率より通常は低い結果となる（契約当初の死亡率が低いことを選択

効果といい、この効果は加入後の経過年数が長くなるにつれ小さくなる)。このような点から、経験生命表は以下の3種類に区分される。

ア) 総合表—経過年数に無関係なトータルの年齢別死亡率

イ) 選択表—年齢・経過年数別死亡率（同年齢でも経過年数別に複数の死亡率が存在）

ウ) 終局表—選択効果を除外した年齢別死亡率（加入後一定年数経過後に選択効果が消滅するとの前提に立ち、一定年数経過後の加入者のみを対象とした死亡率）

経験生命表の集団の細分は、性、職業、地域別等がある。生命保険の場合、この他に保険種類別、選択方法別といった区分が重要である。

経験生命表は、保険料率、解約返戻金率等、契約者価格の設定には同一年齢同一死亡率の総合表、終局表が活用され、収支予測、経営政策策定の場面では選択表が活用される場合がある。

（２）危険の選択

① 危険選択の必要性と意義

危険選択は生命保険事業を遂行するうえで最も重要な専門的、技術的な職務の一つである。

「保険の対象となる危険の種類」（４頁参照）の中で述べたように、保険が成り立つためには保険者が引き受ける危険の程度が数量化でき、合理的尺度で測定できなければならない。言い換えれば、同一保険料で同一の保障を受ける集団は同質の危険度を有するものの集団でなければならない。これを危険均一性の原則という。例えば死亡保険において、より高い死亡率特性を有する者が標準死亡率を示す集団に混入し、その者に対しても同一保障・同一保険料が適用された場合、集団の利益を損ねることになる。

一般に、標準以上に危険度の高い人は保険加入希望が強く、また、より高額な保険を選ぶ傾向がある。このような現象を逆選択といい、これを避けるために合理的な危険選択が必要となる。

② 危険選択の手段

危険選択は普通、生命保険募集人、診査医、生命保険面接士、査定者および決定者によって行われる。

最初の選択は生命保険募集人が行うのがほとんどであるが、これは生命保険の主たる販売経路が対面であることによる。したがって、生命保険募集人が保険を正しく理解して危険選択を行うことが生命保険の普及、事業の健全経営に欠かせない。危険選択はこれで終わらないが、入口である生命保険募集人の第1次選択が特に重要であることが経験的に知られている。

契約の申込みの際、申込者または被保険者は保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めたものについて事実の告知をしなければならない。これを告知義務といい、重大な告知を怠った場合、保険者は契約を解除できる。告知の徴求は保険会社が危険選択を行うための重要な手段の一つである。

危険選択に関しては、健康、身体的な面が最も大きいウエイトを占めており、診査にあたる医師を一般的に診査医という。また、医師ではないが、ある程度の医学的知識と保険に関する知識を兼ね備え、一定の資格を有する生命保険面接士が被保険者に面接する制度もある。診査医、生命保険面接士による報告も保険者の契約査定、加入決定の際の参考資料となり、危険選択の手段となる。この他、告知書のみで危険選択を行う場合もある。

保険金が多い契約の申込みについては保険会社専属の医師が診査

にあたる場合があり、保険金額によってはX線撮影、心電図検査も実施される。

この他、契約確認という選択手段がある。保険申込者の収入、資産状態および道徳的な面や、契約継続の可能性、投機的危険がないことを確認し、申込書記載以外の内容の補足をする。

以上の過程を経て、最終的に保険会社の査定者、決定者が契約締結の可否を判断する。

③ 危険の評価

保険経営に求められる2大原則は健全性と公平性であり、公平性の原点は危険の評価にある。危険の質を同じにできるだけ危険を細かく分け、その危険度を把握することが公平性につながる。したがって、危険区分を細分化し、より正確な危険度を把握することが危険の評価となる。

同じ質とはいえ、全く同質の危険は存在せず、それを追求めれば最終的には1人1危険区分にいきつく。日本の生命保険では性別・年齢別の危険区分を前提に、さらに、危険度が標準的な標準危険、危険度の高い高危険に区分するのが一般的で、これに沿って危険選択を行う。

標準的危険をさらに危険度の低い低危険と標準危険にわけられる場合がある。死亡危険を低危険、標準危険、高危険の3区分にした例としては、体格（身長・体重比率）、喫煙の有無の反映がある。身長・体重のバランスの良い者、喫煙習慣のない者については低危険として保険料率に反映し、同性、同年齢の標準危険集団と差を設けている。

高危険との判定は、これを排除することを必ずしも意味しない。保険加入範囲はできるだけ拡大すべきとの基本的な考え方に立ち、高危険でも的確な危険度が把握できれば保険加入を認めている。高危険に

関しては、種々の方法で危険度を把握して保険加入の道をひらいている。当然、標準危険に比べ、危険度を反映した高い保険料率となる。これを特別条件付保険契約と一般的にいい、標準危険との保険料差を特別保険料という場合がある（高危険には、健康・身体上の危険のみでなく、職業危険等も含む）。

高危険にも種々あり、保険期間全体を通じて危険度が高い場合もあれば、危険度は保険加入後年数を経るにつれ小さくなり、一定期間後には標準体と変わらなくなる場合（逓減性危険）もある。前者の場合には保険期間全体にわたり、後者の場合は一定期間のみ特別保険料を徴収する。また、標準体と同率の保険料を徴収し、保険金を削減して払う対応もある。

公平性の観点からは、危険の区分はできるだけ細かいことが望ましい。しかし、区分が細かいほど事務が煩雑となり、事業費がかさみ、非効率経営に陥る。効率性、公平性がうまくバランスした危険区分が経営上必要となる。

例えば、アメリカでの危険区分の細かさは、低危険を区分し保険料率を下げることにより、契約獲得上、優位に立ち、また、良質契約の獲得による経営の健全性を確保するという競争上の理由による点が大きいと思われる一方、国民性に基づくフェア・アンフェアに対する顧客の厳しい見方を前提にしているとも思われる。

(3) 保険料

危険の評価により危険度の測定が可能となると、次の段階ではそれを具体的に保険料として反映することになる。

死亡保険の危険度の測定結果は前述の死亡表であり、それを利用して保険料を計算する。

① 自然保険料と平準保険料

ここで簡単な二つの死亡表（表 1）を基にして具体的な保険料計算例を示す。

表 1. 仮定死亡表

死亡表 A				死亡表 B			
年 齢	年始生存者数	死亡者数	死亡率	年 齢	年始生存者数	死亡者数	死亡率
歳	名	名		歳	名	名	
30	100	3	0.0300	30	100	7	0.0700
31	97	4	0.0412	31	93	5	0.0538
32	93	5	0.0538	32	88	4	0.0455
33	88	6	0.0682	33	84	3	0.0357
34	82	7	0.0854	34	81	2	0.0247

保険期間 1 年の死亡保険（死亡時にのみ定額保険金を支払う）の保険料は以下のように計算される。なお，ここでは，予定利率，予定事業費率の影響は考えないものとする。

- ・当該年齢の年始生存者から一律に保険料 P を預かり，死亡者に保険金額 S を支払うとした場合，以下の関係式が成立する。

$$\text{年始生存者数} \times P = \text{死亡者数} \times S$$

$$\Rightarrow P = (\text{死亡者数} / \text{年始生存者数}) \times S = \text{死亡率} \times S$$

保険期間 1 年の死亡保険の保険料は死亡率に保険金額を乗じたものとなり，この保険料を自然保険料と呼ぶ。

保険を長期に付する場合，自然保険料で対応すると同一保険金額のもとでも毎年，保険料が変化するという煩わしさがある。特に，死亡表 A のケースのように毎年，保険料が上昇するのは顧客のニーズにあわない。その結果，全保険期間を通じ，同保険金額には同保険料の適用という要請からでてくるのが平準保険料であり，以下のように計算される。

- ・毎年、年始生存者から一律に保険料Pを預かり、死亡者に保険金額Sを支払うとした場合、以下の関係式が成立する。

$$\text{毎年始生存者数累計} \times P = \text{毎年の死亡者数累計} \times S$$

$$\Rightarrow P = (\text{死亡者数累計} / \text{年始生存者数累計}) \times S$$

保険期間5年、年齢30歳、死亡保険金Sの場合、死亡表A、死亡表Bに対応する平準保険料は以下のように計算される。

- ・死亡表Aの場合

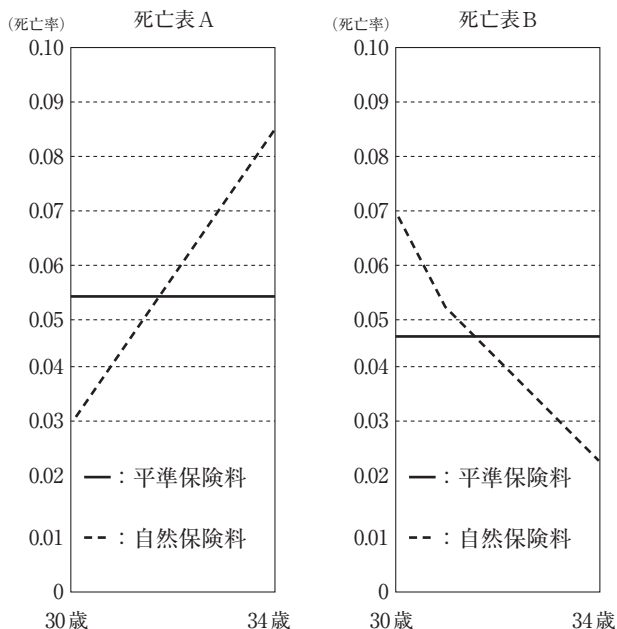
$$P = (3 + 4 + 5 + 6 + 7) / (100 + 97 + 93 + 88 + 82) \times S = 0.0543 \times S$$

- ・死亡表Bの場合

$$P = (7 + 5 + 4 + 3 + 2) / (100 + 93 + 88 + 84 + 81) \times S = 0.0471 \times S$$

平準保険料と自然保険料の関係を図示すると図1のようになる。

図1. 自然保険料と平準保険料



保険金支払いと平準保険料収入が予定どおり推移するとした場合、

- ・死亡表Aの場合：当初は保険料収入が保険金支払いを超過し、会社に余りが生じ、それを会社が留保し、将来の保険金支払いに充当し、最終的には過不足0となる。
- ・死亡表Bの場合：当初は保険料収入が保険金支払いに不足し、会社に損が生じる。以降、保険料収入が保険金支払いを超過し、最終的には過不足0となる。

という結果になる。

死亡表A、死亡表Bの場合ともに、最終結果は同じではあるが、死亡表Bの場合は途中では欠損を生じる。この場合、保険者は借金して対応すれば最終的には帳尻は合う。しかし、予定どおり推移するという保証もなく、現実的ではない。すなわち、死亡表Bのように経過とともに危険度が減少するような場合、平準保険料方式は採用できないといえる。現実の死亡危険は死亡表Aのように通常、経過とともに危険度が増加するため、死亡保険における平準保険料方式の採用は効果的であり、実務ではほとんどの場合、平準保険料方式によっている。

以上は保険料計算の最も原始的な例である。現実には、収入保険料は運用されて利息を生むため、利率の考慮も必要であり、保険給付以外に保険事業を運営する費用も考慮して保険料を確定する。

平準保険料方式は、前述のように保険料の余りから生じる積立金形成を通じ、金融機関として幅広い活動が発揮できる機能を生命保険事業に与えている。

② 保険料の区分と計算基礎率

具体的な保険料を算出する場合、前述のように危険度と保険金が基礎となるが、その他に次の要素を反映しなければならない。

ア) 利率

イ) 事業費

利率の導入は資産の運用成果の一部を前もって保険料に組み込むという考え方によるものである。生命保険は一般的には長期であり、利率を導入すると保険料軽減効果が生じる。

また事業費については、生命保険は契約者のニーズを保険者側が的確に捉えることで契約が成立するという特性（窓口販売に対し訪問販売が主力）や契約内容、技術的側面の複雑さから生じる事務の煩雑さにより費用がかさむが、それは一般金融機関、例えば銀行のように資産運用成果から補填するレベルではないため、事業の運営上その費用を保険料に織り込む必要がある。事業費は新契約費と維持費に大別される。前者は加入勧奨費用を含む新規に保険契約を締結する際に要する費用で、後者は新契約費以外の費用である。維持費の中で保険料を徴収するための費用を区分する場合がある。事業費は保険金比例、保険料比例として定率設定して保険料に織り込むのが一般的である。

以上のように、保険事故の危険度、利率、事業費を定めて契約者に提示する保険料を決定する。この保険料を営業保険料という（保険料表として示すために表定保険料ともいう）。

営業保険料の内訳を2区分し、純保険料、付加保険料という場合がある。この場合、純保険料は保険給付に充てる保険料、付加保険料は事業費部分の保険料を示す。

保険料計算に盛り込む危険度、利率、事業費率を予定危険率（予定死亡率・災害発生率等）、予定利率、予定事業費率（3つを総称して

予定基礎率)という。生命保険は一般的に保険期間が長期であるため、有配当保険では、その間の環境変動（経済、危険変動等）に耐えうように予定基礎率は保守的（危険率、事業費率は高く、利率は低く）に設定している。そのため、多くの場合は予定内に収まり剰余を生じる。これを後日、返還して保険料の精算をする。この返還額を配当金と称している。一方、無配当保険では予定基礎率を実際の数値に近づけて算出しており、その結果、保険料は有配当保険よりも低い水準となる。

（４）責任準備金

保険料設定後の次の段階として責任準備金の評価が生命保険の技術的な面では重要な課題となる。

保険期間が長く危険度が期間の前半より後半に偏る場合（例えば死亡保険金支払、満期生存保険金支払）、前述のように平準保険料方式をとると当初は保険料収入が保険給付より大きく、決算時には余りが生じるが、この余りは全てが保険者の儲けではなく、この内、将来の保険給付に備えて会社に留保しておくべきものがある。この留保すべき部分を責任準備金という。言い換えれば、将来の保険給付には将来の保険料収入と責任準備金を充てるため、責任準備金は将来の保険金給付額と将来の保険料収入額の差額であるともいえる。自然保険料方式の場合は責任準備金はほとんど生じない。

① 責任準備金の計算例

前述の表１の死亡表Ａによる保険期間５年のケースを例にとれば、１年後（年末）の責任準備金は次のとおり表せる（保険金額をＳ、平準保険料をＰ、保険期間を５年とする。予定利率、予定事業費率については考えない）。

責任準備金 = 将来の保険金給付額 - 将来の保険料収入額

$$= (4 + 5 + 6 + 7) S - (97 + 93 + 88 + 82) P$$

ここで5年間の保険金支払額と収入保険料が等しいことにより、

$$(3 + 4 + 5 + 6 + 7) S = (100 + 97 + 93 + 88 + 82) P \text{ となる。}$$

これを変形すると、

$$(4 + 5 + 6 + 7) S - (97 + 93 + 88 + 82) P = 100 P - 3 S \text{ となる。}$$

だから、

$$\text{責任準備金} = 100 P - 3 S$$

$$= \text{過去の保険料収入額} - \text{過去の保険金給付額}$$

つまり、この関係式は、保険料設定の予定どおりに推移すれば、責任準備金は「将来の保険金給付額 - 将来の保険料収入額」または「過去の保険料収入額 - 過去の保険金給付額」と表され、両者は一致することを意味している。前者を将来法、後者を過去法による責任準備金評価という。他の経過年度についても同様である。

現実の計算は予定利率、予定事業費の要素が加味され、複雑になるが前述の将来法、過去法の関係は変わらない。

② 責任準備金の一般概念

前述の議論は保険料設定の予定率どおり状況が推移するとの前提によるもので、最も原始的な責任準備金の概念である。現実には全ての契約が予定どおり推移するわけもなく、これを踏まえて準備する評価性の積立金が責任準備金であるため、将来の動向を見据えて評価しなければならない。したがって、前述の過去法という考え方は現実の評価の面では意味がない。

以上から、責任準備金の現実的定義は次のとおりである。

将来保険給付支払現価－将来保険料収入現価

(注) 割引率を用いて、将来において生ずる価値を現在の価値に直したものを現価という。

責任準備金には、契約集団評価と個々契約評価の二面がある。

責任準備金の第一義は決算時の負債評価であり、契約集団としての積立金評価額をいう。

一方、個々契約の積立金評価額も責任準備金という。これは解約返戻金計算の基礎となり、また配当金計算の基準として用いるため、第一義よりポピュラーであるが、責任準備金の概念としては第二義である。

日本では、第二義の責任準備金の個々契約の合計を決算時評価の責任準備金とするのが普通であったが、近年の契約については、両者の分離が進んでいる。

決算時の責任準備金は保有契約全体を評価するものであり、将来を見据えて保守的に評価されねばならない。アメリカでは保険料基礎率とは別に、保守的な基礎率で責任準備金を積み立てること（これを標準責任準備金制度という）を定めており、責任準備金の本来の意義を反映しているといえる。日本でも1996年度（平成8年度）に施行された改正保険業法により、このような標準責任準備金制度が導入された。この制度の下では、決算時の責任準備金計算に用いる予定利率、予定死亡率が定められているが、無配当保険や準有配当保険（後述）では、それより高い予定利率、低い予定死亡率を用いて保険料が計算されているケースが多い（この場合、第二義の責任準備金は保険料基礎率を用いて計算され、第一義と第二義の責任準備金の額は異なることになる）。

(5) 契約者配当

① 剰余金

保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする負債を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、定款に記載するよう定めている（保険業法第23条）が、剰余金の20%以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない（保険業法第55条の2および保険業法施行規則第30条の6）（従来は剰余金の80%以上を社員に分配する旨定めていたが、2002年度（平成14年度）より上記のとおり20%以上に引き下げられ、社員配当ルールが弾力化された）。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない非社員契約（無配当保険）の取扱いが可能である（保険業法第63条および保険業法施行規則第33条）。

② 剰余の分類

剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、公平性が最も重要なポイントとなる。公平性については保険料の設定の際に充分配慮しているが、配当を差し引いたものが実質負担保険料であるため、配当の分配は公平性実現のラストチャンスであり、慎重な配慮が必要となる。

そのためには、剰余の中身を明確に区分し、その貢献度に応じて分配する必要がある。したがって、剰余の中身はできるだけ細分することが望ましい。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。

③ 利源と利源分析

剰余を各利源に区分することを利源分析という。別の言い方をすると、保険料、年始責任準備金、利息配当金等を各利源に分解したものを収入項目とし、保険給付、事業費、年末責任準備金等を各利源に分解したものを支出項目とし、利源毎の収支残が利源別剰余となる。必要に応じて各利源別剰余を保険種類に区分する。前述の3利源を死差益、利差益、費差益という。

ア) 死差益（危険差益）

死差益とは危険度の差から生じる益の総称であり、危険差益ともいう。伝統的に死亡率の差により生じる益のウエイトが大きいため死差益という。別の言い方をすると、保険料、年始責任準備金のうちの当年度の保険給付に充てうると予定される額から実際に生じた保険給付を差し引いた額が死差益である。障害給付、入院給付についても、死亡給付ではないがこの中に含まれる。死亡保険では予定の死亡率より実際が低い場合は死差益が生じるが、年金など生存保険の場合は損が生じる。死亡率の低下は生存保険では危険度の増加となるからである。

イ) 利差益

利差益とは資産運用利回りが予定利率を上回ることにより、生じる益である。資産運用成果には、利息配当金収入のようなインカムゲインと資産売却益のようなキャピタルゲインとがあり、インカムゲインによる益とキャピタルゲインによる益を区分する場合がある（区分する場合、前者を狭義の利差益、後者を価格変動益と称する）。近年は資産運用が多様化し、インカムとキャピタルの益の区分が難しくなっている。

ウ) 費差益

費差益とは予定事業費と実際との差から生じる益である。すなわち収入保険料から得られる付加保険料と事業費を主とする実際支出事業費用の差となる。

エ) その他の益

剰余のほとんどは上記3利源によるが、それ以外に解約益がある。これは、解約した契約には解約返戻金を払うが、一方、その契約には責任準備金の積立が不要となるため積み立ててきた責任準備金が余る。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より小さく設定されているのが一般的であるため、その差額が解約益となる。

④ 契約者配当金の支払

剰余の契約者への分配を配当という。前述のように予定と実際の差が剰余であり、生命保険会社における配当は保険料の精算という意味合いが強く、保険料を投資することによる利潤というイメージではないので一般会社における株主配当とは性格が異なる。

配当金の分配時期は、毎年あるいは5年などの一定期間ごと、ならびに契約消滅時などであり、前者を通常配当、後者を消滅時特別配当と一般的に呼んでいる。

ア) 通常配当

一定期間ごとに支払うもので、利源に応じて、死差配当、利差配当、費差配当に分けている。

- ・死差配当：死差益を男女・到達年齢等に区分したものを財源とし、例えば、予定と実際の死亡率差に危険保険金（保険金－責任準備金）を反映したものを個々契約の配当としている。

- ・利差配当：個々の契約の予定利率，経過年数を考慮して率を定め，それに責任準備金を反映して計算する。

- ・費差配当：予定と実際の差を保険金換算して計算する。

なお，1996年度（平成8年度）より，死差益および費差益を無配当化し，利差配当のみを5年ごとに支払う5年ごと利差配当付保険（準有配当保険）が発売されている。

イ）消滅時特別配当

個々の契約の正しい精算額はその契約が消滅しないと確定しないため，最終精算として位置づけられる配当である。契約存続時はある程度安定した配当を保守的に定めて支払うため，その差額を消滅時に支払うという考え方による。契約内容に応じて利源が異なるが，過去の通常配当で還元しきれなかった部分やキャピタルゲインを主財源としている。

ウ）配当金支払方法

具体的な保険契約者への支払方法については，積立が一般的であるが保険金増額等他の方法もある。

なお，毎年の決算では一定のポイントを付与し，5年毎に累積ポイントに応じて配当を支払う，「ポイント配当」制度を採用する会社もある。

5. 生命保険の基本型と現在の主な商品

生命保険は家庭経済上の不可避の問題に対して、適切な解決策を与えるものであるが、生命保険には多くの種類があり、それぞれ異なる機能を持っている。ここでは、種類と機能について解説する。

(1) 生命保険商品の基本型

現在、生命保険会社から発売されている生命保険は、商品としては多種多様で数多くあるように見えるが、適切な方法で分類すると分かり易く整理することができる。その中で最も基本的な分け方は、どんな場合に保険金が支払われるかという保険事故による分類である。この分け方によれば、人の死亡を条件として保険金を支払う死亡保険、人の生存を条件として保険金を支払う生存保険、およびその両者を組み合わせた生死混合保険が3つの基本種類となる。多くの複雑な保険商品もこれらの基本型に各種の保障特約を付加して、顧客のさまざまなニーズに応えるように作られているのである。

① 死亡保険

死亡保険は被保険者が死亡した時のみ保険金が支払われるもので、死亡によって生ずる経済的負担を保障しようとするものである。死亡保険には、定期保険、終身保険、およびその両者を組み合わせた定期付終身保険がある。

② 生存保険

生存保険は死亡保険とは逆に、被保険者が一定期間経過後、すなわち満期まで生存していた場合に限って、保険金が支払われる保険である。

したがって、保険期間の途中で被保険者が死亡した場合は保険金は支払われず、払い込んだ保険料は掛け捨てになる。これが純粋の形の

生存保険であるが、実際にはこのままの形で単独の商品として販売されることはほとんどない。生存保険の特殊な形態としての終身年金保険があるほか、他の保険種類と組み合わせて提供されている。

③ 生死混合保険

生死混合保険は、死亡保険と生存保険とを組み合わせたもの、すなわち、被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合には生存保険金（満期保険金）が支払われる保険である。

この保険の典型的なものは、養老保険である。また、養老保険と定期保険を組み合わせることにより、死亡保障部分を大きくした定期付養老保険も、死亡保険と生存保険の組み合わせの割合こそ違い、広い意味での生死混合保険といえることができる。

(2) 現在の主な生命保険商品・制度

次に、現実に販売されている保険商品・制度の種類と特質について述べることにする。

① 個人保険（主契約）

個人保険とは個人を契約の対象とするもので、個別保険とか普通保険とも呼ばれている。なお、ここでは個人保険のうち、基本となる契約である主契約を取り上げる。

ア) 定期保険

この保険は5年、10年といった一定保険期間内に被保険者が死亡した場合に限って死亡保険金が支払われる保険である。

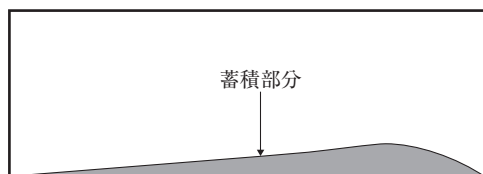
一定の期間内に死亡する一部の人に支払うのに必要な保険料を払い込めばよいので、低廉な保険料で高額の死亡保障が得られるところに特色がある。したがって、死亡後の家族の生活保障を目的とす

る人にとっては最も適した保険である。

普通この保険には蓄積部分（将来の保険金・給付金の支払いに備えて積み立てられる部分）がほとんどなく、契約期間終了時には契約が消滅し、保険金の支払いはないので、老後の保障などの貯蓄的な目的には適さない（図2）。

契約期間が満了になった場合には契約を更新し、さらに一定期間の定期保険に加入することもできるが、その場合には年齢が高くなるので、保険料は高くなる。

図2. 定期保険

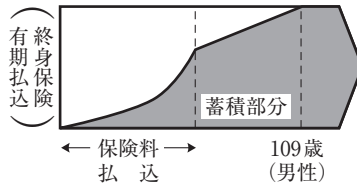


また、この定期保険に保険期間の途中での生存給付を付加したものとして生存給付金付定期保険がある。これは死亡した時の保障と併せ、資金準備、貯蓄などを目的としたもので、主に若者向けの保険として販売されている。

イ) 終身保険

この保険は契約の終期がなく、被保険者の生涯にわたって保障が続くものである。したがって、死亡する前に契約が消滅することはない。しかも、保険料は契約期間を通じて、一定額を払い込めばよい。また終身保険は蓄積部分が年々増加していく仕組みとなっており、同じく死亡のみを保障する保険でありながら、定期保険とは著しく異なっている（図3）。

図3. 終身保険



(注) 終身保険の保険料算出は、男性の場合109歳満期の養老保険を基礎としている。

このように、終身保険は死亡保障という保障機能に加えてその死亡保障の支払に備えるための蓄積部分をもっている（貯蓄機能がある）ため、老後の生活資金、契約期間中の緊急資金を準備することも可能である。

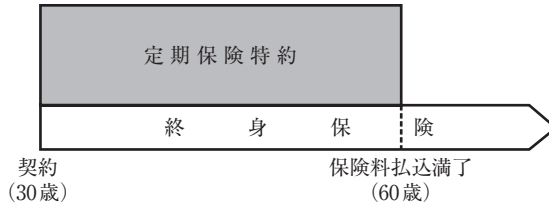
なお、終身保険は、保険料の払込期間によって、被保険者が生涯保険料を払い込む終身払込終身保険、一定期間に限定して払い込む有期払込終身保険、契約時に保険料を一括して全額払い込む一時払終身保険の3つに分類することができる。一般に退職後の収入が低下する人には、60～65歳に払い込みを完了する有期払込終身保険が多く利用されている。

ウ) 定期保険特約付終身保険

この保険は終身保険に定期保険特約を組み合わせることで、定期保険特約のセットされた保険期間の死亡保障部分を大きくした保険である。通常、定期保険特約部分の保険期間は、10年間程度のものとし、定期保険特約部分を更新することにより、ライフ・サイクルに合わせて大きな保障を継続することができるタイプ（更新型）とするものが多い。

図4. 定期保険特約付終身保険

(例) 30歳契約, 30年払込の終身保険に全期型定期保険特約を付加した場合



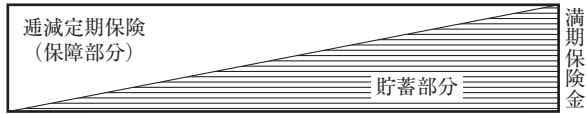
これは終身保険の持つ生涯保障機能と貯蓄機能に、定期保険特約の持つ一定期間の死亡保障機能を組み合わせ、家族の生活保障機能をより高めたもので、一生涯の保障に加え、家族に対する責任の重い時期の重点保障を提供するものである。

工) 養老保険

養老保険は前にも述べた生死混合保険の典型的なものであり、保険期間と保険金額が同一の死亡保険と生存保険を組み合わせた保険である。その実質的内容は貯蓄部分が年々増加していき、満期時には満期保険金と同額になるので、通増する貯蓄と通減定期保険の組み合わせされた保険といえる(図5)。したがって、死亡、満期いずれの場合においても同額の保険金が支払われるだけでなく、保険期間途中で解約返戻金相当額を利用することもできるのである。このように、死亡保障と貯蓄の両機能を併せ持つものであるから、家族保障と老後保障に限らず、結婚資金、教育資金、住宅資金などの確保のために役立つものである。

この養老保険は、名称から老後生活資金の準備のためのみの保険と解釈されやすいが、養老保険は元来 Endowment Insurance、つまり基本財産保険といわれるものであって、死亡しても生きていても生活上欠くことのできない資金を確実に準備する目的で広く利用

図5. 養 老 保 険



できるものである。

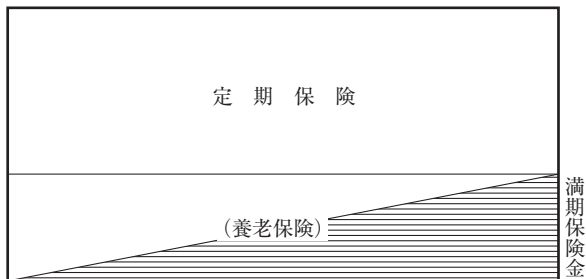
また、貯蓄手段としても活用できる一時払養老保険があるが、これも基本的には養老保険であるから、当然契約当初から満期保険金と同額の死亡保障がある。

オ) 定期保険特約付養老保険

この保険は養老保険に定期保険(特約)を組み合わせることによって、死亡保障部分を大きくした保険である。被保険者が定期保険(特約)のセットされた保険期間内に死亡した場合、満期保険金の5倍、10倍、15倍といった高額の死亡保険金が支払われる。

ライフ・サイクルに応じた満期保険金と死亡保険金の組み合わせが可能であり、高額死亡保障を必要とする世代向けの商品の1つとなっている。

図6. 定期保険特約付養老保険



カ) こども保険

子どもの教育・結婚などの資金準備を目的とするもので、子どもを被保険者とし、その扶養者（普通は両親のうち1人）を契約者として契約する保険である。その仕組みは通常、子どもを被保険者とする生存保険と扶養者を被保険者とする定期保険を組み合わせた特殊な連生保険である。満期時や子どもの学齢期に保険金、祝金などが受け取れ、扶養者が契約期間の途中で死亡した時には保険料が免除される型が基本型であるが、最近では扶養者が死亡した時に、遺族保障（年金など）が支払われる種類など、給付の種類・型等はさまざまである。

キ) 貯蓄保険

貯蓄保険は3年、5年、10年といった比較的短い期間での貯蓄を目的としたもので、結婚や独立資金、事業資金、老後生活資金などの準備に利用されるものである。

一般的な形は、満期時に被保険者が生存している場合に満期保険金が支払われる生存保険に、不慮の事故または所定の感染症^(注)による死亡を保障する災害死亡保険を組み合わせたものである。普通の死亡の際には、それまでの払込み保険料相当額の死亡給付金が支払われるものが多い。

(注)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1類～3類感染症に基づいて規定する例が多い。

ク) 個人年金保険

この保険の仕組みは生存保険の満期保険金を年金払いとしたもので、高齢化社会が進む現在、安定した老後生活をおくるための資金準備手段として活用されている。

また、年金開始前（保険料払込期間中）に被保険者が死亡した場合には、通常、払込まれた保険料相当額の死亡給付金を受け取ることができる。

年金の種類には、被保険者が死亡するまで毎年、年金を支払う終身年金、所定期間内に被保険者が生存している場合に限り年金を支払う有期年金、所定期間内は生死に関係なく年金を支払い、期間経過後は生存している限り年金を支払う保証期間付終身年金、所定の期間に限り生死に関係なく年金を支払う確定年金などがある。

また、夫婦2人を被保険者とし、夫婦いずれかが生存している限り年金を支払う連生年金がある。

ケ）健康・介護・福祉ニーズに対応した保険

健康、介護、福祉面など、生きていくうえでの様々な経済的不安に対して保障を提供する商品が開発されている。代表的なものはつぎのとおりである。

i）介護保障保険（特約）

高齢者を中心に介護を必要とする状態になった場合に、介護費用にかかわる経済的負担を軽減することを狙いとした商品である。単体としての商品もあれば、特約タイプの商品もあり、その他、終身保険の保険料払込終了後死亡保障に代えて介護保障の選択ができるもの等もある。

ii）生前給付型保険

重度の疾病にかかったり、死期が迫っている場合に、被保険者の生存中に死亡保険金を支払うことによって闘病生活にかかわる経済的負担を軽減することを狙いとした商品である。がん、心筋梗塞、脳卒中（いわゆる三大疾病）などの特定重度疾病に罹患した場合に

死亡保険金相当額を支払う「重病給付タイプ」や、すべての傷病を対象とし余命が6カ月以内と診断された場合に死亡保険金から6カ月分の利息と未払保険料を差し引いた額を支払う「末期症給付タイプ」等が発売されている。この生前給付型の保険は1992年（平成4年）より各社とも順次発売を開始している。

iii) 医療保険

医療保険は、病気や災害による入院や手術にかかる経済的負担を軽減したり、休業による所得の減少を緩和することを狙いとした商品である。一般的な入院や手術を保障するものに加え、特定疾病時の給付を厚くするものや、1入院の支払上限日数を短期化して保険料を抑えたものなどがある。なお、解約返戻金をなくすことで保険料を抑えたものなども発売されている。健康保険法等の改正による医療費の自己負担額増加や高度な医療技術を用いた先進医療の進展等に伴い、医療保障へのニーズは一段と高まっている。

iv) がん保険

がんによる入院・手術および死亡・高度障害などに対する保障に対象を特化した保険である。がんの診断確定を受け、治療を開始したとき診断給付金が支払われるものや、退院後の療養に備えて給付金が支払われるもの、がんの治療を目的として通院したとき、通院給付金が支払われるものもある。

v) その他

健康保険適用対象外の歯科医療費を保障する「歯科保険」なども発売されている。

コ) 勤労者財産形成貯蓄積立保険

勤労者の財産づくりを促進する等の目的のため、生命保険の特色

を生かした貯蓄機能を持つとともに、保険期間の途中で災害で死亡した場合には、それまで払い込まれた保険料の5倍に相当する金額を保険金として支払う。

受取時には支払保険料累計額との差額に20%の源泉分離課税が適用される。

サ) 財形年金積立保険，財形住宅貯蓄積立保険

高齢化社会が進む中で、老後に対する自助努力促進制度として、「財形年金貯蓄制度」が1982年（昭和57年）に創設された。これは各金融商品横断的な制度だが、生命保険の財形年金を他の金融機関の商品と比べた場合、生きている限り年金を受け取れる「終身年金」を選択できることが生命保険商品の特色となっている。また1988年（昭和63年）には、勤労者の持家取得を促進する観点から、新たに「財形住宅貯蓄制度」が創設された。

財形年金積立保険および財形住宅貯蓄積立保険についても、勤労者財産形成貯蓄積立保険と同様に、保険期間の途中で災害で死亡した場合には、それまで払い込まれた保険料の5倍に相当する金額が保険金として支払われる。

両者に対する税制上の特典は、財形年金の場合払込元本385万円まで、財形住宅の場合払込元本550万円まで（両者を併せて行う場合は合計で550万円まで）利子や配当金が非課税となり、年金受取もしくは資金の引き出し時においても一定の要件の下で非課税となる。

シ) 変額保険

変額保険は、この保険にかかわる資産の運用実績をもとに保険金額が変動し、一定の給付が保証され資産運用に際しても安全性が重視される定額保険の資産とは明確に区別して資産の運用および経理

を行う必要がある。そこで、変額保険については、定額保険に関する勘定（一般勘定）とは別の勘定、すなわち特別勘定を設けて資産を運用している。

変額保険には、終身保険タイプの変額保険（終身型）と養老保険タイプの変額保険（有期型）のほか、個人年金保険タイプの変額個人年金保険がある。

i) 変額保険（終身型）

このタイプは、一生涯の保障であり、死亡・高度障害保険金は特別勘定で管理されている資産の運用実績に基づき、毎月保険金額が増減する仕組みになっている。ただし、死亡・高度障害保険金については、契約時に定めた保険金額（以下、基本保険金額）が保証される。

ii) 変額保険（有期型）

このタイプは、満期までの保障があり、また、満期まで生存したときには満期保険金が支払われる。死亡・高度障害保険金は、特別勘定資産の運用実績に基づき、毎月保険金額が変動するが、基本保険金額が保証されるのは「終身型」と同様である。

なお、満期保険金額は、保険期間満了時における特別勘定資産の運用実績に基づいて計算された積立金額であり、運用の実績によっては、基本保険金額を上回ることもちろん、下回ることもある。

iii) 変額個人年金保険

このタイプは、特別勘定資産の運用実績により受け取る年金額が変動する個人年金保険である。基本年金額が保証されるタイプや、特別勘定資産の運用ファンドを選択できるタイプなど、商品によって仕組みは異なっている。

〈参考〉

特定保険契約としての「外貨建生命保険」について

この商品は、外貨（米ドルやユーロ、豪ドルなど）で保険料を払い込み、外貨で保険金や解約返戻金を受け取る仕組みで、受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、場合によっては日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を下回る可能性もある。この為替リスクは契約者または受取人に帰属する。

また、外貨と円の換算の際には為替手数料がかかることを含め、この商品の仕組み（為替変動によって将来受け取る保険金などの額がどのように変動するのか等）について、生命保険会社は書面等を用いて説明しなければならない。

現在、外貨建ての商品には、終身保険、養老保険、個人年金保険、変額個人年金保険などがあり、一時払い商品としてその貯蓄性を前面に出すものも多い。通常、運用対象が外国証券等になるため、利回りが現状の低金利の国内運用より相対的に高くなることから、予定利率を高く設定した比較的安い保険料で通貨分散を図りつつ有利な運用ができる商品ともいえるが、保険商品であるがゆえに為替変動等に対する流動性は他の外貨商品（預金や投資信託等）に比べて低くなる。

（注）保険料や保険金に対する税制は円ベースで一般の生命保険契約と同様に適用することができる。円で保険料を支払い、円で保険金の受取りができる特約を付加することができる商品もある。

変額保険をはじめ、このように金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動により損失が発生する可能性（リスク）のある保険契約（投資性の強い商品）を、保険業法では特定保険契約として、金融商品取引法の準用とともに適合性の原則に基づく勧誘の徹底等、募集上の規制を図っている。

特に外貨建生命保険では、利回りの有利性を「積立金等に適用される利率」で表示する場合、手数料を含む支払保険料に対する運用利回りとお客さまが誤認するおそれもあるため注意が必要である。また、投資信託等の投資性商品との比較を含め、お客さまの属性やニーズに応じた適切な情報提供に基づく販売・推奨等が求められる。

（注）特定保険契約には、変額保険、変額個人年金保険、市場金利連動型商品（MVA等）、外貨建商品があり、保険業法で規定する「意向把握義務」「情報提供義務」の募集の基本ルールの遵守とともに、金融サービス提供法や消費者契約法、金融商品取引法の規制を受けることに留意が必要である（159頁参照）。

（注）「金融サービス提供法」は、2023年（令和5年）11月29日公布の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、2024年（令和6年）2月より正式名称が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となっている。

※適合性の原則：顧客の知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らして不適当な勧誘をしないこと。

② 個人保険（各種特約）

特約は主契約たる生命保険契約に付加して締結される特別の保障条項であって、単独の保険契約ではない。契約者の多種多様なニーズを充足するために主契約を補充するものとして様々な種類があるが、以下主なものについて述べる。

ア) 定期保険特約

この特約は、被保険者が死亡したとき、または高度障害になったとき、所定の保険金が支払われるものである（近年では、保険金の支払いに代えて、ある特定の期間中年金が支払われるタイプの特約も発売されている）。

前述のように養老保険や終身保険に付加することにより、働き盛りの期間を重点的に厚く保障する場合などに利用されている。

また、貯蓄ニーズや中高年齢層のライフ・サイクルに応じた保障ニーズに応えるために、2年または3年ごとに生存給付金を支払う「生存給付金付定期保険特約」や、期間の経過とともに保険金額が減少（増加）していく「逓減（逓増）定期保険特約」も発売されている。

イ) 災害割増特約，傷害特約，特定損傷特約

これらはいずれも不慮の事故を原因とする種々の保険事故に対して特別の保険金を支払う特約である。

災害割増特約は被保険者が不慮の事故または所定の感染症により死亡したり、高度障害状態に該当したときに所定の保険金が支払われるものである。

傷害特約は不慮の事故や所定の感染症による死亡のみならず、不慮の事故により傷害を受けて180日以内に所定の身体障害状態になった場合にも、その障害の程度に応じて所定の障害給付金が支払われる。

(注) 所定の感染症については前記①キ)(注) 参照。

特定損傷特約は、被保険者が不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けた場合に所定の保険金が支払われる。

ウ) 入院関係特約

この特約には、疾病やケガで入院したとき、所定の入院給付金を支払うものや、疾病やケガで手術した場合に手術給付金を支払うものがあるほか、家族の入院、手術についても保障する家族保障特約等がある。

入院給付金については、従来5日以上入院時に5日目から給付金を支払うタイプのものが主流であったが、近年では、医療技術の進歩に従う入院日数の短期化および顧客ニーズに対応し、2日以上入院時に初日から給付金を支払う特約も開発されている（日帰り入院に給付を行うものもある）。

また、がん、高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病（成人病）で入院したとき、所定の入院給付金を支払い、手術したときにも手術給付金を支払う「生活習慣病（成人病）入院特約」、女性特有の疾病による入院に対して入院給付金を支払う特約、退院後の通院に対して給付金を支払う特約なども発売されており、様々な医療サービスに対するニーズに込えている。

③ その他の関連諸制度

ア) 特別条件付特約

被保険者の健康状態が通常の被保険者よりも悪く、死亡危険度の高い場合、公平性を保つために一定の条件をつけて加入を認める特約で、この特約が付加された保険契約を条件付契約という。

これには、加入後一定期間に死亡した場合は保険金を削減して支払

う方法、危険度に応じて保険料を割り増しして徴収する方法などがある。

イ) 口座振替扱特約

保険契約者が金融機関に有する口座から、保険会社の口座に振り替えることにより保険料を払い込む場合に適用される特約である。

この特約が付加されると、月払保険については、集金等の手数料が省略されることから、集金扱よりも低廉な保険料率が適用される。

ウ) 団体扱特約

一定数以上の個人契約者が、同一の会社・団体に属し、かつその会社・団体を通じて給与天引きなどの方法で保険料をまとめて保険会社に払い込む場合に適用される特約である。この特約が付加されると、一般の月払保険よりも低廉な団体月払の保険料率（現在は、上記のイ）の保険料率と同じ）が適用され、保険会社は会社や団体に一定の手数料を支払う。また契約者が一定数を超える場合には、さらに低廉な団体月払の保険料率を適用する。

エ) 契約転換制度

既契約の責任準備金等を活用し、転換後の新しい契約の一部に充当するとともに、長期継続契約に対する配当の権利をそのまま生かして、新しい保険に転換できる制度をいう。既契約の責任準備金を中心とする転換価格を新しく加入しようとする保険の一時払保険料あるいは前納保険料に充当する仕組みである。一時払保険料に充当する方式では、一般的に転換価格の転換後契約への充当方法により3つのタイプに分かれており、転換価格を転換後契約の主契約部分に充当するタイプ、定期保険特約部分等に充当するタイプ、主契約部分および定期保険特約部分等に充当するタイプがある。

オ) 特約等の中途付加（中途増額制度）

保険期間中すでに加入している保険に定期保険（特約）、災害割増特約または入院関係特約を上乗せすることによって死亡保険金額または入院給付日額を増額する制度をいう。保険期間は元の保険（特約）の残余期間と一致し、特定の保険金額や給付日額のみを大きくできるところに特色がある。

カ) その他

主契約の保険料の払込方式については、保険料払込期間を通じて同額の保険料を払い込む平準保険料払込方式に加え、契約当初の一定期間内と一定期間経過後で異なる金額の保険料を払い込むステップ保険料払込方式がある。ステップ保険料払込方式の保険料は、平準保険料払込方式の保険料に比べ、契約当初の一定期間は少なく、一定期間経過後は多くなる。

その他に、ボーナス月に通常月（ボーナス月以外の月）より高く設定した保険料を払い込むことにより、毎月同額の保険料を払い込む場合に比べて通常月の保険料負担を軽減するボーナス併用払込方式や、保険金額の一部分に対応する保険料を一時払で払い込むことにより、保険料負担を軽減する一部一時払制度もある。

④ 団体保険

団体保険は個人保険と異なり、1つの契約で多人数の被保険者の集団を原則として無診査で一括して加入させる生命保険である。多人数を1つの契約で締結できるため事務経費等が少なくすみ、結果として一般的には個人保険に比べて割安な保険料となる。

以下、団体保険の保険種類について主なものを紹介する。

ア) 団体定期保険

個人定期保険と同様、保険期間の途中で被保険者が死亡または所定の高度障害となった場合に保険金が支払われる保険で、保険期間はすべて1年（契約は1年更新）、保険契約者は団体（代表者）である。保険料のうち団体が負担した部分については会社経理上損金とすることができる等の取扱いがある。

総合福祉団体定期保険は、1996年度（平成8年度）より、従来の団体定期保険を改定し、団体の弔慰金・死亡退職金規程等の支払財源を保障する部分を「主契約」、従業員死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用・育成費用等の諸費用（企業の経済的損失）を保障する部分を「ヒューマン・ヴァリュー特約」に区分した商品として、発売している。

なお、従業員が任意に加入し保険料を負担する形態は、通常「Bグループ」と呼ばれる。

イ) 団体信用生命保険

住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する（支払保険金で残債務を一括返済する）保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の減少につれて減少していく点に特色がある。

具体的には、債務者を被保険者とし、銀行、販売会社などの信用供与機関を契約者・保険金受取人、債務返済期間を保険期間、未払債務残高を保険金額として加入する。

近年では死亡・高度障害だけでなく三大疾病に罹患し所定の状態に陥った場合などにも保障対象を広げた商品が登場している。

ウ) 団体終身保険

一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の退職

後の死亡保障を目的として利用される。

工) 団体養老保険

団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年一時払いの保険を累積購入していく方式とがある。

オ) 団体就業不能保障保険

団体の所属員が傷病により就業できない場合に就業不能保険金を支払う仕組みの保険であり、1995年（平成7年）より発売されている。

カ) 医療保障保険（団体型）

医療保障保険（団体型）は、健康保険法改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。

⑤ 団体年金保険

企業の退職年金、一時金を準備するための保険である。

ア) 確定給付企業年金保険

確定給付型の企業年金について、「受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みの下に必要な制度整備を行う」こと、また、「これにより、公的年金を土台としつつ、確定拠出年金と相まって、国民の自助努力を支援する仕組みを整備する」ことを目的として2002年（平成14年）4月1日に開始された確定給付企業年金制度における対応商品として生保会社が提供している年金保険である。

イ) 企業年金保険

団体の所属員に対して、退職後一定期間あるいは一生涯にわたって年金を支給する保険である。

この保険には、団体が退職金・退職年金制度を実質的に裏付ける
目的で保険料を負担する「新企業年金保険」と団体の所属員が保険
料を実質的に負担して老後の年金資産を積み立てる「拠出型企業年
金保険」とがある。

なお、長年日本の退職金・退職年金制度の中心であった適格退職
年金制度は、確定給付企業年金法の施行により2002年度（平成14
年度）から新たな契約は認められなくなっていたが、2012年（平
成24年）3月に廃止となった。各企業等が実施していた同制度は
この10年間の間に廃止、または他の年金制度（確定給付企業年金・
確定拠出年金等）へ移行されている。

（注）実施されていた適格退職年金制度のうち、閉鎖型年金（新たな加入者
が無く給付のみとなっているもの）等については、その給付等における
税制上の優遇措置は存続している。

ウ）厚生年金基金保険

厚生年金保険の老齢年金給付のうち、報酬比例部分を企業年金で
代行させるもので、厚生年金保険と企業年金両者の機能や保険料を
調整する制度として実施されている。

なお、1990年（平成2年）4月から、特別勘定第1特約または
特別勘定第2特約を付加することにより、この保険の積立金の全部
または一部を特別勘定で運用することが可能となった。

しかしながら、現状においては近年の運用成績によって厚生年金
保険の一部代行部分の積立金が不足する基金も続出している。その
ため国では制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、該当基金等
に対して5年間の特例経過期間を設けて、他の企業年金制度への移
行を促進しつつ、特例的な解散（廃止）制度の導入等を行う厚生年金
保険法等の一部改正の法律が2014年（平成26年）4月に施行された。

工) 国民年金基金保険

国民年金の第1号被保険者（主に自営業者）を対象とし、国民年金の上乗せ給付を行うことを目的とした年金保険である。

1994年（平成6年）より、特別勘定特約を付加することにより、積立金の全部または一部を特別勘定で運用することが可能となった。

オ) 確定拠出年金保険

確定拠出年金保険は、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができる」制度として、2001年（平成13年）10月1日に開始された確定拠出年金制度における対応商品として生保会社が提供している年金保険である。

（注）確定拠出年金は個人の年金資産が明確であるため、転職または中途退職時にその資産を移行して契約を継続することができる。また、個人や事業主の拠出額には限度があるが、近年、公的年金の財政的な厳しさを補完する意味でも制度の充実が図られており、個人・事業主双方による掛金拠出や限度額の引き上げも実施されている。

確定拠出年金法改正により2017年（平成29年）1月から個人型への加入対象者が拡大され、公務員や専業主婦等（第3号被保険者）の加入も可能になった（個人型確定拠出年金：通称『iDeCo』）。

また、2018年（平成30年）5月には運用商品選択を支援する規定整備のほか、加入者への投資教育の努力義務化や中小企業向けの簡易型の企業型年金、個人型年金においては事業主掛金納付制度も創設された。

確定給付企業年金についても、事業主等と加入者個人が財政悪化リスクを負担する「リスク分担型企業年金」の創設（2017年（平成29年）1月）に加え、2018年（平成30年）5月からは一定の確定拠出年金等からの年金資産の移管（ポータビリティの拡充）も可能となった。

第2章 保険の生成・発展

学習のポイント

前生命保険史ならびに科学的生命保険会社制度誕生の背景，生命保険普及の過程，近年の金融制度改革進行時における生命保険会社の対応等を概観する。

重要項目

- 保険の生成に果たしたギルドの意義
- 資本主義社会における保険生成の諸条件
- 賦課式保険の問題点
- 不没収法の制定
- アームストロング調査
- 金融改革の進展と生命保険事業
- 日本の生命保険事業の革新
- 日本の生命保険事業の現状

1. 保険の歴史的発展

(1) 古代社会

太古の人類は、護身・食料獲得のために、群れを作って生活をしていましたが、やがて生産手段としての道具が発明されるにつれて共同体を形成するようになっていく。このような集団は、血縁集団であり、氏族社会ともいわれるが、こういう社会の習慣として、相互扶助と防衛は一種の義務となっていたようである。

やがて、この氏族社会も、貧富の差が広がり、貴族・平民・奴隷の階級社会が成立するようになる。こうして成立したギリシア、ローマといった古代国家は、奴隷制度に支えられていたが、強大なローマ帝国も末期には対外的な膨張も限度に達し、富と奴隷の供給が減少、国家財政の破綻を促した。国家権力の衰えに乗じてその支配から独立する実力者が多く現われ、帝国は内部から崩壊した。

(2) 封建社会

ローマ帝国は奴隷制度とともに滅び、代わって封建社会が形成されてくる。封建社会の経済は、原則として農業を基盤とする自然物産経済であり、領主とその支配下に置かれた村々は、政治・経済の独立した単位を形成した。

封建社会では、農民や職人の生産力は領主にとって不可欠であり、領主はその生産力に依存し、また一方、農民や職人はその生活を領主によって守られていた。

故に上下の支配関係の中で相互依存していることから、この社会制度それ自体が保障制度の役割を果たしていたといえよう。

西ヨーロッパの封建社会は、農業生産を基礎とする自給自足の社会であったが、封建社会の確立に伴い生産力が向上するにつれ、次第に余剰生産物が生み出されるようになり、交換経済が起こってきた。これに対応して、一部の村民はこの余剰生産物を入手して手工業だけに専従できるようになり、こうして村落では農業と手工業が分化し、手工業者と、原料・製品の輸送・販売を専業とする商人層とが現われ、商品経済と都市成立への動きが始まったのである。

(3) ギルドと海上冒険貸借

都市経済では商人とその家族は1つの経済単位であり、彼等が被った経済的損失は、貴族も領主も救済してくれず、自らが補填していかなければならない。彼等は自由であり、独立してはいるが、それに伴って種々の危険が彼等の社会・経済生活に起こるようになった。

商人たちは、商取引や貿易をするに当たって、盗賊や海賊に襲われるという危険から、自主的な団結と相互扶助を組織的に行う制度を生み出した。これがギルドと呼ばれる組織である。

ギルドにはそれぞれギルド規約が設けられ、組合員はこれに従った。親方と徒弟は、組合員の共存と共栄を目指し、経済的特権の獲得や、組合員の冠婚葬祭も含め、経済的損失は全員で分担し合った。

太古の共同体や奴隷制度、さらに封建社会における農奴制度などは、社会それ自体が保障制度であったが、ギルドは封建社会の中で独立的な経済単位が結合して、自らの力で危険に対処した最初の試みである。このギルドの精神が今日の生命保険に受け継がれていることから、現代生命保険の起源をギルドとする人もいる。

また、中世における商業の発達、海上保険の生成を促進し、地中海沿岸のイタリア諸都市の商人達が、海上貿易の危険を商人相互間に転嫁するシステムとして慣習化した冒険貸借という制度が発生した。この時代に地中海を中心に盛んに行われた海上貿易では、航海が成功すれば莫大な利益を得ることができた。そこで、この利益を目的として、資金を持っている者が船舶または積荷を抵当として資金を貸し付けた。

このように、海上冒険貸借は海上貿易の危険を保障する役割を果たしたことから、海上保険の始まりともいわれる。しかしこの制度はあくまで商業主義に基づく投機的営利を目的とする制度であった。

(4) 資本主義社会

ギルドを含め、封建社会は産業革命とともに終焉を迎え、資本主義社会が姿を現し始めた。人々は共同体の束縛から解放され、自由を獲得したが、自己責任の下、さまざまな危険に対する対策が必要となった。

このようにして、保険生成の諸条件が資本主義社会の中で成熟してきた。また、近世初頭の合理主義の台頭により、危険を予測する手段としての確率論や統計学が発達し、保険業者はこれらを保険の理論に取り入れ、経営を科学的・合理的なものとした。その結果、18世紀末から19世紀初頭にかけて、近代的な海上保険、火災保険、生命保険会社が設立され、急速に保険の投機的性格は薄れた。

初期の商業資本に代わり産業資本がその地位を確立する段階では、社会は資本家と労働者の階級的対立を生み出していた。特に後進資本主義国のドイツでは、労働者階級の弾圧に失敗したあと、一連の社会保険が社会政策の手段として実施された。これは、資本主義社会における最初の社会保険であり、厳しい労使対立の結果、労働者のために作られた「相互援助」の制度であった。

20世紀に入ると、資本主義が本格化し、国内的には労使間の対立の激化、国際的には列強間の衝突が起こり、人々の社会・経済生活は多様化し社会的危険はますます高まり、保険の態様も複雑・多様化した。保証保険その他各種損害保険の発展、団体生命保険の登場、年金を含む生命保険の多様化、健康・傷害保険の発生、さらには社会保険の一般化、社会保障の登場等である。

今日では、社会経済の究極の目標は、国民の経済的福祉の追求にあるということが普遍的真理として認められつつあり、国民の福祉の増進に国が社会的使命を果たしている、ということであろう。

そして保障の領域においても、自由な個人の任意の保障と社会の責任において保障する保険とのバランスをどう調整するかという新しい課題が、提起されているのである。

2. イギリスにおける生命保険の発展 —近代的生命保険の誕生—

17世紀のイギリス社会では、都市経済の発展により、人々の生活は貨幣経済を基盤として向上したが、貨幣収入に依存する生活が一般的となり、死亡などによる収入途絶という経済的危険が一般の人々の生活上の最も重大な問題として意識されるようになってきた。

このような中で一般の人々の保険の前身としての生活保障制度は、イギリス社会で発生をみることとなった。初期のものは保険組合と呼ばれる、科学性、合理性を欠くものであった。

しかし、試行錯誤を繰り返す中で、生命保険の基本理念を学ぶとともに、ルネッサンス以後発達した自然科学の理論を導入することによって、現在の近代的な科学的生命保険の基礎を確立するに至った。

（１）賦課式保険の問題点

相互扶助の保険組合の記録として残っている最古の組合に、1698年にできたマーサーズ・カンパニー（Mercer's Company）があるが、これは教会の牧師達が自分たちに万一のことがあった場合に妻子の生活難を救済し合うために設立した相互扶助組合を発展したものであった。

また、1699年には寡婦と孤児のための保険組合（The Society of Assurance for Widows and Orphans）という保険組合が生まれ、さらに1706年には英国における最初の生命保険会社といわれるアミカブル・ソサエティーが創設された。

これらの保険組合または会社は、遺族の生活保障を目的として最初に生命保険事業を行ったものであるが、その仕組みは賦課式の制度であり、組合員の中で死亡した人に支払われる給付金を加入者が負担するというものであった。賦課式の火災保険の場合には長年にわたって運営されても問題はあまりなかったが、賦課式の生命保険の場合は大きな問題点があった。

火災保険の場合、火災の発生率は家の古さとは関係なく、毎年著しく異なることもない。また、分担金の払込人数もあまり変動しない。したがって、毎年の分担金は同額でよいことになる。

ところが生命保険の場合、人間の死亡率には年をとるにしたがい必ず高くなるという特性がある。しかも死亡する人が増えるにつれて、分担金を払い込む人数も減ってくる。賦課式の生命保険では、年を経るにつれ死亡率が高くなるので、給付金を一定にすれば、分担金が年々増加し、一方、分担金を一定にすれば、給付金が減少せざるを得ないことになる。そして組合員が年々老齢化すると、給付金支払いが多くなると同時に、分担金を払い込む人数も減ってしまい、給付金の支払いができなくなっ

て、団体は解散に追い込まれてしまうこととなった。

いま1つの問題は、人間の死亡率は年をとるにしたがって上昇するものであるが、この時代の賦課式の保険組合や会社では、この原則が理解されておらず、若年者も高齢者も同額の分担金を払い込むこととしたところに問題があった。

(2) エクイタブル・ソサエティーの誕生

賦課式の保険では、危険率の相違する者が同額の分担金で危険分担をしたことに問題があったが、その後、自然科学の進歩により、死亡率に基づき危険分担をする合理的科学的保険料が算出されることになった。

ジェームス・ドドソンによって考案された平準保険料方式を採用した科学的な生命保険会社の設立は、当時の人々の理解を得られず失敗に終わったが、彼の死後5年経って、彼の遺志を受け継いだ人々によって1762年に世界で最初の科学的な生命保険会社エクイタブルが設立された。

エクイタブルは相互会社として設立されたが、当時すでに存在していたアミカブル、ロイヤル・エクスチェンジ、ロンドン・アシュアランスの3社が賦課式で定期保険のみを扱っていたのに対し、年齢別の平準保険料の制定、申込者の医的診査の実施（1858年以降）、最高保険金額の制限、解約返戻金および契約者配当の実施、保険数理の専門家であるアクチュアリーを設置、定期保険だけでなく終身保険の販売など、近代的生命保険事業の特徴を備えていった。

エクイタブルは、設立後短期間のうちに成功を収め、1800年までには保有契約高は5,124件、390万ポンドに達した。

このエクイタブル・ソサエティーの成功により、長期契約方式に基づく生命保険への信頼が高まり、特に配当の支払いを実施したことは当時の人々から大変な好評を博した。

その後、相互組織による生命保険会社が数多く設立された。相互組織による生命保険会社では、契約者も経営に参加する道が開かれており、また剰余金のほとんどが契約者に配当金で還元され、さらに加入者相互の助け合いの思想が相互組織に適していることなどの理由からである。

しかし、こうした生命保険会社を利用できたのは、主として有産階級であり、広く大衆に普及するまでには至らなかった。

当時の一般の人々や労働者は、共済組織としての友愛組合に彼等の保障の方策を見出していた。

(3) 友愛組合

イギリスでは封建社会の崩壊とともに、市民は土地から解放され自由を獲得する一方、領主の保障を失った。そのため、一般市民や労働者階級の間に共済的な保険組合が生まれてきた。これを友愛組合といい、封建社会の崩壊により消滅したギルドの精神を受け継いだものと考えられている。1628年にギルドは消滅、友愛組合は1634年に誕生した。

この友愛組合は、互いに協力して困窮者を救済し合う共済制度であったが、あらゆる階層へ広まり、大きな位置を占めるようになった。

産業革命の進展に伴い、イギリスにおいては多くの労働者が生まれ、彼等は貧困の救済手段として、友愛組合に自己防衛の道を見出した。

初期において、フランス革命の余波を恐れた支配階級は、労働者の結社、団結につながる友愛組合に対し厳しい目を向けた。ところが、エリザベス王朝の時代に貧窮者を救助するために施行された「救貧法」による財政負担の増大により、1793年、「ローズ法」(Rose's Act 正式には Act for the Encouragement and Relief of Friendly Societies) が制定され、友愛組合は法律で保護されることとなった。

救貧法に基づいて政府が財政負担するよりも、むしろ民間で行われて

いる友愛組合を援助することによって低所得者の生活保障を促進しようとするローズ法によって、友愛組合は合法と認められ、登記することによって免税の特典が与えられた。ローズ法によって、その後友愛組合は着実に発展することになった。

なお、友愛組合は、最初は賦課式であったが、後に科学的な制度を導入することによって広く普及、発展し、現在でも存続している。

(4) 黄金時代から泡沫会社時代へ

アクチュアリー協会の誕生

19世紀に入って、イギリスの生命保険会社は黄金時代を迎えることとなった(1816年～1844年頃まで)。科学的な根拠を持つ死亡率データの入手、死亡率の低下、一般大衆の好意的態度の形成などの好条件がその背景となった。そして、従来は保険料が高額なため生命保険には加入できず、共済組織としての友愛組合に加入するのがせいぜいであった労働者階級に対しても、1854年にプルデンシャル社が簡易生命保険(Industrial Life Assurance)を販売することによって本格的に生命保険を提供するようになった。

1844年以降の20数年間は、この黄金時代に刺激され、多くの会社が設立されては消滅するという混乱状態が生じ、その間に破産・合併した会社は330を数えた。そこで、政府は生命保険会社法を1870年に制定し、監督に乗り出し、それ以降は生命保険会社の数も次第に減少した。

またこの頃、保険数理を基礎とする専門職としてアクチュアリー(Actuary)が生まれ、アクチュアリーが互いに研鑽し合う場として1848年にアクチュアリー協会が創立された。アクチュアリー協会は科学的研究を推進し、生命保険事業のその後の健全かつ大きな発展に貢献をすることとなった。

3. アメリカにおける生命保険事業の発展

イギリスで誕生した近代的生命保険制度は、ドイツ、フランスにも広がり、さらにアメリカに導入されて、大きく発展することになった。

アメリカの生命保険の歴史は、イギリスで確立した近代的生命保険制度を導入した保険会社が、国民生活の変化に対応させながら、生命保険の利用を正しく、広く公衆に理解させ、一般社会に普及させることに成功したマーケティングの発展の歴史であった。

(1) 19世紀末までの発展

19世紀に入って、最初の40年間に株式会社形態による多数の生保会社が設立されたが、多くの会社は不健全経営により姿を消している。その中で目立った功績を残した会社には次の様なものがある。

社 名	設立	功 績
ペンシルヴァニア生命年金会社 (The Pennsylvania Company for Insurance on Lives and Granting Annuities)	1809	初の科学的基礎に基づいた生保事業経営（厳格な契約審査・医的診査。年齢比例の保険料賦課）。
ニューヨーク生命保険信託会社 (The New York Life Insurance and Trust Company)	1830	初の代理店、営業職員を積極活用した販売戦略を展開。
ジラード生命保険信託会社	1836	株式会社であるが、株主だけでなく保険契約者にも剰余金を配当として支払。この成功が相互保険会社誕生の道を開く。
ミューチュアル・オブ・ニューヨーク社 (The Mutual Life Insurance Company of New York)	1843	初の相互保険会社、大数の法則に従い相当数の申込を待って経営開始（開始5年で4千件を超える契約獲得）。

南北戦争は生保事業に大きな打撃を与えたが、戦後は再び勢いを盛り返し、毎年50%以上の増加率を示した。しかし、こうした中で新契約獲得のための各社間の競争は過熱し、不健全な経営に走る会社も出て、多くの会社が瓦解した。その主因は経費の使いすぎ、特に手数料の浪費にあったといわれる。

(2) 不没収法の制定

① 監督行政の強化

以上述べたように、激しい新契約競争の結果、1847年から1859年の12年間に42の会社が設立されたが、そのうち24の会社が放漫な経営により廃業することになった。

このような不健全な経営によって人々から厳しい批判の目が生命保険会社に向けられたため、州政府が生命保険の監督に乗り出した。

そして、1851年にニューハンプシャー州で保険監督局が設置されたのを初めとして、その後各州でも同様に監督行政が行われることとなり、保険会社の営業活動について保険金支払能力の有無を中心に監督が厳しく行われることになった。

② エリザ・ライトの功績

マサチューセッツ州で1858年から1866年まで保険監督官であったエリザ・ライト (Elizur Wright 1804年～1885年) は、「アメリカ生命保険の父」と呼ばれる人である。

当時のアメリカにおいては長期契約に加入した契約者が途中で契約を解約した場合には、自ら契約の権利を放棄したものであり、また責任準備金は将来の保険金支払いに欠くことのできないものであると考えて、解約した契約者に所定の額を解約返戻金として返還することは一般的には行われていなかった。返還するケースもあったようだが、特に基準は定められていなかった。

そこで、エリザ・ライトは責任準備金の範囲内で、契約の解約に関係なく、常に一定の割合を責任準備金の積み立てに貢献した契約者の権利として認め、その所定の額を会社が不当に没収すべきでないと主張し、不没収法の制定に努力した。その結果、1861年に不没収法 (Non-

forfeiture Law) がマサチューセッツ州議会で承認された。以後、保険会社の支払能力は強化され、支払能力のない保険会社は整理された。

不没収法の制定によって、契約を失効させた契約者に対し、それまでに積み立てた責任準備金を完全に没収することなくその時の不没収価格を基にして、以後の保険料払込みを中止して死亡保障だけを続ける延長定期保険に変更できることとなった。後に、ニューヨーク州でも、1879年に不没収法が成立し、減額払済保険に変更できる道を開いた。また、1880年にマサチューセッツ州で解約価値法 (Cash Value Law) が制定され、契約の失効時に現金による払い戻しが実施されるに至った。

その後、法定責任準備金法、不没収法が他の諸州でも採り入れられ、1880年代には多くの保険会社の約款に不没収条項が採り入れられて一般化した。さらに不没収価格を基に契約者に貸付を行うこと (契約者貸付) や、保険料の払込みが困難になった時には以後の保険料の払込みに振り替えて貸し付ける保険料振替制度も設けられた。

このように、生命保険は死亡した場合に限らず、長期契約の途中で生活上の経済的変化に対応できるようになって、その利用範囲が大きく拡大した。この結果、生命保険は死亡また生存中においても役立つということが広く理解され、アメリカ国民の中に広く浸透することとなった。エリザ・ライトがアメリカ生命保険の父と呼ばれるのは、同氏が法定責任準備金法を制定させて生命保険会社の保険金支払の基礎を確立するとともに、不没収法によって生命保険が長い契約期間中の経済的問題の解決策としても役立つという一大変革を行い、生命保険契約者の利益を確保したからである。

(3) アームストロング調査

19世紀末、鉄道などの基幹産業は次々と巨大会社の支配下におかれ、巨大こそ全てであるとの風潮がアメリカの社会に生まれた。生命保険会社も保有契約高を競い、新契約の獲得競争が激化し、事業費の乱費など経営上のいろいろな問題が生じた。エージェントの引き抜き、エージェントや加入者へのリベート、契約乗り換え、過大な契約獲得と過大な経費支出、配当金の支払遅延、トンチン配当、会計記録の不備やシンジケートによる不当融資などが行われた。この結果、20世紀に入り、基幹産業とともに生命保険業についても厳しい批判が噴出した。

こうした世評に応じて、1905年にニューヨーク州政府は上院議員アームストロングを委員長とし、生命保険会社の業務内容の調査を実施した。これが有名なアームストロング調査委員会である。

その主な調査内容は

- (i) 経営者の事業経営は適正であるか
- (ii) 株主、契約者によって経営が監視されているか
- (iii) 相互会社の役員選挙は適正に行われているか
- (iv) 資産運用は適正か
- (v) 事業費の支出は適正か

であった。そして、この調査結果により、経営内容について多くの問題点が広く露呈し、公衆の生命保険に対する批判は更に激化し、アメリカ国民の間に生命保険によって得られる利益はほとんどない、生命保険契約者は法律によって十分守られていないという議論が巻き起こった。

その結果、1906年に、アームストロング調査委員会の勧告に基づき、ニューヨーク州で保険に関する次のような内容の取締法が制定された。

ア) 新契約費と年間の新契約高を制限する

イ) 会社の行う投資方法ならびに新契約費の支出について厳しく取り締まる

ウ) 会社役員選出に関する基準を制定する

エ) 契約条項に保険料払込猶予期間と不可争期間の規定を設けることなどであった。

最初この法律は、ニューヨーク州で営業している保険会社にのみ適用されたが、その後合衆国の大多数の州で同様の法律が制定された。こうして生命保険事業は、他の産業に見られない厳しい法律と監督行政のもとにおかれることとなった。

アームストロング調査の直後に、一時新契約高は減少したが、各社が歩調をそろえて再建に努力した結果、生命保険に対する国民の信頼も徐々に回復し、生命保険事業の健全な発展の基礎が固められた。

(4) 20世紀前半における生命保険事業の発展

1907年マサチューセッツ州で認可された貯蓄銀行生命保険は、エージェントを使わず貯蓄銀行の店頭で生命保険を販売するという独特なシステムとして、今日なお続けられている。貯蓄銀行生命保険は、その後1930年ニューヨーク州で、さらに1941年コネチカット州でも認可されるようになった。

1911年、「海外で確立した社会保障制度のアメリカ版」と呼ばれた団体保険が創設され、さらに高度障害給付保険なども新たな商品開発が図られたほか、経験死亡率の著しい改善、高い投資収益などによって配当が増加し、保険コストが低下した。こうしたことが第一次大戦後10年間にわたる生命保険事業の繁栄の大きな要因となった。

また、第一次大戦(1914～18年)に参加する軍人たちの保険として、政府管掌による戦争危険生命保険の制度も生まれた。さらに生保業界自

体もこのころから傷害・疾病保険の分野に進出し、さまざまな形態による生命保険の販売が活発に行われるようになった。

1929年、株価大暴落を契機としてアメリカ経済は恐慌状態に陥り、生命保険事業にも影響が及んだ。アメリカ経済は不況に悩まされ、社会主義的風潮が起きるとともに巨大企業に対する公衆の批判が高まってきた。このような社会経済情勢のもとに、1938年経済力集中問題を調査する臨時全国経済委員会（TNEC）によって広範な調査が実施された。この調査によって生保事業はアームストロング調査以来勧告を忠実に遵守していることが明らかにされたのであったが、これを機会として業界に、政府あるいは公衆に対する生命保険についての正しいPRの必要性の認識が高まった。1939年設立された生命保険研究所（ILI）はPR機関として多くの業績を残し、今日、米国生命保険協会（ACLI）として発展的に継承されている。

なお、アメリカにおける保険事業規制は伝統的に州政府によって行われてきたが、このことは、1945年に公布されたマッカラン・ファーガソン法によって初めて制定法として明確にされた。

（5）第二次大戦後の生命保険事業

① 第二次大戦後の発展

第二次大戦後、生命保険は広くアメリカ国民の間に普及し、契約高が急速に上昇するとともに、1950年代にはEDPS（電子計算機を利用したデータ処理システム）が導入され、また通信販売やクレジット会社を通じた販売が行われるなど新しい販売方式の開発が行われた。

さらに、労働組合との交渉の中で、重要な案件として福利厚生制度が取り上げられるようになって、団体定期保険、団体年金保険、団体健康保険の利用が高まり、この普及とともに生命保険会社の規模はま

すますます大きくなった。

1954年、アーカンソー州で初めて、インフレに対応することを目的とした変額年金契約を生命保険会社が取り扱うこと、そのために分離勘定を設定して年金資産を運用することが承認された。その後、この変額年金は多くの議論をまねいたが、結局、他の州でも許可され、インフレーションによる貨幣価値の下落に対応できる年金制度が生まれることになった。その後、変額制度は生命保険についても採り入れられるに至った。

② 軍人向け保険，社会保障

第一次大戦，第二次大戦を契機に種々の軍人生命保険を政府が提供したことは、広く生活上の保障の必要性を公衆に理解させることに大きく役立ち、民間の生命保険はさらに普及することになった。

そして、生命保険会社は生命保険を通じて国策に協力することとなった。

軍人向け保障の発達

第一次世界大戦	WRI 戦争危険生命保険 (1914), USGLI 合衆国政府生命保険 (1919)
第二次世界大戦	NSLI 従軍生命保険
大 戦 後	現役並びに復員生存者給付金法制定 (1965) 軍事団体生命保険 (1965), 復員軍人団体生命保険 (1974)

また、アメリカの社会保障制度は1935年に始められたが、元来その保障額は一律で、しかも最低生活を保障するものであるので、社会保障の普及によって、生活保障の必要性に対する国民の認識が高まり、生命保険の需要を喚起することに役立った。

③ 消費者運動の高まりと生命保険事業

1950年代から1960年代にかけて生命保険事業は、死亡保障のみならず老後保障分野、医療保障分野でも順調な発展を遂げた。こうした中で生命保険会社の商品の多様化や業務の拡大、社会保障給付の増大

と民間生命保険とのバランス調整のため、直接の監督官庁である州政府だけでなく、連邦政府も生命保険に関する立法にかかわることが多くなった。そこで全生命保険会社は団結して連邦政府関連の諸問題に対応できる態勢を築くために、それまで併存していた株式会社中心の団体と相互会社中心の団体とを合併して、単一の業界協力機関を誕生させた。これが1973年に設立された米国生命保険協会（American Life Insurance Association, ALIA）である。

その後、生命保険契約のコストと給付のディスクロージャーを求める消費者運動への積極的な対応を図るため、PR活動の専門機関であった生命保険研究所（ILI）と前述のALIAが合併し、すべての機能を統合した業界機関である米国生命保険協会（American Council of Life Insurers, ACLI）として発足した。こうして生命保険業界は、対連邦政府関係活動を強化しつつ、企業の社会的責任問題に積極的に取り組むようになった。

（6）金融革命の進展と生命保険事業

① 金融革命下の金融機関

1960年代、クリーピング・インフレーションと呼ばれた穏やかな消費者物価の上昇は、ベトナム戦争、70年代の第一次および第二次のオイルショックを経て上昇のテンポを速めた。この高インフレは、1982年半ば以降急速に鎮静化していったが、この時代、長短金利は激しく上昇し歴史的な高率を記録した。このため、個人や企業の金利選好度は著しく高まり、預金から自由金利商品へ資金がシフトした。特に1978年半ば以降証券会社のMMF（Money Market Fund）の爆発的な売れ行きが引き金となって金融の自由化が急速に進展し、証券会社のMMF、CMAに対抗した銀行のNOW勘定、MMA（Money

Market Deposit Account) などの自由金利商品の開発競争が展開された。高インフレ・高金利は、経済の安定を前提とする商品とエージェント制度という販売チャネルを持つ生命保険業界に大きなインパクトを与えた。

② 高インフレ・高金利の生命保険事業への影響

ア) 伝統的な終身保険の魅力の低下と資金の流出

高インフレ・高金利と消費者の金利選好意識の高まりは、それまで普通保険の大半を占めていた終身保険の魅力を消した。インフレ率が3%程度の時代には5%程度の利回りのキャッシュ・バリュウでも、死亡保障があり、またいつのまにか貯蓄もできるという終身保険は人々の広範な支持を受けた。しかし、1970年代に入り2桁インフレを経験し、3カ月物TBレートが10%を超えるようになると、銀行預金と同様、終身保険に対する信頼が薄れ、高金利商品へとシフトする傾向が強まった。1970年代を通じて、生命保険会社は未曾有の解約・失効率を経験し、キャッシュ・バリュウを担保とした契約者貸付の急増と相まって、生命保険会社から資金が流失したのであった。

イ) 定期化の進展とニューウェーブ商品の登場

伝統的な終身保険が次第に訴求力を失い、生命保険は定期保険のみとし、残りは高利の金融商品に投資しようとする動きが出てきた。普通保険新契約の中に占める定期保険占率は1970年代までは件数で10%、金額で40%程度であったが、1980年にはそれぞれ20%、56%と大幅に上昇した。

しかし、価格競争力のある修正保険料式終身保険や金利感应型終身保険等の改良版終身保険が発売され、また、変額保険およびユニ

バーサル・ライフといったニューウェーブ商品が開発され、急成長した。近年では、終身保険、定期保険、ユニバーサル保険、変額ユニバーサル保険の4者が、新契約保険料のシェアで拮抗している状況にあるが、趨勢的にはユニバーサル保険のウエイトが高まってきている。

ウ) ニューウェーブ商品の開発

歴史的に高インフレと高金利という経済的大変動とともに、高度情報化、教育水準の向上、高齢化、共働き世帯あるいは単身者の増大といった社会構造上の変化によってもたらされた顧客ニーズへの対応として開発されたのがニューウェーブ商品である。具体的には、変額保険、ユニバーサル保険、変額ユニバーサル保険であるが、これらの保険の商品設計上の基本コンセプトは、

- (i) 実勢金利や運用実績の商品への反映
- (ii) 保険の対価——保険料（特に付加保険料）の明確さ
- (iii) 保険設計または投資選択の自在性・弾力性

である。

ユニバーサル保険は、保険料をキャッシュ・バリューとして積み立て、このキャッシュ・バリューをTB、CD、CPといった短期自由金利商品に投資し、短期金利にスライドする形で利殖した中から死亡保障コストを控除する商品である。決済機能こそ持たないものの、死亡保障額に影響を与えることなくいつでもキャッシュ・バリューの引き出しが可能であり、また保険料の払込みが自由であるなど自在性があることなどから、有力商品となった。

一方、企業向け商品では、企業年金をめぐる競争により、確定金利保証契約 (guaranteed interest contract, GIC) の販売が積極化した。

これらの新商品の販売は生命保険会社の販売の拡大に貢献したが、GICにおける高金利の付与は高リスク資産への傾斜を招き、経営不振の一因となった。

③ 投資環境の悪化と経営不振

新たな市場を創造し、失われた市場を回復したこの商品革命も、一方では生命保険会社の収益構造を大きく変え、経営の安定性に影響を及ぼすこととなった。

ア) 商品革命による収益構造の変化

ニューウェーブ商品などの高利回り商品は、発売当初は折からの高金利に支えられ順調であったものの、競争の激化や金利の低下により、次第に生命保険会社の収益を圧迫していった。

その結果、高利回りの運用を求めてハイリスク・ハイリターン投資へ傾斜する会社が増えた。生命保険会社の収益源は収入保険料と投資収益であるが、1980年代は、投資収益が収入保険料を上回る状態であった。

イ) 運用環境の悪化

1980年代後半になると、1987年のブラック・マンデー（株価暴落）など、投資環境は悪化の一途をたどり、経営不振に陥る生命保険会社が発生した。特に、高利回りのGICを大量に販売し、ジャンク・ボンドや商業用不動産抵当貸付などのハイリスク資産に多額の投資を行っていた会社に顕著で、1991年には準大手2社が経営破綻した。また、翌1992年には大手会社の一つであるエクイタブル生命の資産内容が悪化し、自己資本を調達して財務体質を改善するため相互会社から株式会社への転換を行うなど、生命保険業界の危機的状況が大きな問題となった。

これらに伴いアメリカでは、生命保険会社の保険金支払能力に対

する関心が高まり、1993年には自己資本規制の導入が行われ、各社とも資産の健全化に努めて、経営破綻会社も減少していった。

④ 相互参入の活発化と金融制度改革

1990年代後半、インターネット等、通信手段を用いた販路の高度化と急速な普及により、保険・銀行・証券などの金融他業との参入障壁が著しく低下した。特にコスト面では顕著であり、保険会社から貯蓄金融機関（Thrift）免許を取得しての銀行業務への参入申請は、1997年から1999年の3年間で約60社にのぼった（スリフト監督局資料）。このような金融機関の相互参入の活発化は、遂に1933年銀行法の金融機関の垣根を定めたグラス・スティーガル法の廃止へと発展した。1999年11月に制定されたグラム・リーチ・ブライリー法は、金融持株会社設立により、銀行・証券・保険を傘下に併有することを認め、これによりアメリカでは60年ぶりに金融機関の垣根が撤廃された。総合金融サービス化が加速するとみられ、保険会社もその例外ではない。

一方、最近では、サブプライム問題から発した2008年のリーマンショックを契機とした米国金融市場の脆弱性の露呈もあり、2010年には金融規制改革法（ドッド・フランク法）が制定され、リスク回避指向の規制（監督）強化も図られている。

4. 日本における生命保険の発展

日本に生命保険制度が導入されたのは明治時代の初期であったが、これはイギリスで近代的生命保険会社エクイタブル・ソサエティーが生まれてから約100年、アメリカ最初の生命保険会社ペンシルヴァニア生命年金会社が生まれてから約50年後のことであった。

日本の生命保険会社は、欧米の近代的生命保険制度を手本として設立され

たが、当時は、一般に保険に対する知識も理解もなく、会社は生命保険の普及について長年にわたって営々たる努力を重ねていった。その結果、今日では国民生活にとって欠くことのできない生活保障機能および金融機能を果たすに至った。

(1) 近代的生命保険の導入

① 封建社会と保障制度

明治時代以前、日本にも古くから宗門団体、同業者、村落などを中心として相互扶助の思想に基づく、頼母子講^{たのもしこう}、無尽^{むじん}、職人組合などの隣保扶助制度や三倉制度^{ぎそう じょうへいそう しゃそう}（義倉、常平倉、社倉）、海上請負^{なげかね}、抛銀などの損害保険的思想を持った制度が存在したが、日本の保険はこれらの類似制度から発展したものではない。

(注) 無尽や頼母子講は一定の期間に、毎月掛金を払い込ませ、抽籤や入札によって加入者に金銭を給付するものである。したがって、保険のように偶発的危険に遭遇した者に対し、その資金の必要を満たすものではない。結局、共同で積み立てた資金を加入者が利用するものではあるが、早期に給付を受ける者にとっては借入金であり、遅れて給付を受け取る者にとっては一種の貯蓄にほかならない。

日本の近代的生命保険会社の誕生は明治時代の初期で、近代化政策の一つとして、封建社会のシステムにかわる生活保障の手段として生命保険の必要性が認められた。

② 生命保険事業の始まり

明治の初期に広く西洋文明を紹介した福沢諭吉は、彼の著書「西洋旅案内」「西洋事情」の中で、英米の保険制度を紹介した。特に「西洋旅案内」は、日本に保険を紹介した最初のものであり、次のように保険制度を説明している。

『災難請合とは商人の組合ありて平生無事の時に人より割合の金を

取り万一人へ災難あれば組合より大金を出して其損亡を救う仕方なり其大趣意は一人の災難を大勢に分ち僅の金を棄て大難を通る訳にて……（以下略）』

1881年（明治14年）になって福沢諭吉の門下生であった阿部泰蔵によって、日本最初の近代的生命保険会社である明治生命が設立された。

これより前に近代的生命保険会社を設立しようとした人物もいた。若山儀一は1879年（明治12年）に日東保生会社の設立を企てたが、事業資金が集まらず計画を断念した。また安田善次郎は1880年（明治13年）にイギリスの友愛組合を手本に安田生命の前身である共済五百名社を設立し、賦課式の保険事業を行ったが、その後1894年（明治27年）になって共済五百名社は科学的保険制度を採り入れた。

さらに1888年（明治21年）には帝国生命（現在の朝日生命）、翌年には日本生命が設立された。

当時は、明治新政府になって諸制度が改められたが、封建時代の諸制度の残滓は多く、血族的保障制度としての家族制度もまだ根強く残っていた。このような情勢のもとで、生命保険に対する必要性は一般の人に認識されず、また生命保険という保障制度を理解させ、これを利用させることは容易ではなかった。

創業当時の人々は馬やわらじばきで全国を訪ね、各地の名士に生命保険の必要性を説明し、代理店を委嘱して、名士の名声と信用に基づいて、生命保険の普及に努めた。

（2）日清、日露戦争前後

明治生命、帝国生命、日本生命の3社が業務の拡張に努めた結果、これら3社の業績が向上してきたこともあって、各地の資産家達が生命保険事業に注目し、1892、93年（明治25、26年）頃から、事業意欲を多

分に伴った株式制度の生命保険会社が各地に濫設されるに至った。

この動きは、1894年（明治27年）をピークに、1898, 99年（明治31, 32年）頃まで続いたが、この間に新設された会社は40数社（株式会社）にも及び、さらに全国各地で泡沫的な類似事業が行われ、その数は数百にのぼった。

その多くの会社が統計的基礎を欠く保険事業であったり、また濫設による競争の激化で無理募集や義理募集を行ったこともあって、生命保険会社に対する非難が沸き起こった。そして当時の新聞には生命保険事業を批判する記事が数多く見られるようになった。

こういった状況の中で、業界内から、このような状況を放置することは正しい生命保険事業の発達を妨げるものであるという声が起こり、その結果1898年（明治31年）に業界が協力して、生命保険事業の正しい発展と秩序を保つために現在の生命保険協会の前身である生命保険会社談話会を設立した。また、1899年（明治32年）には保険数理の専門家達によって日本アクチュアリー会が設立された。

また、政府としても、より厳しく保険事業の取り締まりを行い、監督を強化すべきであるという意見が出てきた。

そこで、1899年（明治32年）に、ドイツの保険監督法に範を取り、保険業法が制定され、農商務省に商工局保険課が新設されて、保険事業の監督行政が行われるようになった。この業法の制定に当たっては、当時、日本生命の社医を辞していた矢野恒太（のちの第一生命の創立者）の多大な貢献があった。

保険業法の制定によって、その後類似会社の濫設はあとを絶った。また株式会社組織のほか相互会社組織による生命保険会社の設立が認められるとともに、事業方法書や普通保険約款を統一整備する必要が生じた。

従来の約款は各社まちまちであったが、業法の制定により統一約款を定めたいという各社の要望に沿って、生命保険会社談話会では、1900

年（明治33年）に日本で最初の模範普通保険約款を制定した。さらに、業法の制定により相互会社の設立が認められたので、1902年（明治35年）に第一生命が、また1904年（明治37年）に千代田生命がそれぞれ相互会社として設立された。

1894年（明治27年）の日清戦争、1904年（明治37年）の日露戦争を通じて、生命保険の被保険者の中から数多くの戦死者が出たが、生命保険会社はこれらの遺族に対して保険金を支払った。その結果、多くの人々に生命保険の効用についての理解が広められた。

日露戦争後、日本経済は活況をとりもどし、また一般の人々にも生命保険による経済準備の必要性が徐々に認識され、新規加入者も順調に伸展した。

1911年（明治44年）には、明治生命、帝国生命、日本生命の生命保険会社がこれまでの被保険者の死亡率を基にした死亡表「日本3会社生命表」を作成した。これは、わが国最初の経験死亡表であり、それまで明治生命、帝国生命などが使っていた「英国17会社表」、日本生命が使っていた「藤沢氏表」と比べ、実際の死亡率に近いものであった。

（3）第一次大戦前後

1914年（大正3年）に第一次大戦が起こったが、日本は直接に戦禍を受けず、むしろ物資補給国として、経済は活況を呈した。この時期に日本の資本主義経済も一応の基礎を固め、生命保険事業も大きく成長した。

一方、資本主義の発達とともに、社会運動が盛んに行われ、政府としても労働者の福祉対策を考える必要に迫られた。すでに、明治の末から検討されていたことであるが、1914年（大正3年）に当時の大隈内閣が社会政策のひとつとして、小口の生命保険を官営によって提供する方針を決定し、通信省が運営に当たることになった。この保険は外国の簡易保険に範を取ったもので、無診査、月払いの契約で最高保険金額を250円という低額に限定した。

大正時代、保険の有用性を人々に認識させる大きな出来事が2つあった。スペインかぜの大流行と関東大震災である。

スペインかぜでは、1920年（大正9年）までに22万人を超える犠牲者が出た。続いて、1923年（大正12年）の関東大震災では、東京府、神奈川県を中心とする1府4県下で、焼失・家屋倒壊は約60万戸、死者10万人に及び、大震災による全社の支払い保険金は約5,600件、700万円余にのぼった。

スペインかぜや関東大震災に際して生命保険会社が多額の保険金を支払い、その使命を果たしたことで、生命保険の必要性和その役割が新たに認識されたため、その後生命保険契約高は一段と伸展した。

大正末期になって生命保険会社の間で新契約獲得競争にさらに拍車がかかった。そして、従来、全国各地の代理店を通じて、生命保険契約の募集を行っていた多くの会社は、その営業組織を強化するため、代理店に所属していた営業職員を会社直属に改めるとともに会社専属の営業職員制度を採用して、いわゆる代理店方式から会社専属の営業職員制度に変更した。そして、これが生命保険の普及に役立ったが、一方各社の競争は激化した。

この頃から、日本生命、千代田生命、第一生命、明治生命、帝国生命の5社への契約の集中傾向が強まり、1930年（昭和5年）には新契約高で54%の占率、保有契約高で51%を占めるに至った。

その後も業界競争は熾烈化し、不正な募集活動によって、世間の批判を浴びるようになった。このため、1931年（昭和6年）に商工省令によって、保険募集取締規制が施行されることになった。

また、保有契約の増大に伴い、生命保険会社の資産も増大し、金融機関としての地位も高まり、1935年（昭和10年）末には全金融機関の10%の資金量を占めるまでになった。これは全国銀行、政府の資金運用部に次ぐ規模のものであった。

(4) 保険種類の変遷

日本における保険種類の歴史的推移を保有契約高でみると、最初は終身保険が大半を占めていたが、その後、養老保険が増加し、明治30年代には養老保険と終身保険は50%ずつの割合となり、明治の末期には終身保険は1/3に減少し、大正の末期になると終身保険は1割にも満たなくなった。その後この傾向は昭和20年代まであまり変化はみられなかった。

このように、終身保険が減少して養老保険が保険契約の主流を占めるようになったのは、養老保険が持つ貯蓄機能がより高く評価され、一方で、より多くの保障機能を持っている終身保険に対する需要が少なかったからである。

その理由としては、第一に家族制度や家業の世襲制を中心とする生活保障制度や封建的な慣習やものの考え方が強く残っており、独立した近代市民としての生活と思想が確立されていなかったこと、第二に死に対する因習縁起が残っており、死亡保障について割り切った考え方が持ちにくかったこと、第三に伝統的に貯蓄思想が強かったことが挙げられる。さらに保険会社としてもこれら公衆の生活態度や考え方に対応して理解されやすい養老保険に主力をおいた募集政策を採ったことにもよると考えられる。

(5) 第二次大戦

1941年（昭和16年）、第二次大戦に突入するに伴い、あらゆる産業、金融、教育機関などはすべて厳しい戦時体制下におかれた。生命保険会社も大量の国債引受けや、軍事産業への投資を強いられることになった。

また、政府は戦時財政上、統制経済を強化するとともに消費を抑えるために「国民貯蓄奨励運動」を行ったが、「国民貯蓄は生命保険から」などのスローガンのもとに生命保険会社も政府に協力した。政府は金融機関の統制を図るために、金融統制団体令を公布した。これに基づき、1942年（昭和17年）に生命保険統制会が作られ、生命保険事業は、こ

の統制会の下に戦時体制に一層協力することになった。

(6) 戦後混乱期から再建への足どり

① 再建への道

1945年（昭和20年）8月15日、日本は連合軍に無条件降伏をし、第二次世界大戦は終了した。敗戦後の経済は物資が不足し、インフレーションは急速に進み、大きな混乱に陥った。また社会、政治情勢も不安定であった。

生保業界も台湾、朝鮮などにおける巨額の在外資産の喪失、インフレによる事業費の増大や保有契約価値の減少、戦時補償の打ち切りなどで大きな痛手を受けた。

このため、1946年（昭和21年）、金融機関再建整備法により、生命保険会社の資産、負債が新・旧勘定に分離され、旧勘定を整理の対象とするとともに、新勘定で再建整備を行うこととなった。この際、多くの会社が第二会社を設立し、再出発を図ることとした。

そして、第二会社設立に際し、多くの会社が株式会社から相互会社へと組織変更した。

再建の第一歩は新契約の増加を図ることであったが、これは新会社の基礎を作るためには必要不可欠なものであった。さらに多くの部門で事業費の合理化を図って、会社再建が進められた。

② 本格的再建

1950年（昭和25年）の朝鮮戦争による「特需ブーム」を契機として、日本経済は復興の道を歩み始めた。

生命保険会社の本格的再建はこの朝鮮戦争以降のことであるが、その再建の足どりを以下に述べることとする。

敗戦による国民所得の低下により、保険料負担能力は弱まり、年払、半年払に限っていた民間の生命保険会社の新契約成績は著しく低下した。

こういった状況の下で、小口の集金を伴う月払いの生命保険は戦前、簡易生命保険法により官営の独占事業とされていたが、1946年(昭和21年)に同法が改正され、民間の生命保険会社でも取り扱うことができるようになり、1949年(昭和24年)以降、多くの保険会社がこの分野に進出した。

この月払保険では、生命保険会社の営業職員が一定の担当地区を持ち、その地区内の新契約の募集と集金活動を並行して行うデビット・システムと呼ばれる方法が導入された。この導入に伴い、新たに女性を中心とした営業職員が大量に採用された。家庭訪問という活動が女性に向いていたこと、また戦後復興期で男性が求人難であったことがその理由であった。

日本の工業化の進展に伴い、勤労者の数は著しく増大し、企業による福祉制度が発展した。これに伴い各保険会社では、1948年(昭和23年)以降、企業の福祉制度として団体定期生命保険の利用を進めた結果、年々その契約高は伸展した。

人口の都市集中と核家族化の傾向は著しくなり、封建的な大家族制度が崩壊し、死亡保障の必要性が一般に認知されるようになってきた。このような死亡保障のニーズが生まれたことは、生命保険種類に大きな転換をもたらした。1955年(昭和30年)になってこの死亡保障ニーズに対応して、従来の養老保険の保障部分を増大した定期付養老保険が発売された。

その後、日本経済の発展とともにこの風潮は高まり、それに伴い、定期付養老保険の新契約に占める割合は年々増加した。こうした業界の努力と経済成長、さらに生命保険に対する需要の高まりにより1958年度(昭和33年度)末の保有契約高は4兆4,640億円となり、国民所得に対する保有契約高の割合は94%と、戦前の最高水準まで回復した。

1962年(昭和37年)には、企業の福祉制度に役立つ企業年金保険が発売され、また1966年(昭和41年)には国の行う厚生年金保険と

タイアップして厚生年金基金制度が始められた。

(7) 生命保険事業の革新

① 保険審議会の設置

昭和30年代になって、経済成長と生活保障に対する需要の高まりに呼応した業界各社の努力により、生命保険事業は戦後の痛手から立ち直り、着実な発展を遂げた。そして国民生活の福祉と産業経済の発展に大きな役割を果たすようになった。

このように、大きな社会的責任を持つに至った生命保険は、一方では、一般消費者の意識の高まりから厳しい批判を受けることになった。殊に一般消費者と直接関係を持つ生命保険募集人である生命保険会社の営業職員（外務員）の中には知識・訓練等が不十分な者も多く、また、その扱う契約の継続率が不良であることが、鋭く指摘され始めた。そこで生命保険業界としても従来の量的拡大政策を反省し、契約者指向に立脚した質的改善の重要性を認めその努力を開始した。

こうした状況を背景として、1959年（昭和34年）に、保険制度の改善に関する事項と、保険行政に関する重要事項などを審議するために、大蔵大臣の諮問機関として「保険審議会」が設置され、学識経験者、一般消費者を委員として審議が開始された。

この保険審議会は、1962年（昭和37年）に、「生命保険計理に関する答申」、「生命保険募集に関する答申」を大蔵大臣に行った。「生命保険募集に関する答申」は、前述のような営業職員に対する一般消費者の批判を受け、営業職員の質の向上、契約者の保護を指摘している。

この答申に基づいて、1963年（昭和38年）から、生命保険協会による外務員試験が実施され、また、契約者の保護を図るため、契約の内容等を説明した「ご契約のしおり」の交付も行われることになった。

その後、1973年（昭和48年）には、専業外務員の育成を目標とした業界共通教育制度が確立され、各社の営業職員の採用時における選別の強化、教育訓練の充実、外務員試験の改正が図られた。

（注）外務員試験は、この後に初級課程試験と名称を変更し、さらに1990年（平成2年）からは一般課程試験となった。

その後、1975年（昭和50年）6月に保険審議会は、「今後の生命保険事業のあり方」について大蔵大臣に答申を行い、

- （i）契約者の理解と信頼確保の経営理念の徹底
- （ii）消費者のニーズに応える保険商品の開発普及
- （iii）経営効率の競争を通ずる契約者負担の軽減
- （iv）募集秩序の確立

を図り、生命保険事業の社会的責任を遂行するとともに、特に物価上昇状況下での厳しい経営環境の克服に努めるよう提言し、募集制度、保険商品、保険計理、資産運用および会社の運営等、多岐にわたり問題をとり上げ、その改善策などを指摘した。

（注）なお、1998年（平成10年）以降の省庁組織の再編の流れとともに「金融審議会（首相の諮問機関）」に引き継がれ、現在では新しい審議体制（テーマ別の部会や保険ワーキンググループでの検討等）のもと生まれ変わっている。

② 営業職員教育の充実、商品開発、消費者対応

1975年（昭和50年）の答申に基づき、1976年（昭和51年）には「生命保険の募集体制に関する整備改善3カ年計画（募体三計画）」がスタートした。この計画は、

- （i）既存の副業的営業職員を専業外務員として育成すること
- （ii）中核となる基幹外務員を育成すること
- （iii）生命保険契約の継続率を改善すること

を内容としている。見た目には従来の取り組みと大きな違いはないが、

最大の相違点はそれぞれの目標を達成するため、各社に具体的な改善計画の策定とその実行を義務付けた点にある。

この募体三計画は、1976～78年度（昭和51～53年度）の第1次計画のあとも引き続き第2次計画（1979～81年度（昭和54～56年度））、第3次計画（1982～84年度（昭和57～59年度））と実施され、1985年度（昭和60年度）からは最終の第4次計画が実行に移された。この募体三計画は、内容的にも回を追うに従って達成すべき水準の設定が厳正化されるとともに、年間の登録枠制度を導入したり、募体三計画と社内経営計画との連動を義務付けるなどの工夫がなされた。また、結果については、年度毎にフォローされ、目標が達成できない場合は、翌年度の登録枠設定に際してペナルティが課せられた。

1988年度（昭和63年度）からは、募体三計画のあとを受けて、「募集体制の整備改善自主計画」がスタートした。これは、生保各社の中長期の業務計画と関連させ、当局の提示するガイドラインを達成するまでの期間を各社が自主的に設定して取り組むものである。

（注）上記自主計画は「ポスト募体三」と呼ばれたが、この時に専業外務員は専業職員、基幹外務員は基幹職員に改められている。

募体三計画のほかにも、昭和50年答申に沿うものとして、中途増額制度の実施（1974年（昭和49年））、物価指数にリンクして保険金額を増額させる物価指数保険の発売（1975年（昭和50年））等、消費者のニーズに応える種々の商品の開発や、クーリング・オフ制度の実施（1974年（昭和49年））、消費者への情報提供機関「生命保険文化センター」（1976年（昭和51年））の設立（後述）等様々な措置が講じられている。

③ 消費者へのPR活動

生命保険に関する情報提供や消費者意見の聴取に関する努力も続け

られている。生命保険協会では法令で定められた項目のほかに自主的に開示すべきと判断した項目を加えた「ディスクロージャー開示基準」や比較を容易とするための統一様式「ディスクロージャー要綱様式モデル」を作成している。

また、生命保険商品の内容を理解するために必要な事項を説明した「契約概要」、契約するにあたって特に注意すべき事項を説明した「注意喚起情報」、約款中の重要な事項・諸手続きなどを説明した「ご契約のしおり」とともに保険約款を契約申込時に交付したり、インターネットによる幅広い情報提供を行っている。この他、消費者の意向の把握のために各社で地域別の「契約者懇談会」や「モニター制度」などを実施している。

ちなみに、相互会社では、契約者の意向を会社の経営に反映するため、株式会社の株主総会に相当する契約者（社員）代表で構成される総代会有るが、この総代候補の選考は、総代会で選ばれた社外の第三者からなる選考委員会で行われ、その選考にあたっては広く契約者の意見が反映されるよう契約者の地域別分布に応じて定員数を定めるとともに、年齢、職業なども考慮して、各階層から公平に選考されることとなっている。

また、会社経営内容を契約者に公開し、その努力に対する理解を得るため総代会の傍聴制度を実施しているほか、総代の選出にあたり、信任投票制度の導入が行われた。

生命保険に関する各種の相談や苦情を受け付けている窓口が全国各地の生命保険協会や、会社の本・支店に設けられているが、特に生命保険協会には、「生命保険相談所」が設けられ、会社側との話し合い・斡旋の場を提供している。そこで解決しない場合は、学識経験者などの第三者で構成された「裁定審査会」に委ねられる。「裁定審査会」では、苦情や紛争を公平な立場で裁定し、契約者の利益の保護を図っている。な

お、2010年（平成22年）4月1日より「金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ADR制度）」が設けられたが、生命保険協会は生命保険相談所の「裁定審査会」をベースに保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として指定を取得し、2010年（平成22年）10月1日より保険契約者等と生命保険会社との間で生じたトラブルにつき、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

また、生命保険業界と社会をつなぐ総合的情報センターとして、1976年（昭和51年）に財団法人「生命保険文化センター」（2011年（平成23年）4月1日より公益財団法人）が設置された。同センターは公衆の人々の生命保険に対する意識や意向を的確に把握し、それに応じた適切な情報を公正な立場から提供して、人々と生命保険業界間の相互理解を促進するための活動を行っている。また相談窓口も設け、消費者の生命保険設計にも役立っている。

（８）生命保険事業の現状

① 高度成長から安定成長、そして再編へ

戦後、世界的にも希有の高度成長を遂げてきた日本経済であるが、1973年（昭和48年）の第一次石油危機を契機として経済成長率はほぼ半減し、安定成長段階に入った。その後、1979年（昭和54年）の第二次石油危機、1985年（昭和60年）のプラザ合意による円高といった外的ショックにもかかわらず、基本的には着実な成長経路をたどった。1986年（昭和61年）11月からの「平成景気」は株価、地価の異常な上昇（いわゆる「バブル」）を伴った長期の景気拡大となったが、1991年（平成3年）4月を境に後退を始めた。平成景気における過剰な設備投資、資産価格の下落によるバランスシートの悪化等から景気後退は長期、大幅なものとなった。

表2. 保有契約高と国民所得の動き

(単位：兆円)

年度	保有契約高		国民所得	
	(保険金額)	増加率		増加率
H 6	2,098	3.8	379.9	—
7	2,153	2.7	386.7	1.8
8	2,175	1.0	401.0	3.7
9	1,969	▲9.5	395.3	▲1.4
10	1,909	▲3.0	380.0	▲3.9
11	1,860	▲2.6	377.5	▲0.6
12	1,802	▲3.1	392.5	4.0
13	1,734	▲3.8	379.0	▲3.4
14	1,675	▲3.4	374.6	▲1.2
15	1,609	▲3.9	379.9	1.4
16	1,569	▲2.5	385.6	1.5
17	1,532	▲2.4	383.6	▲0.5
18	1,485	▲3.0	391.6	2.1
19	1,443	▲2.8	392.7	0.3
20	1,404	▲2.7	361.1	▲8.1
21	1,370	▲2.4	349.7	▲3.2
22	1,347	▲1.7	362.2	3.6
23	1,335	▲0.9	355.6	▲1.8
24	1,335	0.05	357.4	0.5
25	1,333	▲0.15	372.9	4.3
26	1,335	0.16	379.1	1.7
27	1,337	0.2	395.9	4.4
28	1,350	1.0	394.9	▲0.2
29	1,342	▲0.6	403.1	2.1
30	1,345	0.2	408.6	1.4
R1	1,331	▲1.0	402.8	▲1.4
2	1,322	▲0.7	379.1	▲5.9
3	1,317	▲0.4	403.1	6.3
4	1,307	▲0.8	419.1	4.0
5	1,309	0.2	441.4	5.3
6	1,304	▲0.4	452.0	2.4

(注) 保有契約高は、個人保険、個人年金保険、団体保険の合計。

平成19年度以降は、保有契約高にかんば生命分を含む。

個人年金は年金支払開始前契約の年金開始時における年金原資および年金支払開始後契約の責任準備金の額を合計したものを保険金額としている。

※国民経済計算方法の改訂(2020年基準)は平成6年度以降の数値に遡及適用し反映している。

資料：生命保険協会「生命保険事業概況」、内閣府「2024年度(令和6年度)国民経済計算年次推計」

生命保険事業も、景気変動の影響を強く受けており、昭和40年代は新契約高の増加率は20～30%程度で推移していたが、昭和50年代は、おおむね1桁台で推移した。第二次石油危機による景気悪化がみられた1979、80年度（昭和54、55年度）においては殊に低迷の色が濃く、また1984年度（昭和59年度）においては増加率がマイナスになったが、その後、景気の拡大を背景に1986～88年度（昭和61～63年度）の3年間は2桁台の伸びを示した。この間、商品も定期付養老保険から定期付終身保険へ主流が移り、昭和60年代に入ると予定利率が5.5～6.25%と高く設定されたことから、顧客にとって各種の金融商品の間で相対的に有利になった一時払養老保険、個人年金保険など商品の多様化がみられるようになった。その後、1992年度（平成4年度）以降新契約は伸び悩んだ。長引く景気停滞で1997年度（平成9年度）以降には金融機関の破綻が相次いだ。

中でも、超低金利という経済環境は、生命保険会社の運用利回りが予定利率を大幅に下回るという「逆ざや」問題を深刻化させた。長期にわたるこの経済環境により、遂に1997年（平成9年）に戦後初の、生命保険会社の破綻が発生した。この破綻は人々の生命保険会社への不安を増大させ、1997年度（平成9年度）の生命保険業界の保有契約高は戦後初めて減少に転じた（その後も直近まで減少が続いている）。2000、01年度（平成12、13年度）にも、逆ざやに耐え切れなくなった生命保険会社の破綻が相次いだ。これらの破綻生保は外資系生保に継承されるなど、生命保険会社の再編が生じた。

一方で、生命保険会社同士の合併や戦略的提携による経営強化の動きが顕著になり、従来の相互会社形態から株式会社化する生命保険会社もあった。

表3. 破綻生命保険会社とその後の現状

会社名	破綻年月	総資産	受け皿会社（スポンサー名）	現状
日産生命	H9年4月	2.2兆円	あおば生命（アルテミス）	ブルデンシャル生命と合併
東邦生命	H11年6月	2.7兆円	GEエジソン生命（GEキャピタル）	AIGエジソン生命（AIG） → H24年1月ジブラルタ生命と合併
第百生命	H12年5月	1.7兆円	マニユライフ生命（マニユライフ）	現在に至る
大正生命	H12年8月	0.2兆円	あざみ生命（大和生命・ソフトバンク）	大和生命と合併（H20年破綻）
千代田生命	H12年10月	3.5兆円	AIGスター生命（AIG）	H24年1月ジブラルタ生命と合併
協栄生命	H12年10月	4.6兆円	ジブラルタ生命（ブルデンシャル）	現在に至る
東京生命	H13年3月	1.1兆円	T&Dフィナンシャル（大同・太陽生命）	現在に至る
大和生命	H20年10月	0.3兆円	ブルデンシャルファイナンシャルジャパン生命	ブルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命

※総資産は直前決算期。

② 外資系生命保険会社の進出

1972年（昭和47年）12月、アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーが外国生命保険会社として戦後初めて日本人向け円建保険の販売許可を受け、日本人市場への進出を行った。

以来、多くの外資系生命保険会社が進出している（詳しくは生命保険協会ホームページ「生命保険会社変遷図」を参照）。これらの会社は、無配当定期保険、がん保険、代理店活用、通信販売といった特徴を備えて営業を開始した。これらの外資系生保の進出は、内国会社の個人定期保険、疾病保障商品の開発・販売等の新規分野への進出を促す契機となった。

③ 昭和60年保険審議会答申

昭和60年代以降、生命保険事業を巡る経済社会環境の変化としては、金融の自由化・経済のストック化・女性の社会進出等が起きており、特に高齢化社会を迎えて老後への不安が高まってきている。

これらの環境変化に先行して生命保険事業のあり方を模索するために、保険審議会は1984年（昭和59年）に総会を開催し、1985年（昭和60年）5月に「新しい時代に対応するための生命保険事業のあり方」と題する答申を行った。

60年答申では、生命保険事業を巡る環境変化として、

(i) 金融の自由化、国際化の進展

(ii) 高齢化社会への移行

(iii) 高度情報社会の到来

を指摘し、このような環境の変化の下で新しい時代に対応するための生命保険事業のあり方として、

- 多様性・自在性ニーズへの対応
- 自由化、国際化への対応
- 高齢化に対応した年金ニーズへの対応
- 医療・福祉ニーズへの対応
- 情報化、システム化への対応

を求め、むすびとして、経営の特色化と行政の弾力化を要望している。

この答申は、経営全般にわたる今後の方向を示し、「各社の創意工夫と自己責任原則に基づいた自主的な経営判断」を一段と求める内容のものであった。

④ 関連業務への進出

生命保険事業を巡る動きの1つとして、関連会社に対する規制の緩和が挙げられる。

昭和20年代後半以降、生命保険会社の関連会社として、不動産関連会社、印刷等の事務代行会社等が設立されるようになった。その後、昭和50年代後半に至るまで、信用保証業務を除いて大きな業務範囲の拡大は行われなかった。その後、1983年（昭和58年）に、リース業務が認められたのを初め、抵当証券業務、投資顧問業務（1985年（昭和60年））、クレジットカード業務、アスレチッククラブ（1986年（昭和61年））、消費者ローン業務、情報処理・VAN業務、健康・福祉関

連事業（1987年（昭和62年））と順次緩和されてきている。現在では、ベンチャーキャピタル業務、ファクタリング業務、証券投資信託業務等も認められており、金融関連業務を幅広く行っている（後述第4章2、第6章2（5）参照）。

⑤ 保険料率の変遷

生命保険会社では、戦後一貫して最新の死亡率の使用、経営効率の改善による事業費の節減、運用の効率化による予定利率の引き上げにより保険料を引き下げるとともに、経営努力を重ねることによって契約者配当を充実させて、契約者の払い込む保険料負担の軽減を行う努力を行ってきた。

国民生命表によると女子の死亡率は男子より低くなっているため1976年（昭和51年）3月以降の契約から女子加入者の保険料を男子加入者のそれよりも低い年齢の保険料を採用（セット・バック方式）していたが、第3回全会社表（1981年（昭和56年）4月）から初めて男女別の保険料表を作成、さらに科学的かつ公平な保険料負担を実現し、加入者負担の軽減を図ることとした。

さらに、1987年（昭和62年）4月からは保険料口座振替扱いの月払契約について、あらたに設定した口座振替保険料率を適用し、平均1.5%程度の保険料引き下げを実施するとともに、加入者数20名未満で普通保険料を適用していたB扱団体^{（注）}についても、同水準の料率引き下げを実施した。

（注）個人保険の団体扱いは、団体の種類、契約者人数によって「A扱」および「B扱」等に区分され、それぞれ適用される料率が異なる。

また、生命保険会社は、保険料の引き下げとともに契約者配当の充実にも格段の努力をしてきた。1972年度（昭和47年度）からは、一

定年数経過して満期，死亡，解約などで消滅する契約に対しての，消滅時配当が導入された。

しかしながら，平成に入って以降は，予定利率の引き下げによって保険料率はおおむね上昇基調をたどることになる。1993年度（平成5年度）には資産運用環境の悪化による予定利率の引き下げと，経営合理化による予定事業費率の引き下げが大手生命保険会社を中心に行われた。この結果，予定利率の影響の少ない保障性の高い商品など一部では若干保険料が下がるものの，その他の商品は保険料が上がることになった。また，環境悪化の継続により1994年（平成6年）にも予定利率の引き下げが行われた。

1996年（平成8年）4月には，改正保険業法の施行により標準責任準備金制度（26頁参照）が導入されたが，予定利率（標準利率）の引き下げと併せて，予定事業費率，予定死亡率を改定することにより，保険料の値上げ幅を抑えた。また1996年（平成8年）10月の損保の生保子会社参入に伴い，新たに準有配当保険が導入された。なお，1999年（平成11年）4月以降においても，多くの会社では予定利率の引き下げを行っている。

2007年（平成19年）には，11年ぶりに生保標準生命表が改定された。生保標準生命表には，従来，死亡保険用と年金開始後用とがあったが，医療保険など第三分野用の標準生命表が策定された。第三分野用のものは，死亡保険用のものに比べて死亡率は低く設定されている。

この標準生命表の改定を受けて，生命保険会社では，保険料の改定を行っている。死亡率の低下によって，定期保険や終身保険などの死亡保険では保険料が引き下げられた。一方，寿命の延長にともなって保険会社からの支払いの増加が見込まれる終身年金では，保険料が上

がることになった。同じく死亡率の低下によって支払いの増加が見込まれる医療保険では、対象となる病気の発生率を見直すことによって、また今後の需要の増加を見込んで、現行水準を維持したり、逆に若干引き下げたりするケースも多かった。2018年（平成30年）の同改定では、続く死亡率の低下に伴う死亡保険用と第三分野用の生保標準生命表が再度見直されたが、年金開始後用の標準生命表は据え置かれ、同年4月以降の締結契約分から適用された。

また、標準利率は、2013年（平成25年）4月に標準利率が12年ぶりに引き下げられた（1.5%→1.0%）。さらに、近年の日本銀行によるマイナス金利を含む金融緩和政策もあり、低金利が続く現状から2017年（平成29年）4月には0.25%まで引き下げられている。

ただし、この標準利率は過去の10年国債の応募者利回りをもとに設定されることから金利感応度はあまり高くなく、各社では標準責任準備金を積み立てることができるような保険料設定に配慮している。その結果、貯蓄型の商品（高齢者向けの商品や終身保険等）を中心に一部保険料が引き上げられたが、各社の対応にはばらつきがあり、今後の商品開発や販売政策によって異なる各社料率の決定も進んできている。

（注）標準責任準備金制度の導入（26頁参照）により、責任準備金の積立方法等を「平成8年大蔵省告示第48号」において定めているが、その後の運用環境や運用手法・販売商品等の状況変化を踏まえ、2014年（平成26年）にその一部が改正された（2015年（平成27年）4月以降の締結契約は一時払契約が明確に区分され、当該責任準備金の計算上使用する予定利率の改定方法も変更された）。

⑥ 金融制度改革と平成4年保険審議会答申

金融界では、いわゆるグローバリゼーションとセキュリティゼーションという2大潮流により、従来の銀行・証券の区分にそぐわない

グレーゾーンの登場や、相対的に規制のゆるい海外市場での起債増加といった現象を招いた。その結果、専門制、分業制を基本として各業態ごとに業務内容を規制されている既存の金融制度では環境の変化に対処できなくなった。

このことを背景に金融制度調査会、証券取引審議会、外国為替等審議会の金融関係の審議会が開かれ、現制度について見直しが行われることになった。1991年（平成3年）6月には、金融制度調査会、証券取引審議会は金融・証券制度に関する最終報告書を取りまとめ、その中で、業態別子会社方式により銀行、証券、信託銀行間の相互参入を進める方向が示された。

それを受けて、1992年（平成4年）6月の通常国会において業態別子会社方式による相互参入、資本市場の健全な発展を主要内容とした「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」（金融制度改革関連法）が成立、本格的な改革が行われることになった。

一方、保険審議会では「保険事業の在り方及び保険関係法規の見直し」について1989年（平成元年）6月より審議を開始し、1992年（平成4年）6月に最終報告書「新しい保険事業の在り方」を答申として取りまとめた。

審議会では、見直しにあたり、

- （i）規制緩和、自由化による競争の促進、事業の効率化
- （ii）健全性の維持
- （iii）公正な事業運営の確保

の3つの指針に従って検討が行われた。答申の主な点は以下のとおり。

ア）業態別子会社方式による他業態との相互参入

金融制度改革に歩調を合わせ、銀行、証券などの金融他業態への

相互参入は「業態別子会社方式が妥当である」とされた。

イ) 生損保間の相互乗り入れ

基本的には子会社による相互乗り入れ，傷害・疾病・介護分野（第三分野）では同質化が進んだため本体での相互乗り入れの方向が示された。

ウ) 一社専属制の見直し

従来の生命保険の販売チャネルは一社専属の営業職員，損害保険では乗合可能な代理店が主力となっているが，一社専属が法律で規定されている生命保険のチャネルについても乗合可能とする方向で見直していく。

エ) 料率・配当の自由化

生命保険の保険料率は大蔵省（当時）の認可制になっていたが、「部分的には認可制を止めて届出制に移行するのが望ましい」とされた。また，損害保険の料率に関しても一部自由化するよう求められている。

オ) 新たに広がる業務（資産運用手段，業務）

以下については，保険会社の「本体で行えるようにするのが望ましい」との方向が示された。

- (i) 外貨建ローン
- (ii) 債務保証
- (iii) 社債の受託
- (iv) 公共債ディーリング
- (v) 私募の取扱い
- (vi) 証券化関連商品の取扱い
- (vii) CP・銀行借入のような短期資金調達

以上のほかに，保険会社形態の在り方や，保険経理の見直し等についても報告されている。

この審議会答申は，中・長期的かつ広範な視点から保険事業に関

する基本事項を審議して出されたものであるが、従来制度について抜本的に見直しを求めている点や、生・損保の兼営問題を含め、保険業界と他の金融機関との関係について議論している点が、これまでの答申と異なる最大の特徴といえよう。

⑦ 保険業法の改正

保険審議会の答申を受け、法制的な観点から専門的な検討を行うために法制懇談会が設置され、1994年（平成6年）6月に「保険業法等の改正について」と題する報告書がまとめられた。この報告書に基づき1995年（平成7年）6月に保険業法が抜本的に改正され、1996年（平成8年）4月より施行された。この改正保険業法が現在の保険業法の骨格をなしている（149頁参照）。

改正の大きな柱は、子会社形態による生・損保の相互参入である。当初の審議会報告で検討された他業態との相互参入については、まず、生・損保の相互乗入れや商品の多様化等の保険制度の自由化を進めた後の課題として、段階的に行うことが適当とされた。

行政の監督手法も、自由化の流れに沿って、これまでの行政指導主体の監督から、市場原理に基づいた監督が求められることとなった。新しく保険業法に盛り込まれた、健全性維持のためソルベンシー・マージン基準（自己資本比率規制）、経営危機対応制度、情報開示についての規定は自由化後の新しい監督手法として位置づけられる。

また、規制緩和は競争を促進するため、保険会社が直面するリスクが高くなり、経営の危機に追い込まれる保険会社が出現する可能性もある。このため破綻した会社の契約を健全な会社に移転するような経営危機対応制度が定められ、それをバックアップするものとして、保険契約者保護基金が設立された。

法律改正を要しない部分についても、規制緩和の流れを受け、順次それまでの規制が撤廃された。1994年（平成6年）には、CP発行が認められ、短期的な市場資金を調達することが可能となり、突発的な保険金支払需要に柔軟に対応することにより、効率的な業務運営が図られることとなった。

⑧ 日本版ビッグ・バンと平成9年保険審議会報告

1996年（平成8年）11月、総理大臣より大蔵大臣に対して、内閣の最重要課題の一つとして、2001年（平成13年）までに日本の金融市場をニューヨーク・ロンドンに並ぶ国際金融市場とすることを目指す金融システム改革に全力を挙げて取り組むよう指示が出された。この改革は、フリー、フェア、グローバルの3原則に則り、①参入・商品・価格等の自由化、②ルールの明確化・透明化、投資家保護、③グローバル化に対応した法制度、会計制度、監督体制の整備、を実現することを目的としている。イギリスの証券市場改革が「ビッグ・バン」と呼ばれたことから、「日本版ビッグ・バン」と呼称されている。

これを受けて、保険審議会では、基本問題部会において、保険業および保険監督行政における基本的な問題について検討を行い、1997年（平成9年）6月、「保険業の在り方の見直しについて—金融システム改革の一環として—」を報告した。主な点は次のとおり。

ア) 業態間の参入促進

保険会社による銀行・信託・証券業務への参入および銀行・信託銀行・証券会社による保険業への参入については、これまで培ってきた経営資源やノウハウ等を基礎に、業務の適正な遂行が見込まれるとともに、利用者の多様化・高度化するニーズに応えることが期待できるため、制度面では2001年（平成13年）までに実

現を図るべき。

参入方式については、リスク管理、利益相反行為による弊害の防止等を勘案して、業態別子会社方式が適当である。

イ) 持株会社制度の導入

日本では戦後一貫して、持株会社の設立が禁止されてきた。しかし、持株会社は、組織形態の選択肢の拡大をもたらすものであり、持株会社傘下の兄弟会社間でシナジー効果も期待できるため、多様化・高度化する利用者ニーズに的確に対応してゆくことが期待される。持株会社の導入は、保険業においても重要な役割を担うものと考えられるが、一方で、保険契約者の保護、保険会社の健全性確保のため、効果的な監督の枠組みを構築する必要がある。

相互会社が持株会社になることについては、相互会社の基本的性質から問題があり、持株会社は株式会社とする。相互会社が持株会社となるためには株式会社への組織変更が必要となる。持株相互会社制度については、諸外国の動向を見守っていく必要がある。

ウ) 銀行による保険販売の問題

銀行による保険販売については、販売チャネルの多様化、効率化等が図られるとともに、ワンストップ・ショッピングのニーズにも対応し、利用者利便の向上につながると考えられる一方、銀行がその優越的地位や影響力を行使することにより、顧客保護、競争条件の公平性確保の観点から弊害が生じるおそれがある。

これらを踏まえ、2001年（平成13年）を目処に、銀行がその子会社または兄弟会社である保険会社の商品を販売する場合に限定したうえで、住宅ローン関連の長期火災保険および信用生命保険の販売を認めるのが適当である。

(注) 銀行窓販については第5章2(3)で詳しく述べるが、現在ではすべての保険商品の窓販が可能となっている。

⑨ 日産生命の破綻

1997年(平成9年)4月25日、大蔵省は日産生命に対し、生命保険会社としては戦後初の業務停止命令を出した。この結果、新契約の募集はもちろん、既契約の解約、減額、契約者貸付も即日停止し、生命保険協会が管理人になり、清算段階に入った。

生命保険協会は同年6月、次のような破綻処理策を作成し、同年7月30日に開催された日産生命総代会でこの処理策が決議された。

- 日産生命の全契約を、その契約の維持目的で生命保険協会が設立した「あおば生命」に移転する。
- 移転に際しては、責任準備金は全額保護するか、将来に向けて予定利率の引き下げを行う。これに伴い、保険料は変更されないが、保険金額、年金年額等は引き下げとなる。
- 既に発生している日産生命の債務超過額3,000億円のうち、保険契約者保護基金からの資金援助2,000億円で埋められない残額1,000億円については、早期解約控除制度(早期の解約の控除率を高くする制度)の導入と、あおば生命の将来の収益で補う。

こうした日産生命の破綻によって、次のような経営危機対応制度の問題点が露呈することとなった。

- 同制度では、破綻生命保険会社から救済生命保険会社への保険契約の移転を円滑に実施するために、保険契約者保護基金から資金的バックアップが行われることになっているが、これは救済生命保険会社が現れないと機能しない。日産生命の場合

では救済会社を作ることと決着した。

- 同制度では、支援限度額が累計で2,000億円とされたが、破綻の規模によって保険金額の削減率が変わるために、自分の契約がどこまで保証されるか不明確である。
- 日産生命の破綻で支援限度額を全部使い切ってしまう、今後は支援限度額を増額しない限りこの制度は機能しない。

⑩ 金融システム改革法の成立

日本版ビッグ・バンの法律面での枠組みとして、1998年（平成10年）6月、金融システム改革法が成立した。この法律は、国民によりよい資産運用と資金調達の道を提供するため、ニューヨーク・ロンドンと比肩しうる、自由で公正な金融システムを構築することを目的としており、金融の各業態を越えた総合的な改革を一括して行っている。その中で、保険会社に係わる内容は次のとおり。

（i）保険会社の子会社の範囲の拡大

保険会社は、生・損保子会社、銀行子会社・証券子会社等を所有できる(注)。

(注) いわゆる金融持株会社関連法によって、すでに保険持株会社（保険会社を子会社とする持株会社）の設立は可能となっていた。

（ii）投資信託の窓口販売の導入

投資信託を保険・銀行等の金融機関で購入できるようにする。このため、金融機関が証券取引法上登録を受けて、本体での投資信託の窓口販売を行うことができるようにする。

（iii）生命保険契約者保護機構の発足

旧法の支払保証制度である保険契約者保護基金に代わって、救済保険会社が現われない場合においても破綻保険会社の保険契約を引

き受ける生命保険契約者保護機構が1998年（平成10年）12月1日に発足した。破綻が生じた場合、契約者は責任準備金の90%が補償される（なお、混乱を避けるための一時的な措置として、2001年（平成13年）3月末までに支払事由の発生した個人保険・団体保険等の死亡保険金等、個人年金保険・財形保険等の責任準備金は全額補償された）。

1999年（平成11年）6月、不良債権と逆ざや（資産運用利回りが顧客に約束した保険料の運用利率「予定利率」を下回る状態）に苦しむ東邦生命が監督庁に破綻を申請し、同機構適用の最初の破綻事例となった。

（iv）早期是正措置制度の導入（後述）

ソルベンシー・マージン比率に基づいて業務停止命令を含む幅広い措置が講じられる。

⑪ 金融再生委員会の設置

1998年（平成10年）10月、金融機関の破綻によるパニックを防ぎ、セーフティネットを整備することを目的とした「金融再生法」「金融早期健全化法」が成立し、生保会社の監督も金融再生委員会が行うこととなった。

なお、2001年（平成13年）1月に中央省庁全体の再編が行われたことに伴い、内閣府の外局として金融庁が設置され、金融再生委員会は廃止された。

⑫ 早期是正措置の導入

先に不良債権処理に苦しむ銀行に対して採用された早期是正措置が、1998年度（平成10年度）決算から生命保険会社に対しても導入された。同措置は、保険金の支払い余力を示すソルベンシー・マージ

ン比率が200%未満の会社を対象となる。行政当局は、保険会社に対して、当該保険会社の「保険金等の支払能力の充実の状況によって」「当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは」、「保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める」命令を行うことができる。

⑬ 保険業法の一部改正

生命保険会社の相次ぐ破綻をうけ、生命保険契約者の保護と生命保険会社の基盤整備を目的として、2000年（平成12年）5月、「保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。この法律改正により、

①保険相互会社の株式会社化の規定整備

②会社更生法の保険相互会社への適用

③生命保険契約者保護機構の機能強化

が講じられた。

また、2003年（平成15年）7月には、既契約の予定利率引き下げに関する保険業法の改正が行われた。

これは、ある生命保険会社の保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、当該生保会社による行政への申出、社員総会（あるいは総代会）または株主総会の承認等の手続きを経て、既契約の予定利率等の契約条件の変更を可能とするものである。

（注）保険業法の一部改正については、その後も審議会答申等の内容も踏まえながら現状に則して順次行われている。2006年（平成18年）改正施行の無認可共済への法整備（少額短期保険業者（176頁参照））、2014年（平成26年）には保険募集の基本的ルール（一般的義務規定（158頁参照）等）の制定などの大きな改正もあった。

⑭ 大和生命の破綻と保険契約者保護機構への公的支援の延長

2007年（平成19年）のサブプライムローン問題から始まり、2008年（平成20年）9月のリーマンショック、その後の金融危機の中で同年10月に大和生命が破綻した。生命保険会社が破綻した場合の保険契約者の保護を目的として設立された生命保険契約者保護機構の財源は、生命保険会社各社の拠出によることが基本であるが、生命保険会社各社の拠出のみで対応困難な場合の、政府からの補助（公的支援）を受けることを可能とする規定は、金融情勢の変化に対応し的確な契約者保護を図る必要性から、2027年（令和9年）3月末まで延長されている。

（注）上記生命保険契約者保護機構への公的支援の実施については、国会審議による。

第3章 生命保険と社会経済

学習のポイント

生命保険が国民経済において果たしている役割を，生命保険会社の資産運用の面および社会保障制度との関係から理解する。

重要項目

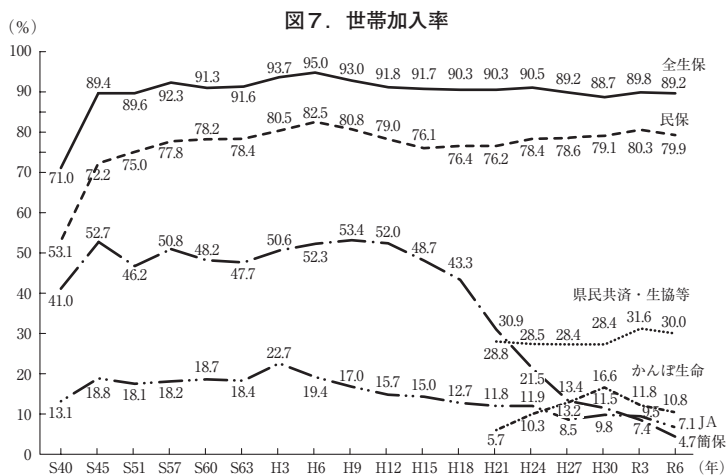
- 国民経済における生命保険
- 生命保険会社の資産運用の原則
- 生活設計としての生命保険
- 社会保険の特質

日本の生命保険事業は戦後急速に発展し、国民経済の中で大きな役割を占めるようになってきている。その役割とは、一つは生命保険契約に基づき遂行している「経済的保障機能」であり、もう一つは保険料を原資とする生命保険資産の運用による「金融機能」である。

1. 国民経済における生命保険

(1) 世帯加入状況

生命保険への世帯加入率を民間生保ベースでみた場合、1958年（昭和33年）34.8%、1965年（昭和40年）53.1%、1970年（昭和45年）72.2%と1970年頃までは極めて速いスピードで伸びてきたが、それ以降は微増基調となり、1994年（平成6年）に82.5%に達した後、停滞傾向にある（2024年度（令和6年度）



資料：生命保険文化センター「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査」

(注) 全生保は民保（かんぽ生命を含む）、簡保、JA、県民共済・生協等の計。

平成12年以前の全生保は民保、簡保、JAの計。

79.9%)。JA（農協）、県民共済・生協等を含めた全生保ベースでは、世帯加入率は約9割の水準に達しており、飽和状態であるといえよう。なお、2003年度（平成15年度）以降は、世帯加入率に県民共済・生協等を含めており、2024年度（令和6年度）調査では、全生保で89.2%となっている（図7）。

加入保険金額も順調に伸び続けてきたが、近年は減少傾向にある（図8）。

図8. 世帯の加入保険金額（全生保）

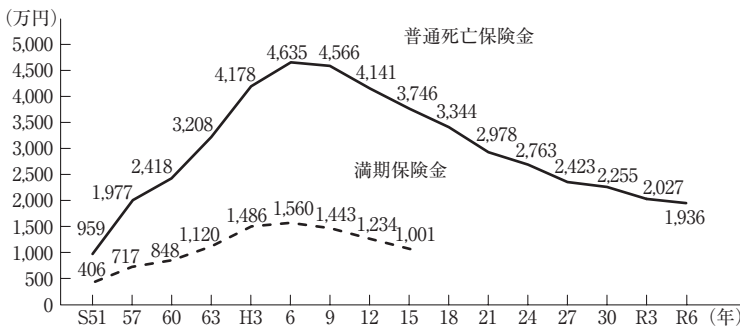
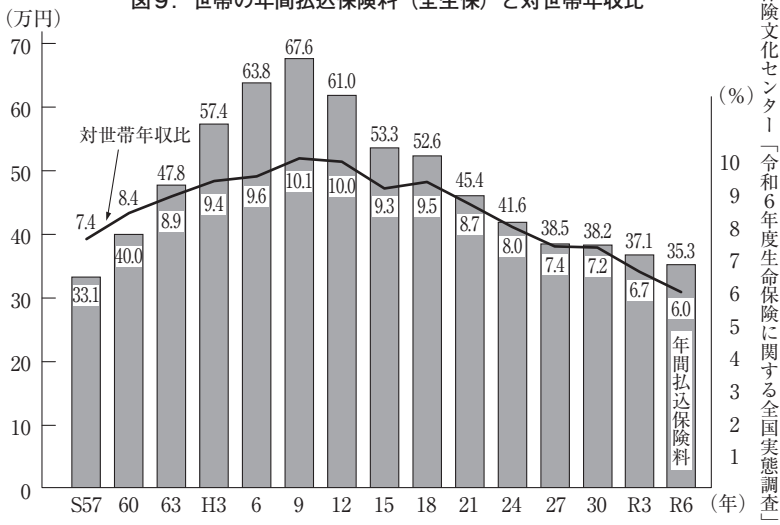


図9. 世帯の年間払込保険料（全生保）と対世帯年収比



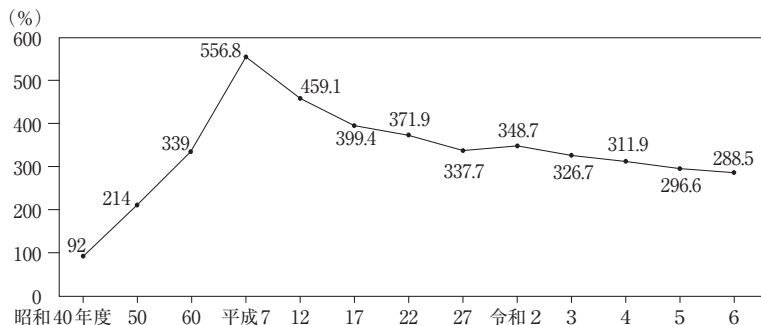
資料…図8・9とも生命保険文化センター「令和6年度生命保険に関する全国実態調査」

また、加入世帯における年間払込保険料（一時払、頭金制度による払込み、払込みの完了した契約を除く）も年々増加し続けてきたが、近年は減少傾向を示している（図9）。

（２）保有契約と国民所得との関連

2024年度（令和6年度）の民間生保の保有契約高（個人保険・個人年金保険・団体保険の合計）は、対前年微減の1,304兆円（かんぽ生命分含む）となった。保有契約高は1967年（昭和42年）に国民所得と同水準にまで達した後、さらに増加を続け、1975年（昭和50年）には国民所得の2倍、1981年（昭和56年）には3倍を超えた。一時は5倍を超えたが、近年では保有契約高の伸び悩みもあり、2024年度（令和6年度）では3倍程度である。それでも国際的にみれば、たいへん大きな保障倍率である（図10）。

図10. 保有契約高の国民所得に対する割合の推移



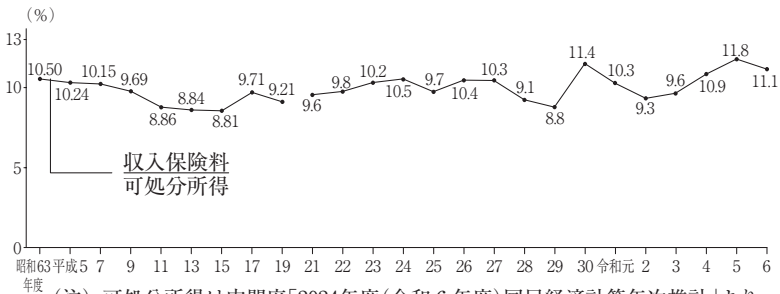
資料：生命保険協会「生命保険事業概況」

（注）国民所得については、昭和40年度までは経済企画庁「国民所得統計年報」、昭和60年度までは、内閣府「国民経済計算確報」。平成7年度以降は内閣府「2024年度（令和6年度）国民経済計算年次推計」による。

（３）保険料支出性向

家計可処分所得に対する民間生保の収入保険料の割合（保険料支出性向）は、昭和40年代が3%台、50年代には5%台、そして1988年（昭和63年）には10.5%となり、着実に伸びてきた。その後、頭打ち状態に入り、9%前後で推移していたが（図11）、2009年度（平成21年度）

図11. 保険料支出性向の推移



(注) 可処分所得は内閣府「2024年度(令和6年度)国民経済計算年次推計」より。

資料：生命保険協会「生命保険の動向」

※平成21年度以降はかんぽ生命分を含み、2020年基準の可処分所得で再計算している。

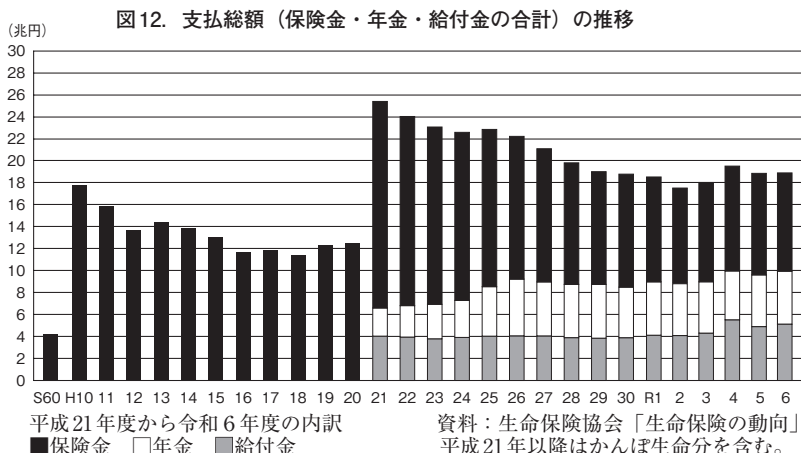
以降のかんぽ生命を含んだ民間生保の保険料支出性向では10%近い水準で推移しており、2024年度(令和6年度)は11.1%となっている。

(4) 保険金・給付金の支払い

生命保険の普及に伴い、急増してきた保険金・給付金の支払いが1999年度(平成11年度)以降減少に転じている。しかし2024年度(令和6年度)の支払総額(保険金・年金・給付金の合計)は18兆9,059億円(かんぽ生命分含む)で、これは1965年度(昭和40年度)(かんぽ生命分を除く1,156億円)の規模とは比較できないほどの金額に増大している。

また、その内訳は、1985年度(昭和60年度)に7割を超えていた保険金の占率(かんぽ生命分を除く)は、最近では5割程度に大きく後退し、給付金・年金の占率がそれぞれ上昇している。

直近のかんぽ生命分を含む支払総額の内訳をみても、給付金と年金の合計占率は、2009年度(平成21年度)の25.9%から2024年度(令和6年度)には52.1%とその割合が急増している。特に、近年の年金支払いのウエイトは拡大している。



(5) 国際比較

世界各国の生命保険契約状況について、保険料収入、保険料収入の GDP に占める割合、世界市場における保険料収入シェアをみると、日本の生命保険の普及度は高いことがわかるが、近年の高い経済成長率をもとに中国・インドを中心とした新興国がその勢いを増してきている（表 4）。

表 4. 世界各国の生命保険収入、世界市場シェアの状況(2023 年 単位:100 万米ドル, %)

順位	国名	保険料	対前年 増減率	対 GDP 占率	世界市場シェア
1	アメリカ	714,859	1.4	2.6	24.7
2	中国	390,400	12.5	2.1	13.5
3	日本	277,198	5.8	6.8	9.6
4	イギリス	236,941	2.7	7.1	8.2
5	フランス	170,098	1.1	5.5	5.9
6	イタリア	110,549	▲ 7.7	4.9	3.8
7	インド	100,185	0.6	2.8	3.5
8	ドイツ	93,325	▲ 10.5	2.1	3.2
9	韓国	84,364	▲ 12.9	5.0	2.9
10	カナダ	70,319	2.5	3.3	2.4
世界	—	2,888,998	1.3	2.9	100.0

資料：Swiss Re「Sigma 3/2024-World Insurance」より作成
(注) 対前年増減率は米ドルベースの保険料伸び率。

2. 金融機関としての生命保険会社

生命保険会社の業務には、生命保険契約の引受けに加え、契約者から集めた保険料を運用する資産運用業務がある。生命保険会社は資産運用業務を通じて政府、企業、個人の各部門に対して資金を供給しており、銀行などと同じように金融機関としての役割を果たしているのである。

(1) 生命保険会社の資金の性格

生命保険会社の資金は大別すると負債と純資産によって構成されている。

負債の大部分は保険契約準備金で、責任準備金、支払備金、契約者配当準備金から構成される。その中でも、保険料の積立金部分からなる責任準備金が大半を占めている。

生保資金の構成（2024年度（令和6年度））

単位：兆円，カッコ内は構成比で単位：％

生保資金 418.5	負債	責任準備金	338.8 (80.9)
	390.1 (93.2)	支払備金	2.2 (0.5)
純資産	28.4 (6.8)	契約者配当準備金	3.4 (0.8)
		価格変動準備金	6.5 (1.5)
		その他	39.2 (9.4)

資料：生命保険協会「生命保険の動向」
かんぽ生命分を含む

生命保険会社の資金の特徴としてはその「長期性」があげられる。銀行や信託銀行などの商品の契約期間が最長でも10年であるのに対して、生保契約は20年、30年という長期にわたる契約であり、生保資金は他の金融機関の資金に比べ長期の安定的な資金である。

(2) 資産運用の原則

生命保険会社が資産を運用するにあたっては、生保資金の持つ特質から、いくつかの基本原則が確立されている。

ところで、変額保険（変額個人年金保険を含む）や企業年金の分野に

において特定の契約に係る資産を他の資産とは分別して運用する「特別勘定」による資産運用が行われている。こうした特別勘定資産の運用における基本原則もその他の資産（一般勘定資産）の運用の場合と基本的には異なるところはないが、その特性に応じたいくつかの留意点があげられる。

本稿においては一般勘定に代表される生保の資産運用の基本原則とともに各特別勘定における資産運用の留意点につき説明することとする。

① 生保資産運用の基本原則

ア) 安全性の原則

安全性の確保は資産運用の第一の基本目的である。生保会社の資産の大部分が、契約者から払い込まれた保険料を源泉として将来の保険金支払を担保する責任準備金により構成されるものだからである。

イ) 収益性の原則

安全性を追求していく一方で、収益性を確保することも重要な基本原則である。すなわち、保険料は予定利率で割引かれていることから予定利率に相当する収益確保は最低限必要である。また、それを超える収益は契約者配当金として契約者に還元され、保険料の実質負担を軽減させることになる。

安全性と収益性は二律背反の関係にあることが多いが、多様な投資対象に対してリスクヘッジしつつ収益を追求していくことが資産運用の課題となる。

ウ) 流動性の原則

流動性の原則は、生保資金の長期的性格と安定的性格から、銀行などに比べればその重要性は低い。しかしながら近年他の貯蓄性金融商品との競合が激化し、生保資金の流動性が上昇しているため、当該原則の重要性が高まっている。

エ) 公共性の発揮

生命保険会社の資金が広く大衆から集められたものであり、さらに資産運用が広く国民経済の各分野で行われていることから、運用に際しては、公共性の発揮が常に要請される。現在、生命保険会社は国債など公共債の引き受け、公社、公団など公共関係機関への投融资等を通じて公共性の発揮に努めている。また、貸付・不動産投資を通じて、資金の地域還元にも努めている。

② 変額保険(変額個人年金保険を含む)の特別勘定資産運用における留意点

変額保険(変額個人年金保険を含む)の特別勘定資産運用の基本原則も一般勘定資産運用の基本原則と大きく異なるものではないが、特別勘定資産の運用実績が直接保険金額や年金額に反映されるものであるだけに以下の点に留意する必要がある。

ア) 収益の確保

変額保険(変額個人年金保険を含む)においては、一般の保険に比べ、リスクをとりつつハイリターンを狙うという商品特性から資産運用にあたっては収益性がより強く意識される。この特別勘定資産については、一般勘定資産と比べて運用規制が緩く、弾力的な資産運用が可能となっており、収益追求と安全性確保のバランスについても、生保会社の判断に負う部分が大きくなっている。

イ) 流動性の原則

変額保険(変額個人年金保険を含む)においては、投資環境の悪化状況下で大量解約が生じる可能性があるので、流動性が一般勘定にも増して重要となる。

③ 企業年金特別勘定の資産運用における留意点

企業年金に関する特別勘定の種類には、合同運用特別勘定と単独運用

特別勘定の2つがある（投資対象別に複数の合同運用特別勘定を保有する生命保険会社もある）。企業年金資産は、企業の退職年金制度に関する積立金であることから、長期的観点にたって安全性を確保しつつ高収益を追求していくスタンスは、一般勘定の基本原則と異なるものではない。しかしながら、一方で、特別勘定の運用実績が直接責任準備金額に反映されることから、顧客も収益性に高い関心を示し、運用に当たっても強く意識せざるを得ない状況にある。なお、単独運用特別勘定の場合、契約毎に特別勘定が設定されることから個々の顧客の意向に応じた資産運用が可能である。

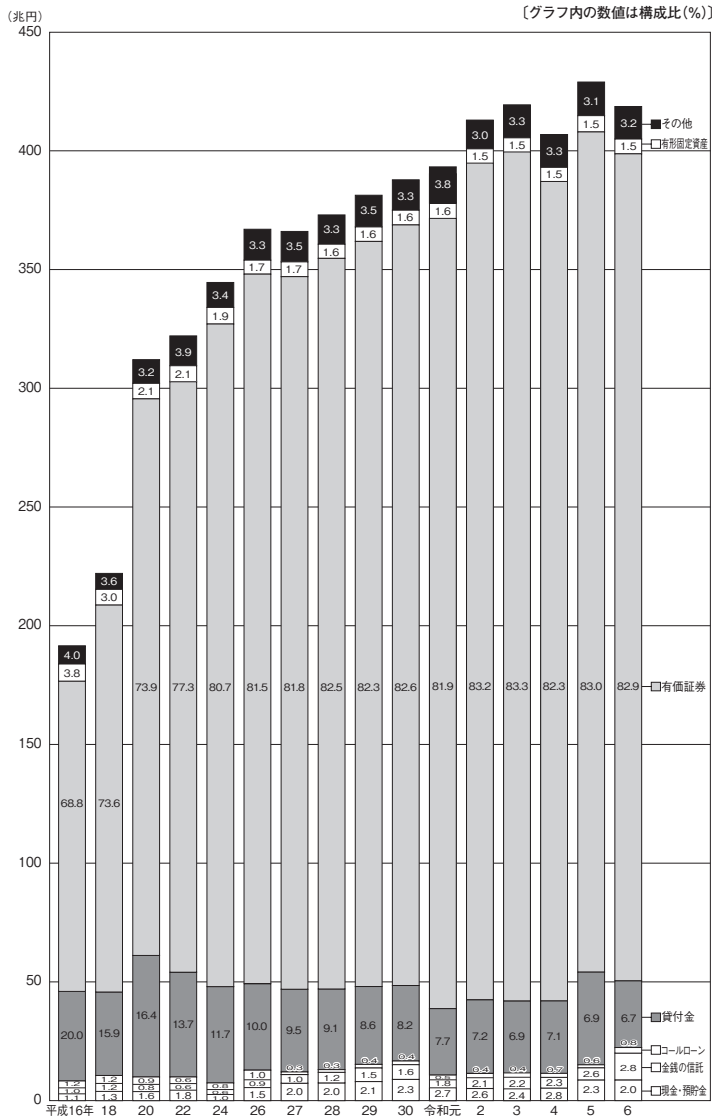
（３）資産運用の現状

① 生保資産の金融機関における位置

生保の総資産は2024年度（令和6年度）末で418兆5,222億円となった（かんぽ生命分を含む）。高度成長期を経て、低成長期が続く今日、経済は設備投資主導型から輸出主導型を経て消費主導型へと急速に転換しつつある。このような転換の中で、法人部門の大幅な資金不足は緩和されるとともに、個人部門や政府部門の資金需要が高まっている。資金調達については、中小企業等を中心にした借入金による資金調達（間接金融）が銀行等においてはまだ大きな割合を占めているものの、一方で大企業は社債等の資本市場からの資金調達（直接金融）へシフトしつつある。このような経済構造・金融構造の変化の中で、金融の自由化・国際化の進展と相まって、資金調達手段の多様化、証券市場の拡大、海外での投融資機会の増大等に対応するため、機動的かつ効率的な運用が生保資産運用に求められている。

この結果、生命保険会社の資産の構成をみると、1975年度（昭和50年度）には総資産の67.9%を占めていた貸付金が2024年度（令和6年度）には28兆2,168億円（シェア6.7%）とシェアを大幅に減らしている。一方、

図 13. 総資産および総資産構成比の推移



(注) 商品有価証券は「その他」に含む。

資料：生命保険協会「生命保険の動向」
平成20年以降はかんぽ生命分を含む。

有価証券のシェアは8割以上（82.9%）を占めている（図13）。

② 資産運用の自由化

生命保険会社の資産運用については、戦後長く規制色の強い体系の下で運営されてきた。投資の対象となる資産とその投資上限額が、省令や通達において定められており、保険会社はこれらの規制をまとめた財産利用方法書に従って資産運用を行っていた。かつては、無担保貸付の対象会社が財産利用方法書に個別に列挙されていたこともあった。

昭和50年代以降、金融自由化が徐々に進行する中で、海外投資の活発化、新金融商品の開発が行われ、保険会社に対する規制も、個別認可型から包括認可型へとシフトすることとなった。現在では、多様な投資対象への機動的な運用が可能となるように手当がなされている。

金融自由化の流れの中で、商品ファンドや小口債権（リース・クレジット債権の流動化商品）、ABS（資産担保証券）等の証券化関連商品が注目を浴びているが、生命保険会社に対しても、市場のメインプレーヤーとして期待がかかっている。また、1995年（平成7年）には、従来禁止されていた外貨建ローンが解禁され、対外投資の一層の効率化が可能となった。

資産運用と密接に関連する証券業務も従事可能な範囲が拡大している。従来から行ってきた私募債の取扱い、国債の窓口販売業務に加えて、公共債のディーリング、社債の管理業務が保険業法において認められ、銀行とほぼ同様の証券業務に従事することが可能となった。

さらに、1996年（平成8年）4月から施行された改正保険業法では、財産利用方法書が基礎書類から削除された。保険会社の資産運用規制は、法令によるものに一本化され、簡素化された。

（注）上記の資産運用規制の中で各運用方法およびその量的制限については、2012年（平成24年）4月の保険業法施行規則第48条の削除により、保有資産種類ごとの上限運用比率規制が撤廃された。

こうした自由化は、一方で保険会社に対する規制がこれまでの行政主導から市場主導、自己規律へと転換することを意味しており、従来以上に資産運用のリスク管理能力が問われることとなった。各社は、スワップ、オプション等のデリバティブ商品の効果的な利用、大口与信管理の徹底化等を通じて、効率的な資産運用体制の構築に努めている。

3. 社会保障と生命保険

生命保険事業は、国民大衆サイドの経済的保障ニーズの高まりに呼応して、積極的な営業努力を傾注することによって、飛躍的な成長を遂げてきた。

ところで、この需要サイド（消費者）のニーズと供給サイド（生命保険業界）の対応を結ぶものが生活設計であり、合理的でバランスのとれた生活設計のプランニングを通じて、消費者は自分の将来の生活における経済的課題を解決することができるようになり、また営業職員もライフ・コンサルタントとしての機能を果たすことができるようになるのである。

経済社会の大きな変化は、生活設計の必要性をますます高めており、生保各社はそれに対応してその方法を高度化・システム化させつつある。

（1）生活設計の原則と方法

生活設計には、毎月の収入を中心に現在の家計における費用のバランスをどうとるかを考える短期の生活設計と、住宅・教育・結婚・老後などの目標を達成するためにどのような経済準備をしていくか、そのための資産対策としてどのような家計ポートフォリオ（資産配分）が適切かを考える長期の生活設計がある。

長期の生活設計は短期の生活設計を積み重ねていくことによって築いていくという考え方もあるが、実際には短期の生活設計を積み上げていきさえすれば自動的に長期の生活設計が実現できるものではない。むしろ、逆

に長期の生活設計における目標をまず設定し、その目標との関連において今何をしておくべきかを短期の生活設計の中に組み入れておくべきだろう。

① 健全な家庭経済

幸福な家庭は3本の柱によって支えられているといわれる。健全な肉体と健全な精神と健全な家庭経済を持つことである。

健全な肉体とは、家族が健康であること、健全な精神とは、家族が互いに愛情と信頼を持ち合うことであり、また健全な家庭経済とは、常に家庭の収入と支出のバランスがとれていることである。

これらの3本の柱は互いに影響しあい、支えあっているのです、その1つが欠けると他の柱に影響を与え、家庭の幸福は失われていくことになる。

特に健全な家庭経済については、幸福な家庭生活を営むうえで極めて大切であるが、収入と支出のバランスを長い家庭生活の中で常に維持することはなかなか容易なことではない。

しかも、収入の中心は勤労による収入であるが、人間にとって老化と死亡は避けられないものである。その中でも、死はいつ起こるか分からないので、ここに経済的不安の大きな原因がある。

また、支出は子どもが成長し独立するまで徐々に増加するのが一般的であるが、時には、子どもの入学、結婚などで一時的に支出が増加することがある。

このように家計の収支のバランスが崩れる可能性は日常生活の中で常に存在し、しかもひとたび収支のバランスが崩れると、幸福な家庭生活は根底から覆されることになる。

② 生活設計の必要性

そこで、家庭の収支のバランスを常に維持するためには、将来の収入確保の準備があらかじめなされていることが必要であり、このため

には将来の収支の見込みを立て長期の生活設計を持つことが大切である。

家庭生活のライフ・サイクルは、結婚に始まり、子どもの誕生、家族の増加と成長を経て、やがて子どもの独立とともに家族は減少し、老夫婦の生活、さらに引退後の生活となるのが一般的であるが、個々の家庭では家族の年齢、人数、資産などに相違があるので、各自の家族状況に基づいてライフ・サイクル表（生活設計表）を作る必要がある。

ライフ・サイクル表によって、入学、結婚などの費用、またその他いつどのようなお金がいくら必要になるかが把握でき、さらに、その間に収入がなくなる事態が起きた場合の家族の生活費や、退職後の老後生活費についても準備計画を立てておくことの必要性が明らかになってくる。

③ 経済準備の必要性

幸福な家庭生活を営むためには、長期的展望に立った生活設計を考え、将来必要な出費をあらかじめ計画的に準備しておくことが必要である。そのために将来必要な経済準備には次のようなものがある。

ア) 遺族生活資金

収入の源泉である一家の働き手が死亡した場合、残された家族が生活を維持するための資金

イ) 老後生活資金

退職後の生活資金で、夫婦の老後生活資金と夫の死亡後の妻の老後生活資金

ウ) 住宅資金

住宅取得のための資金で、頭金として必要な資金

エ) 教育・結婚資金

子どもの教育や結婚に必要な資金で、働き手の生死に関係なく確

④ 生活保障としての生命保険

経済準備をするうえで、注意すべきことは、その必要性の大きいもの、必要額の大きいものを優先して準備することである。

家庭生活のうえで、経済的危険の最も大きいものは、一家の働き手の死亡によって収入が急に途絶えることである。その日から残された家族の生活は、大きな困難に直面することになり、子どもたちの教育のための資金も必要になってくる。

こうしたことから、家庭生活における第1の危険は子どもが独立するまでに死亡するという、いわゆる「早死の危険」である。

しかし一方で、今日の日本人の寿命は延びてきており、定年後の生活資金の必要性も高まってきている。特に最近では、退職して収入が減少する反面、老化や病気などに伴う寝たきり状態などの介護リスクが増大する。これがいわゆる第2の危険といわれる「長生きの危険」であって、この危険に対する準備は前もって行っておくべきである。

第3の家庭生活上の危険は、家庭生活を続ける間に収入と支出のバランスが崩れることである。長い家庭生活の途上では、思いがけない事故や病気などで急に支出が増えたり収入が減少したりすることがある。こういった緊急の支出のための準備も必要である。

以上のような家庭生活上の3つの大きな危険に対し、必要な資金を確実に準備する最善の方法が、生命保険である。

巨額のお金をしかも直ちに準備することは個人では到底できないことであるが、生命保険は多数の人々による「助け合い」の共同備蓄制度であるから、このようなことが可能であり、しかも、これほど適切な方法はないと言い得るものである。

また、生命保険の種類にもよるが、養老保険や終身保険などは蓄積

部分（貯蓄部分）が徐々に増えていくので、万一の時の死亡保障だけでなく、契約途中における緊急の支出にも、また、老後の生活資金の準備にも役立つものである。

以上、要約すれば、生命保険は、死亡保障、老後保障と緊急出費保障の3つの機能を持つものであり、家庭生活の長期計画を立てるうえで大きな役割を果たすものである。

（２）私的保障と社会保障

ライフ・サイクルに沿った自らの長期の生活設計を考えていくうえで、不可欠の要素となるものは、個人の自由意思に基づく契約で行われる生命保険等の保障制度（私的保障）と社会全体の責任において行われる社会保険等の保障制度（社会保障）であり、被用者の場合は企業の責任によって実施される保障制度（企業保障）も考慮する必要がある。

これらの生活保障制度は、国民生活の経済上の危険を保障し、国民生活の安定化を目指す制度であるが、その目的や性格も違っていて、相互に補完し合いながら、全体として国民の福祉の向上に役立っている。

その相互関連性を1つの表で示せば表5のとおりであり、現実の生活設計では、これら3つの保障制度を適切に組み合わせ、一生涯を通じるプランニングを立て、実行していく必要がある。

そのためには、私的保障と社会保障との基本的な相違点をはじめ、社会保障の概要と日本の社会保障－特に公的年金制度の現状と課題を理解しておくことが重要である。

表5. ライフ・サイクルの重点課題と国、企業、個人の役割

ライフ・ サイクルの 重点課題 3層の保障制度	死亡等の場合の 生活保障	老 後 の 生活保障	マイホーム づくり	子どもの教育・ 結婚資金 づくり	医療資金 備	介護保障
社会保障 (国)	●労災補償制度 ●遺族年金 障害年金 (厚生年金 国民年金)	●老齢年金 (厚生年金 国民年金)	●国庫融資制度 (独立行政法人 住宅金融 支援機構 (旧・住宅 金融公庫) 融資など) (財形住宅 ローン)	●奨学金制 度	●医療保険 制度 (健康保険 国民健康 保険 後期高齢者 医療制度等)	●介護保険 制度
企業保障 (企業)	●法定外労災 補償制度 ●死亡退職金 制度 ●弔慰金制度 ●遺族・遺児 育英年金制 度	●退職一時 金制度 ●年金制度 (確定給付 企業年金 確定拠出 年金等)	●住宅貸付 金制度 ●住宅資金 積立奨励 制度 (利子補給 制度 その他援 助制度) ●住宅資金 積立制度	(遺族・遺児 育英年金 制度)	●医療保険 制度 (組合健康 保険)	—
私的保障 (個人)	貯蓄 死亡保険	貯蓄 個人年金保険	貯蓄 団体信用保険	貯蓄 こども保険	貯蓄 医療保険	貯蓄 介護保険

① 社会保障制度の概要

社会保障制度の意味については、1950年（昭和25年）に、社会保障制度審議会によって内閣総理大臣に提出された「社会保障制度に関する勧告」の前書きの一部が理解しやすい。その前書きは、「いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾（高度障害）、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する

生活を営むことができるようにすることをいうのである。」としている。

社会保障制度はいずれも国の社会政策上の必要性から法律に基づいて政府の監督のもとに施行される制度であって、政府が保険者（経営主体）となる場合や、政府の監督のもとに行われるものがある。

一般に社会保障制度といわれる場合、狭義と広義の社会保障制度に社会保障関連諸制度を含める場合があるが、ここでは日本の狭義および広義の社会保障制度について述べることにする。

ア) 狭義の社会保障制度

社会保障制度は、狭義では、社会保険制度、公的扶助制度および社会扶助制度の3つの制度から成っている。

社会保険は、保険料の拠出を前提としての権利の行使であり、公的扶助は、資力調査（ミーンズ・テスト）を必要条件としての国庫を財源とする給付方式である。原則として、社会扶助は資力調査なしでの国庫からの給付方式をいう（ただし、所得による制限のあるものもある）。

i) 社会保険制度

現行の社会保険制度は、医療保険部門、介護保険部門、年金保険部門、雇用保険部門および災害補償保険部門の各部門から成っている。

〈医療保険部門〉

医療保険部門は、以下の7つの制度に分かれている。

- a. 健康保険制度 全国健康保険協会管掌保険制度
 組合管掌保険制度
- b. 船員保険制度
- c. 国家公務員共済組合制度
- d. 地方公務員等共済組合制度
- e. 私立学校教職員共済制度

f. 国民健康保険制度

g. 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）

〈介護保険部門〉

介護保険制度

〈年金保険部門〉

現行の年金保険部門は、2015年（平成27年）10月から公務員等の共済年金が厚生年金保険に一元化されたことにより、2つの制度に集約されている。

a. 厚生年金保険制度

従来の国家公務員共済組合制度・地方公務員等共済組合制度・私立学校教職員共済制度は、厚生年金保険制度に統合された。

b. 国民年金制度

（注）2015年（平成27年）10月の一元化前に既に給付されていた共済年金は存続している。なお、これらの共済組合等は厚生年金保険の運営機関として機能し、新旧制度移行期間の年金給付等の調整支給も担う。

〈雇用保険部門〉

現行の雇用保険制度は、2010年（平成22年）1月より船員保険制度と統合され、1つの制度となっている。

〈災害補償保険部門〉

現行の災害補償保険部門は、2010年（平成22年）1月より船員保険制度が労働者災害補償保険制度に統合され、以下の3つの制度に集約されている。

a. 労働者災害補償保険制度

b. 国家公務員災害補償制度

c. 地方公務員災害補償制度

(注) ただし、労災保険の対象となった船員については独自給付がある。

ii) 公的扶助制度

現行の公的扶助制度は生活保護法に基づいて行われているいわゆる生活保護制度がそれに該当する。この制度は、国の責任において、生活に困窮するすべての国民に対し、資力調査（ミーンズ・テスト）によって測定される困窮の程度に応じて、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、困窮者の自立を助長しようとするものである。

iii) 社会扶助制度

社会扶助制度には、1972年（昭和47年）1月に発足した児童手当制度があり、日本の社会保障制度の中で一番遅れてスタートしている。

2010年度（平成22年度）からは、政府の「（所得）控除から手当て」の考え方のもと、所得制限のない子ども手当制度として実施された。しかしながら、扶養控除等の所得控除の廃止・見直しとともに厳しい財源確保の問題もあり、支給対象者の所得制限のあり方を含めた支給方法や金額等は継続して国会審議され、2012年度（平成24年度）以降は、従来の児童手当法改正による新たな所得制限のある児童手当制度として実施されることになった。

また、2024年（令和6年）10月（12月支給分）からは、所得制限が完全撤廃され、対象児童も中学生から18歳（高校生）までに拡大された。さらに第3子以降の手当については月額3万円に増額されるなど、その支給対象拡大と支給金額の充実が図られている。

イ) 広義の社会保障制度

現代の社会保障制度を、広義でとらえるとすれば、上で述べた3つの制度（社会保険制度、公的扶助制度、社会扶助制度）に、さら

に社会福祉制度、保健医療制度および生活環境衛生・生活環境保全制度の3つの制度を加えたものとなる。

日本の社会福祉制度には次の諸制度がある。

- i) 老人福祉制度
- ii) 身体障害者福祉制度
- iii) 知的障害者福祉制度
- iv) 児童福祉制度
- v) 児童扶養手当制度（ひとり親家庭対象）
- vi) 特別児童扶養手当制度（障害児対象）
- vii) 母子・父子・寡婦福祉制度
- viii) 母子保健制度

これらの諸制度の名称からうかがわれるように、高齢者、身体障害者（児）、知的障害者、母子・父子世帯および寡婦などを対象に、それぞれの福祉を図ることを目的としている諸制度を一括して、社会福祉制度としているのである。

以上述べた現行の社会保障制度が対象としている主な保障の内容は、通常失業や高齢、死亡などによる所得の喪失をカバーするための所得補償と医療保障等である。以下では、受給者が保険料を負担するという点で生命保険に似た性質を持つ社会保険制度について述べることにする。

② 社会保険の特質

社会保険には生命保険と違ったいくつかの特質がある。そこで、その特質を普通の生命保険と比較してみることにする。

ア) 保険料の基準となる考え方

生命保険の保険料の金額は、死亡率、保険金額、契約期間等に左

右される。これに対して、社会保険の場合は保険料の負担能力，すなわち保険加入者の所得によって，その金額が左右される。

つまり，保険事故の発生率よりも保険料負担者の負担能力に応じて保険料が決められることが多いという特色がある。

イ) 事業主による保険料の分担

生命保険の保険料は，その全額を保険契約者が負担している。一方，社会保険の保険料は，被保険者が企業の被用者である場合にはその全部を被保険者が負担するのではなく，事業主が分担することになっており，分担割合は，少なくとも50%になっている。

ウ) 保険財政に対する国庫負担

生命保険の運営はすべて加入者負担で行われ，国庫からの補助は全くない。一方，社会保険の場合には，その多くが程度の差こそあれ，保険財政について国庫負担（納税者負担）が行われている。すなわち，国民が納付した税金から補助を受けて運営されている。

エ) 給付額の画一性

生命保険では保険事故が発生した場合に支払われることになる保険金の金額（保険金額）は，契約当事者の合意によって任意に決められることができるから，給付額のコレは，個々の必要に応じて決められるようになっているといつてよい。

これに対して，社会保険の場合には，給付額は，個々の被保険者の好みや必要によって自由に決めるのではなく，法制上の決まった金額になっている。つまり，社会保険では社会的に一般化された尺度によって，給付額が決められているのである。

オ) 加入の強制

生命保険に加入するかどうかは個人の自由である。つまり生命保

険は任意保険である。一方、社会保険は加入が義務付けられている強制保険である。

強制加入とする理由は、社会保険の保険料は社会安全のため、社会単位、すなわち特定の社会集団を構成する人々の危険率により算定され、加入者個人の危険率の高低に関係なく一律の保険料を負担することとなっており、任意加入を認めると危険率の高い高齢者や病弱者だけが加入することになって、保険金の支払いに保険料が不足し、保険制度が破綻するおそれがあるからである。

すなわち、社会保険は生命保険と違って無選択で加入を認めるが、加入を強制することによって、大数の法則が働く被保険者集団を形成し、一定の危険度を保持することができ、いわゆる逆選択を防止することができるからである。しかも、これによりこの制度を確実に存続することが可能となる。

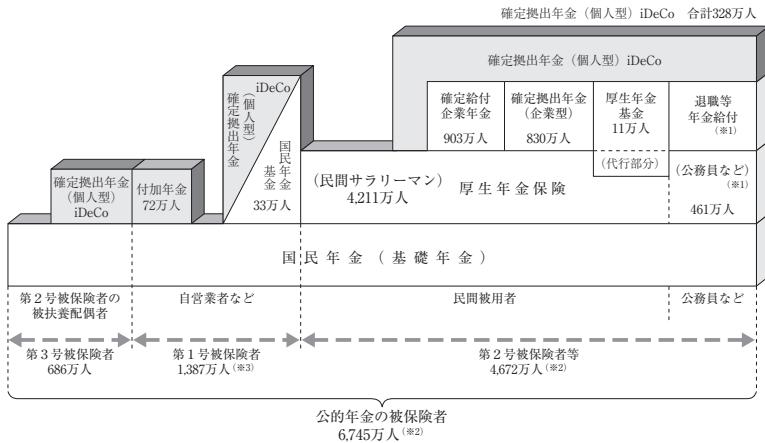
(3) 公的年金制度

① 公的年金の概要

日本の年金制度は、軍人や官吏を対象とした明治時代の恩給制度に始まる。一般国民を対象とした年金制度としては、1942年（昭和17年）に、工場などで働く男子労働者を対象とした労働者年金保険制度が発足している。

このように、公的年金制度は、被用者を対象とする制度から出発し、1961年（昭和36年）には自営業者等を加入対象とした国民年金制度が発足して、すべての国民が何らかの公的年金に加入する「国民皆年金体制」を実現してきた。

図 15. 年金制度の体系（令和 6 年 3 月末現在）



資料：企業年金連合会 HP より作成

現在の公的年金制度は、全国民（20歳以上60歳未満の者）が加入し、基礎的給付を行う国民年金（基礎年金）と、それに乗せして報酬比例の年金を支給する、被用者（会社員や公務員等）の厚生年金保険からなる。また、自営業者等に対する国民年金の上乗せ年金としては国民年金基金制度があり、厚生年金保険の上乗せ年金としては確定拠出年金（企業型）などがある（図15）。

公的年金制度の加入者状況については、2024年（令和6年）3月現在で加入者が6,745万人、うち厚生年金制度への加入者数は、4,672万

人となっている。また、公的年金の実受給権者数は、3,978万人にのぼっている。2024年（令和6年）の国民生活基礎調査の概況によると高齢者世帯が受給している公的年金・恩給額は1世帯平均で200万円であり、所得に占める割合は63.5%となっている。また、同調査では、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のうち43.4%が公的年金・恩給のみで生活しており、さらに所得の6割以上を公的年金・恩給が占めている世帯まで含めると75.0%になり、公的年金は老後生活の柱として定着してきている。

② 公的年金制度改革

ア) 改革の必要性

このように国民生活に広く普及・定着してきている公的年金制度であるが、今後迎えようとしている人口構造の高齢化により大きな影響を受けることが指摘されている。すなわち2020年（令和2年）時点における65歳以上の人口は3,602.7万人で、総人口に占める割合（28.6%）は既に4分の1を超えているが、これが2030年（令和12年）には3,696.2万人・30.8%となり、2050年（令和32年）に3,887.8万人・37.1%、さらに2060年（令和42年）には3,643.7万人に減少するものの、総人口が減少するためその占率は4割に近づくものと推計されている（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2023年（令和5年）推計）」による）。また、平均寿命の延びにより、「人生100年時代」を見据えている。2024年（令和6年）の簡易生命表によれば、平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳となっており、今後さらに延びるものと予測される。こうした中で、公的年金財政の長期的安定を図るために保険料や年金の給付水準をはじめとして制度の大幅な見直しを重ねて検討し、その改正に取り組ん

でいる。

イ) 改革の経緯

1984年（昭和59年）2月には「公的年金制度の改革について」と題する基本方針が閣議決定され、公的年金制度の長期的安定と公平化を図るために、公的年金制度の一元化が政府の目標として示された。

1985年（昭和60年）改正では、年金制度の基礎的部分を一元化し20歳以上60歳未満のすべての国民を対象とする基礎年金制度の発足や、給付水準の段階的な引下げ（給付乗率通減）等を内容とする大幅な改正が実施された。

1989年（平成元年）改正では、1973年（昭和48年）改正で導入された物価スライド制の完全自動化などが行われた。

1994年（平成6年）改正では、厚生年金定額部分の支給開始年齢を基礎年金と同じ65歳に段階的に引上げることや、厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となる標準報酬の再評価率を、それまでの現役世代の名目賃金の上昇率に応じたものから、税や社会保険料を除いた手取賃金の上昇率に応じたものに改める（ネット所得スライドの導入）等の改正が実施された。

さらに2000年（平成12年）改正では、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に65歳まで引き上げられること（1961年度（昭和36年度）以降生まれの男性、1966年度（昭和41年度）以降生まれの女性は、原則として65歳になるまで老齢年金を受給できない）や、報酬比例部分の給付水準の適正化（給付乗率の5%削減（従前額は保障））、65歳以降のスライドをネット所得スライドから物価スライドに切り替える等が行われた。

なお、保険料や年金額の計算の基礎となる標準報酬（月額）につ

いては、賞与も含む総報酬制に移行，2003年（平成15年）4月に施行されている。

ウ）2004年（平成16年）の改正

こうした数次の改正を経てもなお，少子化の影響などにより，年金制度の安定は期しがたかった。そこで，2004年（平成16年）には，上限を設けて段階的に保険料を引き上げる一方，給付水準を引き下げることを柱とする改正がなされた。

2004年（平成16年）改正の主な内容は以下のとおりである。

〔保険料〕

厚生年金保険については保険料率で年取の18.30%（本人負担は9.15%），国民年金については保険料で月額1万6,900円（平成16年度価格。賃金上昇率をもとに改定）を上限にすえ，2017年度（平成29年度）までの間，毎年保険料を引き上げていき，上限で固定する。

（注）国民年金は2017年（平成29年）4月分保険料から，厚生年金保険は同年9月分保険料から上記の基準値で固定された。

なお，実際の国民年金保険料（第1号被保険者）は，この基準額に年度改定率を乗じて算出される。また，2019年（平成31年）4月からこの基準額は100円増額されて月額17,000円となっている（134頁参照）。

〔将来の年金給付水準〕

現役世代の減少に応じて自動的に給付を削減する「マクロ経済スライド」が導入された。これにより現役世代の平均手取賃金に対する所得代替率（標準モデル）が，2004年度（平成16年度）の59.3%から，2023年度（令和5年度）には50.2%になると試算された。この制度は2015年（平成27年）4月に，デフレ時の物価スライド据置措置による特例水準の解消とともに，前年の物価や賃金が

上昇したことから、制度創設後初めて適用された。

(注) 当初のマクロ経済スライド率の適用による年金額の改定は、物価や賃金が十分に上昇しない場合は十分な調整機能を発揮することができなかったため、2018年（平成30年）4月より、景気回復期に賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調整する仕組み（キャリアオーバー）が導入され、景気回復期では「当該年度のスライド率」に「前年度までの未調整分」を加えて年金額の調整（引下げ）が行われるようになった。さらに2021年（令和3年）4月より、物価の変動率よりも現役世代の賃金の変動率が低い場合は、賃金の変動率に応じた年金額の引下げが行われるようになった（133頁参照）。

なお、2024年（令和6年）の財政検証では、推計計算の前提となる社会・経済状況等をいくつかの楽観的、悲観的なケースなどに分けて検証している。その結果、2024年度（令和6年度）の標準世帯の所得代替率が61.2%であるのに対し、楽観的な諸要件の下では今後も50%以上を維持できるとしたものの、厳しい条件下では国民年金は2059年度（令和41年度）に積立金がなくなり、完全な賦課方式に移行するとされている。

(注) 上記の社会・経済状況等の主な前提には、人口の前提、労働力の前提、経済（物価上昇率・賃金上昇率・年金積立金の運用利回り）の前提などがある。

〔基礎年金の国庫負担割合〕

2009年度（平成21年度）に、現行の3分の1から2分の1に引き上げることとされた。これに伴う将来の財源確保に関しては、「2007年度（平成19年度）をめどに、社会保障制度全般の改革の動向などを勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行う（改正国民年金法の付則）」とされた。

(注) 2012年度（平成24年度）の税制改正により、消費税をその財源とすることとされたが、2009年度（平成21年度）から2013年度（平成25年度）までは、財政投融资特別会計からの特例的な繰入金や消費税増税による収入を償還財源とする年金特例公債（つなぎ国債）により確保された。

〔在職老齢年金制度の見直し〕

それぞれ異なっていた60歳台前半と60歳台後半以降の在職者への厚生年金支給停止基準額（年金と賃金の合計額の基準額）を、2022年度（令和4年度）より47万円（令和4年度価格（令和8年度においては65万円））に統一した。

〔次世代育成支援の拡充〕

3歳未満の子どもを育てる厚生年金保険加入者の月額賃金の子育て以前の賃金を下回った場合は、以前の賃金を年金額計算の基礎とする。また、3歳未満の子どもを育てる厚生年金保険加入者の育児休業期間中は保険料を免除する。

〔離婚時の夫婦間における年金受給権の分割〕

離婚した場合に、厚生年金の分割割合で合意しているか、裁判所の決定があれば、厚生年金の分割を請求できる制度を創設する。この制度は2007年（平成19年）4月から実施されているが、2008年（平成20年）4月以降は一方の当事者からの請求により保険料納付記録を自動的に1／2にする「第3号被保険者期間の分割制度」も施行された。

〔遺族年金の見直し〕

30歳未満で子がない遺族厚生年金の受給権を得た妻については、5年を経過すると受給権を失うこととし、遺族年金受給期間を短縮する。

この2004年（平成16年）改正によって、年金制度改革は一応の決着を見たが、少子化が予想以上に進んだ場合などには不安が残っている。

こうした事情のもと国民年金の未納率の高止まりに懸念もあったが、近年は低所得滞納者を除き、改善傾向にある（厚生労働省資料）。

エ）現状と課題

急速な少子高齢化とともに、厳しい年金財政の問題や将来に向け

た年金制度自体の存続に関わる諸問題の抜本的な解決には、社会保障全体の改革とその財源確保のための新しい仕組みが要求されている。現在、社会保障・税一体改革による制度充実の取り組みがすすめられているが、2012年（平成24年）にその一環として、年金関連法案が可決成立した。これによって以下のような改正が順次進められている。

- 1）年金額の物価スライド特例水準の解消（2015年（平成27年）4月）によるマクロ経済スライドに基づく年金給付額のあり方の再検討

⇒2016年（平成28年）の国民年金法の改正によって、デフレ時等の対応として物価・賃金上昇時に一括調整する（2018年（平成30年）4月～）ことや、物価の変動率よりも賃金の変動率が低い場合は賃金変動率に連動する調整（2021年（令和3年）4月～）が実施されることになった。

- 2）基礎年金の1/2国庫負担割合の恒久化（2014年（平成26年）4月～）

⇒2009年度（平成21年度）から施行しているが、今後は消費税の引き上げとともに社会保障目的税化して安定財源を確保することになっている（131頁参照）。

- 3）遺族基礎年金の父子家庭への支給（2014年（平成26年）4月～）

⇒以前の支給対象は「子のある妻」または「子」に限定されていた。

- 4）産休期間中の保険料免除（2014年（平成26年）4月～厚生年金保険，2019年（平成31年）4月～国民年金）

⇒以前は健康保険も含めた育児休業中に限る厚生年金保険の保険料免除制度から、少子化対策の一環として拡充された。

(注) 国民年金保険料は、この適用開始により免除期間の基礎年金が満額保障されることになるため、その財源として、固定基準額が100円増額された。

5) 年金生活者支援給付金の支給 (2019年 (令和元年) 10月～)

⇒所得の額が一定の基準を下回る年金生活者へ、消費税10%への引き上げ時期 (2019年 (令和元年) 10月) から最大月額5,000円の支給が開始された。

6) 受給資格期間25年の10年への短縮 (2017年 (平成29年) 8月～)

⇒無年金者の発生を抑えることのほかに国民年金保険料の納付率の改善を同時に図るため、3年間の時限的な後納制度も運用された。

(注) 保険料払込の時効期間の2年を経過した未納分を含めて、5年間に遡って支払いを可能とする後納制度は2018年 (平成30年) 9月に終了した。

7) 厚生年金保険と共済年金の一元化 (2015年 (平成27年) 10月～)

⇒厚生年金保険の2階建て部分に統一し共済年金の職域加算部分は「年金払い退職給付 (新たに保険料を積み立てる新制度)」に経過的に移行して廃止する。

(注) その他、保険料率や支給要件等の制度的な差異は基本的に厚生年金保険に揃えることになった。また、退職給付 (格差) の官民均衡を図る観点から、当面公務員等の退職手当の支給水準を引き下げて調整することとしている。

8) 短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大 (2016年 (平成28年) 10月～)

⇒厚生年金保険と健康保険の適用基準が同一のため適用範囲の拡大による保険料負担の増加が課題となる。

なお、社会保障制度改革国民会議の報告 (2013年 (平成25年) 8月) を踏まえて、政府は社会保障制度改革推進法に基づいて法制上の措置

としてその骨子をまとめており、これらの年金関連法により方向づけられた事項等の着実な実施と、今後の取組課題として更にその他の事項に関する検討を加え、その結果に基づく必要な措置を講じる旨を閣議決定（同年8月）している。これらの対応において、2014年（平成26年）以降に実施されている税制改革に基づく社会保障目的税としての消費税の引き上げが、その財源として中心的な位置づけをなしていることは重要である。

（注）上記以外のその他の検討項目には、「高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人ひとりの状況を踏まえた年金受給のあり方」「高所得者の年金給付のあり方及び公的年金等控除を含めた年金課税のあり方」「その他必要に応じて行う見直し」などがある。

さらに、2025年（令和7年）の年金制度改革により、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図ることとなった。この改正では、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、以下の措置などが講じられている（2025年（令和7年）以降順次実施）。

1）被用者保険の適用拡大等

賃金要件の撤廃、適用事業所の拡大など

2）在職老齢年金制度の見直し

支給停止となる収入基準額の引き上げ

3）遺族年金の見直し

遺族厚生年金の男女差の解消。遺族基礎年金の支給停止に係る規定の見直しなど

4）厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

標準報酬月額の上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げ

る^(※)など

※68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。

5) 将来の基礎年金の給付水準の底上げ

今後の社会経済情勢の変化を見極め必要な措置を講じるなど

(4) 公的医療保険

日本の医療制度は「国民皆保険」となっており国民は、健康保険（一般の被用者）、国民健康保険（自営業者等）、各種共済組合（公務員等）、後期高齢者医療制度（75歳以上）のいずれかに加入しなければならない。

公的医療保険においても高齢化などに伴う医療費の増加を受けて財政状況は年々厳しくなっており、過去、保険料負担の引き上げ、受診時自己負担の引き上げ（例えば被用者本人の場合でゼロ→1割→2割→3割）が繰り返されてきた。

こうした改革を経てもなお、財政状況は厳しく、高齢化の進展にともなって更に悪化すると想定される。こうした状況を改善すべく、以下の内容を骨子とする「医療制度改革大綱」が2005年（平成17年）末に決定され、2006年（平成18年）通常国会で健康保険法等の改正が行われた。

- a. 高齢者の受診時および入院時自己負担引き上げ
- b. 後期高齢者医療制度（75歳以上）の創設
- c. 生活習慣病等の疾病予防対策の推進
- d. 在院日数短縮のための諸施策の実施
- e. 都道府県単位を軸とした保険者の再編等（政府管掌保険→協会けんぽ）

医療保険制度は、2000年（平成12年）の介護保険制度の創設（140頁後述）により高齢者医療の一部を移行した。更に2008年（平成20年）4月から従来の老人保健制度に代えて後期高齢者医療制度（長寿医療制度）創設、給付率の改定、政府管掌保険の公法人化を図り時代に則した効率化

を進めてきたが、逼迫する財政問題は、新たな抜本的対応の必要性をも生み出している。健康保険組合連合会の決算見込と今後の財政見通しでは、2024年度（令和6年度）の決算見込は145億円の黒字で、収支は改善したが、依然、約半数の660組合が赤字となっている。保険料収入は対前年度比+4.9%（+4,261億円）の増加となったが、保険給付費が前年度に続き+1.3%（+623億円）と増加している。さらに高齢者等拠出金が+5.7%（+2,065億円）の増加となっていることに注目する必要がある。

国民健康保険、協会けんぽも保険料率の引き上げ対応などで厳しい財政状態をしのいでいる現状があるが、法定給付費・高齢者医療拠出金に加えて、介護納付金（145頁参照）の増大も課題となっている。団塊世代の後期高齢者入りと現役世代の減少による拠出金負担の増加に対応すべく、2022年（令和4年）10月には後期高齢者の自己負担1割の層のうち、一定以上の所得者は2割負担となっている。

社会保障制度改革国民会議の報告（2013年（平成25年）8月）では、更なる高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が避けられない現状の中で、国民皆保険制度の維持を前提とした必要な医療制度の改革を提言している。これに基づき制定された社会保障制度改革推進法（プログラム法）の工程表に沿って、政府は必要な法制上の措置を講じながら具体的な制度改革を順次図っている。

① 医療サービス等の提供体制について

1）病床の機能分化・連携及び在宅医療・在宅介護の推進

⇒地域医療ビジョンの策定と都道府県の役割強化、財政支援・診療報酬に係る適切な対応、医療法人間の合併等の制度見直しなど。

2）地域における医師、看護職員等の確保及び勤務環境の改善等に係る施策

3) 医療職種の業務範囲及び業務の実施体制の見直し

② 医療保険について

1) 医療保険制度の財政基盤の安定化

⇒国民健康保険の財政上の構造問題解決と運営主体を都道府県とした市区町村連携・役割分担，協会けんぽの国庫補助や高齢者医療制度の費用負担を含む制度のあり方の検討など。

2) 保険料に係る国民の負担に関する公平の確保

⇒国民健康保険や後期高齢者医療制度について，低所得者の保険料負担や各制度からの支援金のあり方，被用者保険の標準報酬月額の上限額の引上げなど。

(注1) 後期高齢者医療制度では，低所得者に対する保険料軽減の特例措置について所得割部分は2018年度（平成30年度）から本則（軽減なし）となり，均等割部分は低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直されている。また，元被扶養者の保険料については，均等割分の軽減特例が2019年度（令和元年度）には廃止された。

(注2) 国民健康保険の保険料は，被用者保険とのバランスを考慮し，当面は超過世帯割合が1.5%に近づくように賦課限度額について医療分（基礎賦課分）が段階的に引き上げられている。

3) 保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等

⇒70～74歳の医療費一部負担金引上げ，負担能力に合わせた高額療養費の見直しなど。

(注1) 現在の医療費の一部負担（自己負担）割合

- ・6歳～69歳（70歳以上の現役並所得者含）：3割
- ・義務教育就学前および70～74歳：2割
- ・75歳以上の一般者：1割（2022年（令和4年）10月以降，一定以上所得がある者は2割（そのうち現役並み所得者は3割））

(注2) 高額療養費とは，自己負担額が限度額を超えた場合に超えた金額が全額給付される制度を指す。

2015年（平成27年）1月から70歳未満者について新たな所得区分によって上限額が見直されたことに続き、2018年（平成30年）8月までに70歳以上の高齢者についても所得区分に応じた限度額の引き上げが図られた。

③ 難病対策・小児慢性特定疾患対策

⇒都道府県の超過負担の解消と公平かつ安定的な医療費助成制度の確立など。

（注）2015年（平成27年）5月「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、上記の社会保障制度改革推進法（プログラム法）に基づく諸検討を踏まえた以下のような法制上の措置が決定し、順次適用されている。

①国民健康保険の安定化（2018年（平成30年）4月～）

財政支援を拡充し、都道府県が財政運営の責任主体となって運営の中心的な役割を担う。

②後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入（2017年（平成29年）4月～）

被用者保険について2015年度（平成27年度）から段階的に移行実施。

③負担の公平化等（2016年（平成28年）4月～）

入院時の食事代の段階的な引き上げ（低所得者・難病・小児慢性特定疾病患者を除く）、紹介状なしの大病院受診時の定額負担導入、健康保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額の上限額の引き上げ等。

④その他（一部を除き2016年（平成28年）4月～）

協会けんぽの国庫補助率は16.4%（当面）とし、一部特例減額措置を講じる（2015年（平成27年）5月～）、被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助率見直し、医療費適正化計画の見直し（都道府県が地域医療構想と整合的な目標を設定）と予防・健康づくりの促進（自助努力支援）、患者申出療養（新たな保険外併用療養）の創設 など。

（５）介護保険制度

① 高齢者介護を巡る状況

現在日本では、高齢化の進展により、介護を必要とする高齢者が急速に増加しつつある。現状では、要介護・要支援認定者数について749万人に増大している（142頁参照）。

これまでこれらの高齢者介護の担い手は家族に大きく依存してき

た。しかし、主たる介護力である女性の就業に関する問題、また介護の長期化・重度化による介護者自身の「介護疲れ」、あるいは平均寿命の延びとともに高齢者の単独世帯や高齢夫婦だけの世帯が増加するなどの家族類型の変化により、80歳の妻が85歳の夫の介護をするような「老老介護」といった家族の介護機能の変化が起こっており、高齢者介護問題は老後の大きな不安要因の一つとなっている。

② 介護保険制度創設（2000年（平成12年））の経緯

高齢者介護サービスは、従来、(i) 老人福祉制度（ホームヘルプや特別養護老人ホームなどの介護事業）と (ii) 老人保健制度（高齢者向け医療制度）の2つの制度によって提供されてきた。しかし、(i) については、行政がサービスの提供種類や機関を指定するため、利用者がサービスを自由に選択できなかった。また (ii) については、介護が主たる目的の長期入院（いわゆる「社会的入院」）によって医療費の非効率的な消費を招いているといった問題があった。また (i) (ii) が異なる制度下にあることから利用者負担や手続きが不均衡となり、総合的なサービス提供ができないなどの課題を抱えていた。

これらの状況を踏まえ、2000年（平成12年）4月より、公的介護保険制度が開始された。

この介護保険制度の主な目的としては、

- 1) 現行福祉と医療に分かれている高齢者介護サービスを統一的な制度に再編成し、手続きの利便性を高めるとともに、必要な介護サービスを総合的に提供できる仕組みとする
- 2) 利用者が主体的にサービスを選択し利用できる利用者本位の制度とする
- 3) 社会保険方式により、給付と負担の関係を明確にするとともに、

増加する介護費用を社会全体の連帯によって安定的に賄う

- 4) 民間事業者の参入を促進し、介護市場に競争原理を導入、サービスの向上を図る
- 5) 介護を社会全体で担うことにより家族の介護負担を緩和し（介護の社会化）、高齢者の介護予防や自立した生活の支援を行うなどが挙げられる。

③ 介護保険制度の概要

ア) 保険給付の対象者

介護保険制度の被保険者は、65歳以上を第1号被保険者とし、40歳～65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者とする。第1号被保険者は、原因を問わず常に介護が必要な状態（要介護状態）あるいは日常生活に支援が必要な状態（要支援状態）であれば保険給付の対象となるが、第2号被保険者については、初老期の認知症など老化を原因とする特定の疾病による要支援状態または要介護状態であることが保険給付の要件となっている。

イ) 保険料

介護保険制度は単一の制度であるが、保険者（運営主体）は、各市町村であり、第1号被保険者の保険料は各市町村ごとに基準保険料（所得段階別の定額保険料）が設定される。また、第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険者が制度の算定基準に基づき保険料を設定し、一般の医療保険料に上乗せする形で一括して徴収する。

ウ) 支給限度額

介護保険の給付を受けるためには、要支援認定または要介護認定を受けなければならない。市町村は、各被保険者の状態を把握するための認定調査（一次判定）と主治医の意見書をもとに、「介護認

定審査会」で審査判定（二次判定）を行う。その結果、最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」までの7段階の判定を受けた者に対して保険給付がなされる。各要介護度に応じて介護保険制度からの支給限度額が決められており、この点は医療保険制度と異なるところである。なお、サービスの利用者は1割（一定水準以上所得者は2割、その中で特に所得の高い層は3割）の利用者負担を支払う。

（注）一定以上所得者とは、単身で年金収入のみの場合280万円以上、特に所得の高い層とは、同様に単身で年金収入のみの場合340万円以上に相当する者をいう（基準詳細は省略）。

④ 介護保険制度開始後の状況

ア) 要介護認定関係の実施状況

2025年（令和7年）4月末現在、要介護・要支援認定者数は749万人である。また、介護保険のサービス受給者数（全体）は573万人、そのうち「介護サービス」受給者476万人の内訳は、居宅サービス受給者が約351万人、地域密着型サービス受給者が約93万人、施設サービス受給者が約98万人となっている（介護給付費等実態統計月報2025年（令和7年）4月審査分）。

要介護認定については、コンピュータを使った一次判定において、認知症の高齢者の判定が軽めに出るなどの課題が指摘されており、二次判定（介護認定審査会）において一定の手当て（修正）が行われている。

イ) サービス提供状況

全国の介護サービスの指定事業所・施設数は増加傾向にある。法人の種別としては、従来から高齢者向けのサービス提供主体として活動していた社会福祉法人や医療法人に加え、営利法人やNPO法人（特定非営利活動法人）の参入も進んでいる。もっとも近年は人

員基準違反などの不正事案も多く、規制も強化されている。

また、サービスの提供量も増加傾向にある。介護保険に係る総費用は介護保険制度がスタートした2000年度（平成12年度）で3.6兆円だったが、2024年度（令和6年度）費用額・累計（介護サービスおよび予防サービスの合計額）では11.9兆円と約3.3倍に増加している（令和6年度 介護給付費等実態統計の概況）。

ウ) ケアマネジャーの役割と課題

介護保険制度においては、利用者のニーズや状態などを総合的に勘案し、主に12種類の居宅サービスから、最適なサービスを計画的に組み合わせて提供する仕組みが取り入れられている。この仕組みを「ケアマネジメント」といい、このケアマネジメント業務を中核的に担うのが「介護支援専門員」（ケアマネジャー）である。

ケアマネジャーは、利用者宅を訪問してアセスメント（ニーズ把握や課題分析）を実施する。そして、利用者ごとに最適なケアプラン（介護サービス計画）を作成する。また、利用者と介護サービス提供事業者とのパイプ役となって、サービスの調整や給付管理業務などを行う。

ケアマネジャーは、利用者にとって最も身近な専門職として、その役割を期待されているが、多くのケアマネジャーは利用者や家族からの多種多様な相談への対応、膨大な事務作業に追われているのが現状である。こうした状況から、ケアマネジャー業務の支援体制の整備が課題となっており、解決に向けた取組みが、都道府県・市町村レベルで進められている。

⑤ 2006年（平成18年）実施の制度見直し

介護保険制度は2000年（平成12年）の導入の際に5年後に見直す

こととされており、これを受けて2005年（平成17年）の通常国会で法改正が行われた。2006年（平成18年）4月から介護予防サービスや地域密着型サービスなどを新しく取り入れた改正制度がスタートしている。

制度改正の内容は、①予防重視型システムへの転換、②施設給付の見直し、③新たなサービス体系の確立、④サービスの質の確保・向上、⑤負担のあり方・制度運営の見直しの5つが柱とされた。

⑥ 介護報酬改定

介護報酬とは、提供されるサービスの対価（価格）であるが、3年ごとに単価が見直されることになっている。2003年（平成15年）、2006年（平成18年）と行われた改定では、介護財源不足を理由に連続して引き下げられたが、2009年（平成21年）以降は介護人材確保を狙いとした介護職員の処遇改善部分の単価についてプラス改定が行われている。

介護保険は、その創設以来、サービス利用者および介護費用の増大による制度の持続可能性が課題とされてきた。創設から10年を経過して、2012年（平成24年）4月に施行された改正介護保険法では、高齢者が地域における自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に重点が置かれており、以下のような取り組みが進められている。

- a. 医療と介護の連携の強化
- b. 介護人材の確保とサービスの質の向上
- c. 高齢者の住まいの整備等
- d. 認知症対策の推進

e. 保険者による主体的な取り組みの推進

f. 保険料の上昇の緩和

なお、社会保障制度改革国民会議の報告（2013年（平成25年）8月）を踏まえ、政府は上記の改正介護保険法の具体的取り組みに加えて以下の検討を進めていくとともに、必要な法制上の措置を順次講じている。

1）地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し

⇒在宅医療および在宅介護の連携の強化、高齢者の生活支援および介護予防に関する基盤整備、認知症に係る施策など。

⇒上記と併せた地域の実情に応じた要支援者への支援（予防給付）の多様化。

（注）予防サービス受給者を含む軽度支援者の給付は、2015年度（平成27年度）から2017年度（平成29年度）末までに段階的に「地域支援総合事業」に移行している。

2）各保険者からの後期高齢者支援金の全面総報酬割に併せた介護納付金の総報酬割の段階的实施とこれに伴う必要な措置

（注）2017年（平成29年）8月に1/2報酬割、2019年度（令和元年度）は3/4、2020年度（令和2年度）からは全面総報酬割となった。

3）一定以上の所得を有する者の利用者負担や補足給付（食費や住居費）の支給要件に資産を勘案する等の見直し

（注）2015年（平成27年）8月以降、単身で金融資産1,000万円超の者等は低所得の施設利用者の補足給付の支給要件から除かれ、2021年（令和3年）には1,000万円以下の基準がさらに細分化された。

4）特別養護老人ホームに係る施設介護サービス費の支給対象の見直し

⇒特別養護老人ホームの入所要件の厳格化

（注）2015年（平成27年）4月以降、原則、新規入所者は要介護3以上に重点化された。

5) 低所得の第1号被保険者の介護保険料の負担軽減や介護報酬に係る適切な対応のあり方

(注) 2014年(平成26年)6月の「医療介護総合推進法」公布以降は、上記の具体的対応の他に以下の措置等も関係法の改正とともに講じられている。

- ①消費税引上げに連動した低所得第1号被保険者の介護保険料の段階的引き下げ(公費補てん)
- ②高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費に関する利用限度額の所得区分に応じた引上げ(2015年(平成27年)8月～2018年(平成30年)8月)。高額介護サービス費においては現役並所得者区分の細分化
- ③その他、新たな介護医療施設の創設や福祉分野との共生型サービス実現、地域ケア会議の推進等

第4章 生命保険会社の経営に関する 法的規制

— 学習のポイント —

生命保険会社に対し，なぜ国家が監督する必要があるのかを理解し，監督法について概観する。

また，相互会社と株式会社の特質について理解する。

重要項目

- 保険監督法
- 保険相互会社と保険株式会社の特徴

1. 生命保険業の監督の必要性和その方法

生命保険事業は多数の契約者から保険料を徴収し、これを安全かつ有利に運用管理し、将来被保険者が死亡したり、また満期まで生存した場合に、保険金を支払って個人あるいは企業の必要とする経済的需要を確実に保障する責任を有するものであり、国民経済全般に及ぼす影響は多大で、極めて社会性・公共性の高い事業である。したがって、日本を含め世界的に生命保険事業は国家により監督されるのが一般的となっている。

国家による保険監督の方法としては、伝統的に形式的監督主義と実体的監督主義の二つに大別されてきた。

形式的監督主義は、さらに公示主義と準則主義に分けられる。公示主義は保険会社の事業成績など一定の事項を公示させて契約者や一般公衆の判断に委ねるもので、準則主義は保険事業の開始および継続について一定の準則を定めて、その遵守を国が監督するものであるとされる。この形式的監督主義は、保険市場の自律調節機能、保険会社の自主規制に期待し、自由主義経済を基調とする立場である。

一方、実体的監督主義は、監督官庁に広範な権限を与えて、保険事業の開始から業務運営、そして経営不振会社に対する最終的整理、統合に至る事業経営のあらゆる段階において監督を行うものであり、日本ではこの方式が採られている。なお、日本の保険業監督の主務大臣は内閣総理大臣（金融庁長官に監督権限が委任されている（保険業法第313条））および財務大臣である。

2. 保険業法

(1) 経 緯

保険会社を監督するうえでその基礎となる制定法の中心は1995年（平成7年）6月に改正され、1996年（平成8年）4月に施行された改正保険業法（平成7年法律第105号）である。

この改正保険業法施行以前は、(旧) 保険業法（昭和14年法律第41号）、保険募集の取締に関する法律（昭和23年法律第171号）および外国保険事業者に関する法律（昭和24年法律第184号）が、主たる監督法であった。これらの法規について、金融の自由化・国際化等の保険制度を取り巻く環境の変化に対応するとともに、保険業の健全性を確保することを目的として、規制緩和・自由化の推進、保険業の健全性の維持、公正な事業運営の確保の3点を基本的な柱として、全面的な改正を行った。以降、必要に応じて随時改正が行われてきた。そのなかで、2013年（平成25年）9月の金融審議会の報告を受け、保険募集に関する基本的ルールが、より積極的な一般的義務規定として保険業法に新たに規定された（2016年（平成28年）5月施行）。さらに、2025年（令和7年）には、顧客本位の業務運営を徹底し健全な競争環境を実現する観点からの改正が行われた（2026年（令和8年）6月1日施行）。

(2) 概 要

保険業法には、公法規定である行政的監督規定と私法規定である保険事業を営む者の組織および業務活動に関する規定とが混在している。

公法としての部分は以下に述べるとおり、事業免許、基礎書類の認可および日常の業務監督などを中心とする実体的監督主義を採っており、諸外国と比べてもその監督権はかなり広範囲にわたっている。

（ なお、本章における括弧書きの条数は、現行の保険業法の条
数である。 ）

① 目 的

保険業法の目的は、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、国民生活の安定・国民経済の健全な発展に資することにある（第1条）。

② 定義・免許

一般の多くの人々を対象に保険契約の引受けを行う事業である保険業には、保険業の公共性に鑑み、免許制（少額短期保険業者については登録制）が採用されている。免許には生命保険業免許と損害保険業免許の2種類があり、生命保険業免許を受けた保険会社は、（イ）及び（ロ）の保険の引受けを、また、損害保険業免許を受けた保険会社は（ロ）及び（ハ）の保険の引受けを行うことができる（第2条、第3条）。

（イ）人の生死に関し一定額の給付を行う保険（いわゆる生命保険）

（ロ）傷害・疾病・介護分野の保険（いわゆる第三分野の保険）

（ハ）一定の偶然な事故による損害をてん補する保険（いわゆる損害保険）

保険業の免許を申請するときは、免許申請書に、基礎書類（定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書）を添付して内閣総理大臣に提出しなくてはならない（第4条）。

③ 業 務

保険会社は、保険業法および他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない（第100条）。その理由としては、他業の失敗による資産の悪化を防止すること、保険数理に基づき決定された

収入保険料を他業の欠損填補に充当すると収支相等の原則が貫徹できなくなることを、保険事業に専念するほうが効率的かつ安全な事業経営が可能になることなどが挙げられる。

保険業法により保険会社の行う業務は、次の（イ）から（ハ）である。

（イ）固有業務（第97条）

保険の引受け及び資産の運用が規定されている。

（ロ）付随業務（第98条）

固有業務に付随する業務を行うことができ、以下の事業が例示されている。

- ・ 他の保険会社等その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行
- ・ 債務の保証
- ・ 国債等の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
- ・ 金銭債権その他の取得または譲渡
- ・ 特定目的会社が発行する特定社債等の引受けまたは当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
- ・ 短期社債等の取得または譲渡
- ・ 有価証券の私募の取扱い
- ・ 取引所金融先物取引等
- ・ 金融等デリバティブ取引等
- ・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引等

（ハ）法定他業（第99条）

固有業務、付随業務に加え、固有業務の遂行を妨げない限度において、次の法定他業を行うことができる。

- ・ 社債などの募集又は管理の受託
- ・ 公共債ディーリング

- ・ 保険金信託
- ・ 証券投資信託, 外国証券投資信託の受益証券等に係る売買, 売買の媒介等
- ・ 投資助言業務

④ 子会社等

i) 子会社

保険会社の子会社の業務範囲については, 他業の禁止の観点から, 以下のように制限がなされている。

〈子会社の定義（第2条第12項）〉

- ・ 保険会社が直接その会社の総株主等の議決権の50%超を保有する会社
- ・ 保険会社及び保険会社の子会社の持分の合算でその会社の総株主等の議決権の50%超を保有する会社

〈子会社の範囲（第106条第1項）〉

- (ア) 生命保険会社
- (イ) 損害保険会社
- (ウ) 少額短期保険業者
- (エ) 銀行
- (オ) 長期信用銀行
- (カ) 資金移動専門会社
- (キ) 証券専門会社
- (ク) 証券仲介専門会社
- (ケ) 金融サービス仲介業者のうち, 所定の有価証券等仲介業務のほか, 有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営む会社

- (コ) 信託専門会社
- (サ) 保険業を行う外国の会社
- (シ) 銀行業を営む外国の会社
- (ス) 有価証券関連業を行う外国の会社
- (セ) 信託業を営む外国の会社
- (ソ) 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社
- (タ) 新たな事業分野を開拓する会社
- (チ) 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社
- (ツ) 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社
- (テ) 保険業高度化等会社
- (ト) 上記（ア）～（テ）に掲げる会社のみを子会社とする持株会社
- (ナ) 上記（ア）～（テ）に掲げる会社のみを子会社とする外国の持株会社

（注）上記の子会社においては一定の要件が必要なケースがある。

〈株式の取得制限（第107条）〉

保険会社又はその子会社は、国内の会社（子会社等は除く）の株式について、原則として総株主等の議決権の10%を超えて保有することはできない。なお、保険会社は独占禁止法によっても株式の取得制限を受けている（独占禁止法第11条）。

〈取締役等の兼職制限（第8条）〉

保険会社の常務に従事する取締役（指名委員会等設置会社にあつては執行役）は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

〈特定関係者^(注)〉との間の取引等（第100条の3）〉

利益相反の弊害による保険会社の財務内容の悪化を防ぐため、保険会社と特定関係者との間の、通常と著しく異なる条件での資産の売買その他取引が禁じられている。

（注）「特定関係者」とは、保険会社の子会社や、保険会社を子会社とする保険持株会社、保険持株会社の子会社（当該保険会社を除く）等のことをいい、次に述べる「子法人等」「関連法人等」もこれに含まれる。

ii) 子法人等，関連法人等

保険会社の子法人等，関連法人等についても，他業の禁止の観点より，業務範囲等について制限がなされている。

なお，子法人等，関連法人等とは，子会社ではないが，保険会社と出資，融資，人材等の面で，つながりの深い法人をいい，詳細については，保険業法施行令，保険業法施行規則，金融庁監督指針に定めがある。

⑤ 監 督

保険業に対する規制の実効をあげるためには，免許の際にとどまらず，継続的に保険監督者が保険会社の実態を把握し，監督措置を行える体制が取られていることが必要である。こうした観点から保険業法では以下のような規定を設けている。

i) 保険商品・料率の認可，届出

保険商品・料率については，原則として認可が必要である。但し，保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定められる特定の商品・料率については届出でよい（第123条）。なお，届出の場合，保険会社は，原則90日経過後，届出事項を実施できる（第125条）。

ii) 資産運用規制

資産の運用方法、運用割合等については内閣府令で定められている（第97条、第97条の2）。なお、各運用方法における量的制限に関し、2012年（平成24年）4月に保険業法施行規則第48条が削除され、保有資産種類ごとに総資産額の一定割合を上限とする資産運用比率規制は撤廃された。

iii) 行政監督権

内閣総理大臣には保険会社に対して報告徴求権、立入検査権、一般的監督権などが認められており、早期是正措置制度も導入された。各々の内容は次のとおり。

・ 報告徴求権

内閣総理大臣は、保険契約者などの保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる（第128条）。

・ 立入検査権

内閣総理大臣は、保険契約者などの保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所などに立ち入らせ、帳簿書類などを検査させることができる（第129条）。

・ 一般的監督権

内閣総理大臣は、保険会社の業務または財産の状況に照らして保険契約者などの保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、業務の全部もしくは一部の停止、財産の供託、その他監督上必要な措置を命じることができる（第132条）。

・ 早期是正措置制度

保険会社の保険金支払い能力に関し導入された制度で、内閣総理

大臣はいわゆる経済価値ベースのソルベンシー比率が100%未満の会社について、各区分毎に以下の是正措置を命じることができる。

区 分	経済価値ベースのソルベンシー比率	是正措置
非対象区分	100%以上	なし
第一区分	70%以上100%未満	改善計画の提出およびその実行の命令
第二区分	35%以上70%未満	保険金等の支払い能力の充実に資する各種措置に係る命令
第三区分	35%未満	期限を付した業務の全部または一部停止命令

(注) 従来はソルベンシー・マージン比率が指標として用いられてきたが、国際的な規制動向やリスクの多様化・複雑化などを背景に策定された指標である、「経済価値ベースのソルベンシー比率」へ2026年（令和8年）3月期決算から移行することとなった。

⑥ 経営危機対応制度

保険会社が経営危機に陥った場合、保険業法では経営の破綻した保険会社の保険契約を健全な保険会社に移転することにより継続させる制度を導入している。さらに、保険契約者保護機構が設置され、そのような救済保険会社に対し資金援助を行うことができるうえ、救済保険会社が現われない場合は機構自ら保険契約を引き受けることができることになった（第259条）。これらの処理を迅速に行うため、内閣総理大臣は、破綻した保険会社に対し保険契約の移転・合併について協議するよう命ずることや、保険管理人による業務・財産の管理を命ずること（第241条）、また、保険契約の移転・合併に係る保険会社間の協議に際し、その条件を斡旋すること等ができる（第257条）。

また、2000年（平成12年）6月の「金融機関等の更生手続の特例

等に関する法律（いわゆる更生特例法）」の改正によって、保険相互会社にも、再建型破綻処理である更生手続が適用されることとなり、債務超過に陥る前の早期の処理手続開始などが可能となった。

⑦ 保険募集

生命保険は目に見えないサービスであり、一般の多くの人々には内容が理解しがたく、またその必要性は通常潜在的にしか感じられていないので、保険募集は契約締結にとって重要な意義を持つものである。保険会社にとっても事業の発展のために新契約の募集は不可欠なものであり、しかも一般の募集従事者にとって募集成績が自己の収入に関係することから、募集競争は激化し、ややもすると契約者に迷惑を及ぼすような募集活動が行われかねない。

このような性質を持つ募集活動を規律するため、保険業法で設けられている主な規制は、以下のとおりである。

- ・生命保険募集人は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない（第275条、第276条）。
- ・生命保険募集人は、原則として、複数の生命保険会社の委託を受けて募集を行ってはならない（第282条）。
- ・保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為（第300条）。
- ・保険会社は保険募集に際して、重要な事項の顧客への説明、顧客情報の適正な取扱い、第三者に委託する業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない（第100条の2）。

その他、国際的な整合性の確保、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図る観点から、契約者と保険会社の間に立って中立の立場で保険契約の媒介を行う保険ブローカー（保険仲立人）制度が導入されている（1996年（平成8年）4月施行の改正保険

業法より)。

2013年(平成25年)9月の金融審議会の報告を受け、保険募集に関する基本的ルールが、より積極的な一般的義務規定として保険業法に新たに規定された(2016年(平成28年)5月施行)。これは1996年(平成8年)の改正保険業法の施行以来の保険募集に係る大きな改正で、商品の複雑化、販売チャネルの多様化、国際化等に対応する新しい時代の保険事業のあり方を方向づけている。その内容には商品提案に際する「意向把握義務」および「情報提供義務」のほか、法令遵守のための「体制整備義務」を負う対象者の拡大等(保険会社以外に保険募集人を含む)がある(第294条、第294条の2、第294条の3)。これによって保険業法の禁止行為(第300条)の内容も説明すべき重要事項の限定等一部見直された。

また、一定の大規模保険募集人(大型乗合代理店)については帳簿書類の作成・保存及び事業報告書の提出が義務付けられるとともに、業務委託先等に対する監督当局による報告徴求・立入検査権限も整備された(第303条、第304条、第305条)。

この他、その曖昧さから生じるトラブル等を防止するためにも、保険業法上の「保険募集行為」の再整理と明確化、乗合代理店等による複数会社商品の比較推奨販売に対する追加義務規定も具体的に規定された。

保険仲立人に係る規制緩和等の環境整備(立場の明確化・保証金の引き下げ・長期契約取扱いの認可要件撤廃等)については、2014年(平成26年)8月に改正法が施行されている。

2025年(令和7年)の改正(2026年(令和8年)6月1日施行)により大規模乗合代理店および保険会社等に対する体制整備義務が強

化されるとともに、保険契約の締結等に関する禁止行為について、対象となる行為等の範囲が拡大された（保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与の禁止等）。さらに、販売面での競争促進の観点から、保険仲立人への規制が見直され、保証金の最低金額の引下げ等による規制緩和が図られる一方、届出事項を内閣府令により追加可能とする規定が整備された。

（注）上記の保険業法改正内容の詳細については、生命保険講座テキスト「約款と法律」「生命保険商品と営業」を参照。

なお、2001年（平成13年）4月から施行された「金融商品の販売等に関する法律（金融サービス提供法に改称）」（下記（注）参照）によって、保険会社を含む金融商品販売業者は、顧客への重要事項の説明と勧誘方針の策定・公表が義務付けられている。また同じく2001年（平成13年）4月から施行された「消費者契約法」では、不適切な勧誘を行った際の契約取消権や、不当な契約条項の無効等を定めることにより消費者保護を図っている。

また、2006年（平成18年）の通常国会で「金融商品取引法」が成立し、2007年（平成19年）9月から施行された。

これは従来の「証券取引法」を改組し、その規制対象を伝統的な有価証券以外にも拡大することとしたもので、議論の中では保険・年金商品全般、預金全般を対象とすべき、との意見もあったが、結局、保険・年金商品に関しては、保険業法で規定した特定保険契約としての変額保険、変額個人年金保険、市場金利連動型商品、外貨建商品が対象とされることになった。

（注）「金融サービス提供法」は、2023年（令和5年）11月29日公布の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、2024年（令和6年）2月よ

り正式名称が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となっている。

⑧ 外国保険業者

保険業法は、外国保険業者が日本において保険業を行うためには、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けることを必要とすることを定め（第185条）、その事業開始に当たっては、一定の金額の金銭を供託しなければならないこととし（第190条）、また日本における保険契約者、被保険者、保険金受取人などは、この供託金に対し優先権を有することを規定（第190条）して、日本における保険契約者等の利益を保護している。

さらに、日本国内において締結した保険契約に係る責任準備金等の金額等に相当する資産を国内において保有しなければならない（第197条）として、外国保険会社の担保資金の明確化と支払能力の確保を図っている。その他、内国保険会社についての規定を数多く準用し、基礎書類の提出を求め（第187条）、日本において使用する保険約款、保険料等についても、日本の保険会社と同様の監督規制を受けることとしている。

（3）相互会社と株式会社

保険業法の、保険業を行う者の組織に関する部分は、株式会社について会社法の一般規定に所要の修正・補充を加えているほか、保険事業に独特の、相互会社の制度を設けている。

日本では、生命保険事業は保険業法によって株式会社または相互会社でなければ行えないことになっている（第5条の2）。そして株式会社については、原則的には会社法の株式会社の規定が適用されるが、保険事業の特殊性による必要事項については、別に保険業法で規定されてい

る。また相互会社は保険事業に特有の会社形態で、各契約者が社員となるという組織の構成が危険への共同準備という保険事業の性格に適しているため、保険業法によって認められているものであるが、会社法の規定も数多く準用されている。このように保険事業を行う会社形態を規定する理由は、事業の性質上大規模経営を必要とし、かつその事業に安定性・永続性が要請されるからである。

株式会社と相互会社の特徴を対比すると次のような相違がある（表6）。

表6．株式会社と相互会社の相違

	株式会社	相互会社
法人性	営利（社団）法人	中間（社団）法人
構成員	株主	社員
意思決定機関	株主総会	社員総会、総代会
資金	資本金	基金
損益	株主に帰属	社員に帰属

① 会社の性質

株式会社は、営利を目的とする者が出資して株主となり会社の構成員となって組織する営利法人である。

相互会社は契約者が社員となり、自ら会社の構成員となって組織する会社で、契約者相互の利益を目的とするもので営利も公益も目的としない中間的な社団法人である。

② 出資関係

株式会社にとって株主の出資する資本金は会社存在の基礎であり、事業資金や保険契約の担保資金として重要な役割を果たすものである。

相互会社には資本金は存在しないが、事業資金や担保資金として、相当額の資金が必要である。そのため保険業法では、相互会社の設立に際して基金の保有を求め、さらに基金を償却するときは、償却する額に相当する金額を積み立てなければならないとしている。なお、基

金は増額することも可能である。

③ 経営参加

会社の構成員（社員）が会社の意思決定機関を通じて経営に参加し、また経営の結果としての損益が構成員に帰属するという点については、株式会社も相互会社のいずれも同じである。しかし、前にも述べたとおり、株式会社の構成員は株主であり、相互会社の構成員は保険契約者（社員）であるので、保険契約者の立場は株式会社と相互会社で異なることとなる。すなわち、株式会社の保険契約者は保険サービスを購入した顧客であって会社経営の枠外にとどまり、会社の損益の帰属には関与しない。これに対して、相互会社の保険契約者は会社の構成員として会社の意思決定機関である社員総会あるいは総代会を通じて会社の経営に参画し、また会社の損益は保険契約者に帰属するので剰余金の分配権を有するものである。

相互会社における契約者の経営参加は理論的には上述のとおりであるが、実際問題としては、保険契約者の増大に伴って社員の意思を会社経営に反映するための社員総会の開催は事実上不可能となる。そこで社員の中から総代を選出し、社員総会に代わるものとして総代会を設けている。また、事業の規模の増大に伴い社員自治の実効性を確保し、広く社員の経営に対する意向を反映するために、相互会社各社は様々な方策を採っている。すなわち、社員投票（信任投票）による総代選出制度を導入したり、また総代への情報提供の充実や一般社員の総代会傍聴制度を設ける等、総代会の活性化を図っており、さらに、各地域において契約者懇談会を開催し、一般の社員の意見を経営に採り入れるべく努めている。

④ 組織変更

保険業法は株式会社の相互会社への組織変更について規定している（第68条）。

また、資本調達能力の向上や事業展開等を目的として、相互会社が株式会社へ転換を図る可能性などを考慮して、相互会社の株式会社への組織変更についても規定している（第85条）。従来の規定では、相互会社の社員（契約者）に、株式会社化に際して株式を割り当てる場合、1株未満の端株主が極めて多数発生し、その管理コスト等の負担は多大なものとなるなどの実務的な課題があったが、2000年（平成12年）6月の法改正により、1株未満の割当て部分については一括で株式を売却し金銭で交付する制度が導入されたことにより、相互会社から株式会社への組織変更が容易になった。

第5章 民間生命保険の隣接業界

学習のポイント

各種共済事業・簡易保険・損保・信託・銀行・証券業界について概観する。

重要項目

- JA 共済
- こくみん共済 coop 〈全労済〉
- 全国生協連
- 簡易保険
- 損害保険
- 銀行・信託・証券業界
- 少額短期保険業

民間生命保険会社のほかに生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関としては、共済（JA共済、こくみん共済 coop〈全労済〉、全国生協連等）がある。また、近年、銀行、証券、損保などの隣接業界との接点も大きくなっている。

1. 生命共済事業

（1）共済と保険

共済事業は、「一定の地域または職域に関係する者によって構成される団体が、相互扶助を目的として、組合員の火災・死亡・疾病・退職等に際して一定の給付を行う」事業をいう。基本的には組合員を対象としているが、特例として、構成員以外との契約が認められるケースもある。

これを民間保険と比較すると、民間保険では、生命保険と損害保険の兼営が認められていないのに対し、生命共済と損害共済の兼営も認められており、共済事業の保障内容は多様なものである。

また、民間保険においては、加入者の拠出する金額は給付・反対給付均等の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で均一である場合も多く、相互扶助の色彩が一層強い。

さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、金融庁の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が多種多様であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。また、共済は民間保険に比べて法人税負担が軽い等の特徴をもつ。

しかし、実態としてしてみると、JA共済（全国共済農業協同組合連合会）などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、構成員外の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。

さらに、根拠法令のない「無認可共済」も急増していた。これらは共済種類、契約内容等について民間保険会社と極めて類似し、このような判断基準では保険事業と区分し得ないものも多いことから、2006年（平成18年）4月の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または少額短期保険業者（後述2（4）参照）とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。本節では、代表的な共済（事業）である「JA共済、こくみん共済 coop〈全労済〉、各都道府県民共済」について解説する。

（注）保険業法で規定する適用除外団体には、JA共済等の制度（法定）共済のほかにPTA共済等の、いわゆる少数共済が含まれる。

（2）JA共済（全国共済農業協同組合連合会）

JA（農業協同組合）による共済事業は、1947年（昭和22年）に制定された農業協同組合法により根拠を与えられ、実現される運びとなったものである。当時の目的は、企業保険による保障下でない農家のリスクを保障するとともに、農村資金の農村外への流出を抑えて農家経営等の資金として活用することにあった。

1958年（昭和33年）に全都道府県の組織化が完了したが、当初は共済事業の実施組合はわずかであった。その後急速に普及するにつれ、共済事業成績も飛躍的に拡大してきた。2024年度（令和6年度）末で生命総合共済の保有契約高は74.4兆円、総資産は57.4兆円の規模（総資産は損害系の共済も含んだ数値）に達している。

取扱商品は、養老生命共済、終身共済、こども共済、年金共済、医療共済など民間生命保険会社とほぼ同じであり、大型保障性商品の販売に力を入れているのが特徴である。また、自動車共済・建物更生共済といった損害系の共済商品も取り扱っている。

JA 共済事業は、農協系統組織の一環であり、農業協同組合の行う信用・購入・販売など、他の事業と同様、JA（単位農協）、JA 共済連という2段階による組織機構により運営されている。

なお、JA 共済の資金運用は農林水産省の省令にその方法が定められており、運用機関はJA 共済連である。

保有契約高、総資産の動きを民間生命保険、JA 共済の間で比較すると、表7、表8のとおりである。

表7. 個人保険保有契約高の比較（除年金）

（単位：兆円）

	民間生保	JA 共済
昭和50	173	31 (18)
60	601	144 (24)
平成 5	1,381	228 (17)
10	1,409	248 (18)
15	1,153	222 (19)
16	1,112	213 (19)
17	1,071	204 (19)
18	1,026	195 (19)
19	981	185 (19)
20	940	177 (19)
21	903	170 (19)
22	880	164 (19)
23	865	158 (18)
24	862	152 (18)
25	858	145 (17)
26	857	138 (16)
27	859	131 (15)
28	863	125 (14)
29	853	118 (14)
30	849	110 (13)
令和元	830	103 (12)
2	816	97 (13)
3	807	91 (11)
4	795	85 (11)
5	791	79 (10)
6	779	74 (9)

（注）カッコ内は民間生保を100とした場合の指数。
 資料：生命保険協会「生命保険の動向」
 「JA 共済連の現状」
 平成19年度以降は、民間生保にかんぽ
 生命分を含む。

表8. 総資産の比較 (単位：億円)

	民間生保	JA 共済
昭和50	128,960	32,333 (25)
60	538,706	112,147 (21)
平成 5	1,691,211	246,714 (15)
10	1,917,684	336,823 (18)
15	1,843,230	421,410 (23)
16	1,915,230	427,047 (22)
17	2,098,791	435,632 (20)
18	2,202,170	441,096 (20)
19	2,138,992	435,174 (20)
20	2,051,420	432,104 (21)
21	3,103,802	446,633 (14)
22	3,206,912	462,975 (14)
23	3,269,528	476,332 (15)
24	3,449,981	506,909 (15)
25	3,505,826	523,556 (15)
26	3,672,552	541,782 (15)
27	3,671,679	558,375 (15)
28	3,755,051	577,651 (15)
29	3,812,751	581,890 (15)
30	3,877,945	580,992 (15)
令和元	3,927,350	571,883 (15)
2	4,124,465	580,363 (14)
3	4,196,966	581,926 (14)
4	4,068,156	576,870 (14)
5	4,286,072	584,751 (14)
6	4,185,222	574,189 (14)

(注) カッコ内は民間生保を100とした場合の指数。

資料：生命保険協会「生命保険の動向」

「JA 共済連の現状」

平成21年度以降は民間生保にかんぽ生命分を含む。

(3) こくみん共済 coop 〈全労済〉

消費者・勤労者が協同してその生活を守る運動の一環として、職業別または地方別、あるいは労働組合単位に実施されているのが、消費生活協同組合法（生協法）に基づく各種共済であるが、その中で、こくみん共済 coop 〈全労済〉は、労働者共済の全国組織であり、生協法による

共済事業中最大の規模を誇っている。

労働者共済事業は、1954年（昭和29年）に大阪で火災共済事業が実施されて以来、全国に広がり、1957年（昭和32年）9月、労済運動の全国組織として、「全国労働者共済生活協同組合連合会」（労済連）が結成された。また、1976年（昭和51年）11月には、略称を「全労済」へ変更し、2019年（令和元年）6月には愛称を「こくみん共済 coop〈全労済〉」とした。

2024年度（令和6年度）末の「団体定期生命共済」の保有契約高は約33.7兆円となっている。近年は個人向けの共済が事業の中心となっており、主力の「こくみん共済」を中心とする個人向けの生命共済は、従来の掛金建、掛け捨て型だけではなく、男女別・年齢別掛金の長期保障や介護医療保障タイプ等を加え、2024年度（令和6年度）末の保有契約高は約35.1兆円となっている。

この他に、こくみん共済 coop〈全労済〉では年金共済等も取り扱っており、商品・サービス面の充実を図っている。

こくみん共済 coop〈全労済〉は全国レベルの本部、地方レベルの地方労済本部、県レベルの県本部からなる3段階組織で運営されている。組織、事業運営上の権限は本部に置かれ、地方労済本部、県本部は本部から委任された権限を分担している。

（４）各都道府県民共済(全国生協連(都道府県民共済グループ))

全国生協連の共済事業は、1973年（昭和48年）12月に埼玉県民共済生活協同組合が生命共済を実施してスタートした。

その埼玉県民共済と同様の方式により共済事業の全国展開を図ることを目指して設立されたのが、全国生活協同組合連合会（全国生協連）である。全国生協連は、1971年（昭和46年）12月に設立された首都圏生

協連を前身としており、同生協連に所属していた埼玉県民共済が、その共済事業の発展を背景に、自らがイニシアティブをとり、1981年（昭和56年）5月に同生協連を改組して全国生協連を発足させた。

その後も全国に輪を拡げ、2022年（令和4年）4月にすべての都道府県における事業展開を実現している。

全国生協連は、各加盟都道府県単位生協から構成されているが、共済契約の引受に当たっては全国生協連と単位生協との間で委任契約か業務委託契約のどちらかが締結される。委任契約が結ばれるのは、単位生協が独自の共済事業を有している場合であり、単位生協が加入者と共済契約を締結する。一方、単位生協が共済事業を有していない場合には、業務委託契約が結ばれ、全国生協連名義での共済契約が結ばれることとなる。なお、生協法の改正施行（2008年（平成20年）4月施行）に伴い、共済事業の運営組織は全国生協連の「都道府県民共済グループ」に委ねられた。

全国生協連が実施している各都道府県民共済の商品は、生命共済に傷害保障と入院保障を付加したものであり、加入が無面接、無診査と極めて容易であるとともに掛金が年齢にかかわらず一律であること（月払保険料、1,000円・2,000円・4,000円など）から、共済活動が積極的な一部地域では業績も非常に好調である。加えて、銀行と提携し、窓口で共済加入できるため、銀行が保険を販売している観を呈している。

全国生協連の生命共済（各都道府県民共済）の契約実績は、総加入件数で2024年度（令和6年度）末に1,799万件に達し、着実にその数を伸ばしている。

なお、この生協法の改正に伴い、こくみん共済 coop〈全労済〉はじめ各都道府県民共済やCO・OP共済などの共済事業は、契約者保護の観点から事業の健全性確保のための規制が強化された。これによって共済事業のより明確な役割発揮（他事業との区分含む）と組合員の利便性向

上のための運営（共済代理店の設置認可等）が推進され、新しい共済組織のネットワークも築かれつつある。また、保険法が規定する契約ルールは各共済制度にも適用されることから、契約手順から共済金支払等のさまざまな保全手続きにいたるまでの規定も整備されてきており、民間生保事業との差異は縮まっている。

2. 簡易保険とその他の隣接業界

（1）簡易保険の歴史と現状

2007年（平成19年）10月に郵政民営化関連法によりかんぽ生命が新しい生命保険会社として発足したが、それ以前は、簡易保険として1916年（大正5年）10月の創設以来、国営の独立事業として運営されてきた。創設当時、既に数多くの民間生命保険会社が経営を行っていたが、営業政策上、有診査、年払の大口契約を中心としていたため、その対象は主として中産階級の人々に限られ、一般労働者は民間生命保険によって生活の保障を確保することが難しかった。このような背景の下、「低廉かつ確実な小口月払保険を広く大衆の間に普及させ、もって、国民生活の安定を図る」という社会政策的配慮から、国営による簡易保険事業が始められるに至った。なお、当時内閣に設置された小口保険制度調査委員会では、簡易保険を独占事業とする理由として、①基礎の強固、②非営利、③経費の節約、④事業の普及、の4項目をあげている。

制度創設後、簡易保険は民間生命保険を補完する形で、順調な発展を遂げた。

しかし第二次世界大戦の敗戦を境に、簡易保険と民間生命保険の関係は、補完関係というよりもむしろ競合関係となった。敗戦により民間生命保険が壊滅的な打撃を受けたこと、国民の所得水準が低下し民間生命保険が主力とする年払契約では生命保険の販売が立ち行かなくなったこと、等を理由に、1946年（昭和21年）10月、無診査・月掛・集金に関

する簡易保険の独占が廃止されたためである。

その後、簡易保険は民間生命保険の新商品・サービスに追随する形で商品開発を進め、加入限度額についても順次、引き上げられてきた。

当時、簡易保険の業務範囲は法律（簡易生命保険法）で定められており、その加入限度額や販売保険種類は制限されていた。しかしその一方で、政府による支払保証があり、法人税も免除されている等、民間生命保険に比べて有利な競争上の特典も大きかった。こうした簡易保険事業を含む官業としての郵政3事業（保険、貯金、郵便）のあり方については、長い間、議論が続けられてきた。行政改革の流れの中、郵政3事業の実施主体は郵政省から郵政事業庁へ（2001年（平成13年）1月）、郵政事業庁から日本郵政公社へ（2003年（平成15年）4月）と経営形態を変えてきたが、これらはいずれも国営を維持する形態であった。しかし2005年（平成17年）10月に郵政民営化関連法が成立し、2007年（平成19年）10月に日本郵政公社が廃止された。これによって持株会社である日本郵政株式会社と傘下の4つの事業会社（郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険）という体制が発足した。簡易生命保険法は郵便貯金法などとともに廃止された。

かんぽ生命は民間の生保会社と同じ保険業法に基づき免許を受け、事業を行う。ただしかんぽ生命が行うのは新契約業務のみであり、それまでの簡易保険既契約は郵政公社の承継法人である独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構により引き継がれている。これにより簡易保険の既契約に対しては政府による保証が継続された。

この郵政事業の民営化では、かんぽ生命とゆうちょ銀行について、株式市場へ上場後に段階的な政府保有株の放出により、2017年（平成29年）10月までには完全民営化することになっていた。しかし、2012年（平

成24年)4月に、改正郵政民営化法が成立し、同年10月には郵便局株式会社と郵便事業株式会社が合併(日本郵便株式会社)し、持株会社および金融2社を合わせた4社体制となり、金融2社の株式については、全株処分義務が努力規定となった。その後、2015年(平成27年)11月に持株会社の日本郵政株式会社と同時に金融2社もその株式を売り出し、ようやく上場が実現したが、段階的処分であり、完全な民営企業としての公平な競争条件を整えるためにはいくつかの課題を残している。

なお、現在制約のある取扱商品や行える業務の範囲等は、順次見直されてきており、新規業務として認可されつつある。

(2) 損害保険

損害保険とは、保険者の支払うべき保険金額が保険事故の発生によって生じた実際の損害額に応じて定まる保険をいい、生命保険は保険事故(人の生存又は死亡)に関し、一定の保険給付を行うもの、すなわち、あらかじめ約定された保険金額が支払われる保険をいうこととされている。

「(旧)保険業法」では生保事業・損保事業の兼営が禁止されていたが、生損保それぞれの事業において取り扱える保険商品についての規定がなかったことから傷害保険、疾病保険等、いわゆる第三分野の商品が、生損保いずれの業務分野に属するものなのか議論が呼び起こされてきた。しかし、その後、双方の第三分野の商品開発が活発化する中で、この分野の商品について業務分野調整を行う意味合いは薄れつつあった。

このような状況の中で、1996年(平成8年)4月施行の改正保険業法において、生命保険、損害保険、第三分野の定義が明定され、第三分野については生損保本体で取り扱えることとし、それ以外の分野については子会社方式により相互参入が可能とされた。

その結果、生命保険会社が損保子会社を設立し、損害保険会社が生保

子会社を設立する形で、1996年（平成8年）10月より、生損保の相互参入が実現した。その後、親会社の合併等に対応した子会社の統廃合、買収等も行われたが、今日では参入業界で一定の事業規模を有するようになった子会社もある。なお、第三分野商品（傷害保険・がん保険等）の生損保本体での取扱いについては、日米保険協議の結果を踏まえ、一部制限する激変緩和措置が講じられたが、2001年（平成13年）7月に全面解禁された。今日では、保険法の施行により「傷害疾病定額保険」「傷害疾病損害保険」の定義付けも明確にされ（9～10頁参照）、第三分野は内外の生損保がともに力を注ぐ競争の激しい市場となっている。

（3）銀行・信託・証券業界

戦後の日本の金融制度は、「長短分離」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する専門金融機関制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における直接金融（証券発行による資金調達）のウエイトが高まった。金融の国際化も進展して、諸外国の金融制度との整合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社（または持株会社のもとでの兄弟会社）を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。

銀行・証券業界は生命保険の販売チャネルとしても重要性を高めてきている。証券会社は1998年（平成10年）12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売につい

ては、2001年（平成13年）4月、住宅ローン関連の信用生命保険と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年（平成14年）10月に個人年金の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。今日では銀行は個人年金の主要な販売チャネルとなっている。2005年（平成17年）12月には一時払終身保険、一時払養老保険や期間10年以下の準払養老保険等が販売対象に加えられた。

2005年（平成17年）の金融庁文書は、上記の一時払終身保険等の解禁から2年後にすべての保険契約を窓販の販売対象とすることとしていた。これに従い、2007年（平成19年）12月22日にすべての保険商品の窓販が可能（全面解禁）となった。なお、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢（保険契約締結後に発生する業務について保険会社と銀行の間で適切な分担を行うことや銀行等の販売責任者の周知を図ること）の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の法令等遵守態勢の整備等を行うことが求められている。

（注）上記の弊害防止措置は、全面解禁後も存置されているが、2012年（平成24年）4月より、枠組みを維持しつつ、規制の一部緩和や新たな実効性確保のための措置が講じられた。

（４）少額短期保険業

「1. 生命共済事業」で触れた「JA共済」や「こくみん共済 coop〈全労済〉」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監督を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済（いわゆる無認可共済）」が数多く設立され活動を行うようになっていた。

従来の保険業法は「保険業」を「不特定の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員＝「特定の者」を

相手に事業を行う「根拠法のない共済」は保険業法の適用対象から外れることとなり、保険業法上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。

こうした状況を解決するため、保険業法が改正され（2006年（平成18年）4月施行）、「不特定」という限定がとりはられるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。

「少額短期保険業」は、短期（生保・医療保険で1年以内、損害保険で2年以内）かつ少額保険金額（疾病による死亡保険金300万円以内、疾病・傷害による入院給付金等80万円以内、損害保険金1,000万円以内等で、かつ総額1,000万円以下（複数契約合算））の保険のみを引き受ける保険業である。

（注）2006年（平成18年）4月1日以前に共済事業を行っていた少額短期保険業者については、激変緩和措置として、引き受け可能な保険金額に対する段階的な経過措置がとられてきたが、保険契約者等への影響を踏まえ、2018年（平成30年）4月以降も更に5年間にわたって以下の措置（上限金額を縮小して延長）が継続されることになった。（平成30年4月～令和5年3月末まで）

- ・既契約者：平成30年3月末時点の保険金額以下で更新
- ・新契約者：一律本則の2倍まで

少額短期保険業者には1,000万円以上の資本金と内閣総理大臣への登録が求められる。また、ディスクロージャーと責任準備金の積立てが義務付けられ、早期是正措置も適用されるなど、少額短期保険業者にも契約者保護の規制が課される。

「根拠法のない共済」は、施行日から2年間（2008年（平成20年）3月まで）は「特定保険業者」という位置づけで事業を継続できたが、それ以降も事業を継続するためには、原則として「保険会社」として免許を受けると「少額短期保険業者」として登録しなければならないこととされた。

（注）「根拠法のない共済」の中には、保険業法上規定された適用除外団体や（認可）特定保険業者等で存続する共済がある。

第6章 民間生命保険会社の 今後のあり方

―― 学習のポイント ――

生命保険業界を取り巻く経営環境の変貌を捉え
今後の対応について概観する。

重要項目

- 商品面における対応
- サービス面における対応
- 販売体制における対応
- 機械化（システム動向）における対応
- 資産運用における対応
- 国際化における対応

1. 変貌する経営環境

(1) 経済・産業構造の変化

戦後の復興期以来、生命保険業界は順調に発展してきたが、これは経済の高度成長に支えられてきた面が大きい。高度成長期には、国民所得の増加により保険料への支出能力が高まる一方、企業保険市場においても企業経営の拡大基調の中で従業員福祉向上の一環としての保障需要が堅調であった。

毎年2桁の高度成長を遂げてきた日本経済も、1973年（昭和48年）の第一次石油危機を境に高度成長から安定成長路線に転換した。その後、第二次石油危機や、1985年（昭和60年）以降の大幅な円高という外的ショックにもかかわらず日本経済はそれらを克服し順調な拡大をした。特に1986年（昭和61年）11月から1991年（平成3年）初めまでの平成景気については、地価、株価の大幅上昇を伴い、いざなぎ景気に次ぐ長期の大型景気となった。

国家財政については、資産価格の上昇や資産取引の活発化などによる税収の伸びによって、1990年度（平成2年度）には赤字国債の発行が回避できるまでになり、一旦はいわゆる「財政再建」がなされた。

しかし、1990年（平成2年）以降の「バブルの崩壊」に伴うデフレ効果と高成長の反動による設備投資や耐久消費財等のストック調整から1991年（平成3年）初めに景気は後退に転じた。

その後は、景気低迷の長期化に伴い、税収の伸びも鈍化・減少した。一般会計の国債依存度はピークであった1979年度（昭和54年度）の34.7%から1991年度（平成3年度）にかけて大幅に低下したものの、数

次にわたる景気対策のため1992年度（平成4年度）以降は補正予算で建設国債の追加発行が行われ、さらに1994年度（平成6年度）からは5年ぶりに赤字国債が発行された。その後たび重なる景気対策で、国と地方の公的債務残高はGDPの総額を上回り、暦年ベース推計では2024年（令和6年）には債務残高がGDPの2.5倍（推計値）を超えている（IMF「World Economic Outlook」（2024年10月））。また、国債増発により急上昇してきた公債依存度は、近年の消費増税や景気回復基調の中での税收の伸びによって、2025年度（令和7年度）の政府当初予算（案）では24.8%と、コロナ禍の2020年度（令和2年度）の時期を除いて減少傾向にあり、リーマン・ショック前の2007年度（平成19年度）の水準近くまで抑制されている。しかし、社会保障費膨張等を主要因として、先進国の中で最悪の厳しい財政状態から容易に脱出できる状況にない。

企業においては、土地、株式の価格に関する「右肩上がり」の神話の崩壊により、土地や株式の含みを当てにした経営の見直しを迫られることになった。90年代前半は需要側の問題から低成長が続くことになったが、長期的には少子化の進展による労働力人口の伸びの低下など供給側の要因から成長率の低下が予想され、これまでの市場シェア重視の拡大路線から収益重視への転換を迫られている。

景気低迷で1993年（平成5年）以降家計の消費が落ち込む一方、バブル期のような伸びはないが家計の「ストック化」は着実に進んでいる。また、金融自由化・金利自由化に伴って新しい金融商品が次々と開発され、家計の貯蓄をめぐる金融機関間での獲得競争も激しくなっている。

(2) 社会構造の変化

ア) 高齢化

日本人の平均寿命は、厚生労働省令和6年簡易生命表によれば、男性81.09歳、女性87.13歳となっており、日本は今や世界トップクラスの長寿国である。一方、出生数は、近年の単年度における微増はあっても、昭和40年代の第二次ベビーブーム以降の長期的な減少は続いており、2016年（平成28年）には過去最低の100万人を割る等（厚生労働省「人口動態統計（年間推計）」）その傾向に変化はない。

平均寿命の伸びと出生数の減少に伴って、全人口に占める高齢者の割合は高まってきており、1970年（昭和45年）には7.1%であった65歳以上人口の割合が、1980年（昭和55年）には9.1%、2010年（平成22年）には23.0%、2020年（令和2年）には既に28%を超えている。なお、2060年（令和42年）には37.9%に達し、日本の人口の2.6人に1人が65歳以上人口となると予測されている（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2023年（令和5年）推計）」による）。国連では老年人口割合が7%を超えた国を人口の高齢化が進んでいる国と見なしており、その意味では日本も1970年（昭和45年）にその仲間入りをしたことになる。

日本における高齢化の特徴は、先進諸国と比べそのテンポが極めて速い点にある。主要各国について、65歳以上の人口比率が7%から14%へ倍増するのにかかった期間を見ると、フランスは115年、スウェーデンで85年、イギリスで47年、ドイツで40年を要したのに対し、日本はわずか24年、すなわち1994年（平成6年）に老年人口の割合が14%の水準に達している。このように超スピードで

進行する高齢化は、社会・経済面に様々な問題を生起させている。

高齢化がもたらす最大の問題は、高齢者扶養負担がますます重くなることである。65歳以上人口1人を何人の15～64歳人口で支えているかを見てみると、1980年（昭和55年）は7.4人であったのが、2000年（平成12年）には3.9人、2020年（令和2年）には2.1人、2050年（令和32年）には1.4人に減少し、働き手による高齢者扶養負担は急速に高まっていく見通しである。しかも、高学歴化によって15～19歳の人口の大半が生産活動に従事していないことを考えると、実際の負担は一層深刻となるであろう。

2023年度（令和5年度）の社会保障給付費（ILO基準）は総額約135.5兆円、対GDP比率約22.8%である。前年度と比べ2兆6,809億円、1.9%の減少ではあるが、依然として高水準を維持している。

社会保障給付費を増大させる主要な要因となっているのは、高齢者の増加による医療費の増大と、年金給付額の増大である。国民一人が生涯に必要な医療費は2,873万円（厚生労働省資料より：生涯医療費の2022年度（令和4年度）推計）とされるが、高齢者になるほど医療費がかかることから、このうち約半分の1,361万円が70歳以上で必要になる。この結果、高齢化の進展は確実に医療費の増大を招いている。また、社会保障給付費のうち、一番多いのは年金であり、実に41.6%を占める。ついで医療が33.6%、福祉その他24.7%（うち介護対策8.6%）となっている。1981年度（昭和56年度）以降、年金が医療を上回る状況が続いている（「令和5年度社会保障費用統計」国立社会保障・人口問題研究所）。

高齢化の進行とともに、社会保障給付費は急増しているのが現状であり、これに対し、被保険者数は出生数の減少を反映して横ばい状況か

ら近年は減少傾向となっているため、保険料収入は伸び悩み、その結果、医療保険部門、年金保険部門の収支は悪化しており、社会保障制度全般の見直しが進められている。

イ) 少子化

一方、少子化が急速に進行している。

合計特殊出生率は年々低下し2005年度（平成17年度）には1.26となり、出生数が死亡数を下回って遂に人口が減少するという歴史的転換点を迎えることとなった（2024年（令和6年）の合計特殊出生率は1.15と依然として厳しい状況が続いており、女性の人口も減少する中でこの出生率が上昇しなければ出生数は減り続けることになる：厚生労働省「令和6年人口動態統計月報年計（概数）の概況」）。

少子化のもっとも大きな原因は晩婚化・非婚化である。表9、表10のとおり30～40歳代層の未婚率は近年急上昇している。

表9．年齢階級別未婚率の推移（各年の国勢調査）（％）

	男 子				女 子			
	平成12年	22年	27年	令和2年	平成12年	22年	27年	令和2年
30～34歳	42.9	47.3	47.1	51.8	26.6	34.5	34.6	38.5
35～39	26.2	35.6	35.0	38.5	13.9	23.1	23.9	26.2
40～44	18.7	28.6	30.0	32.2	8.6	17.4	19.3	21.3
45～49	14.8	22.5	25.9	29.9	6.3	12.6	16.1	19.2

（各年の男女別年齢階級別の人口に対する割合）

表 10. 年齢階級別配偶関係割合(令和 2 年国勢調査)

(%)

	男 子			女 子		
	有配偶	未婚	離別・死別	有配偶	未婚	離別・死別
30 ～ 34 歳	46.1	51.8	2.1	57.4	38.5	4.0
35 ～ 39	58.2	38.5	3.4	67.7	26.2	6.1
40 ～ 44	63.1	32.2	4.6	70.5	21.3	8.2
45 ～ 49	64.0	29.9	6.2	70.0	19.2	10.9

(令和 2 年の男女別年齢階級別の人口に対する割合)

ウ) 女性の社会進出

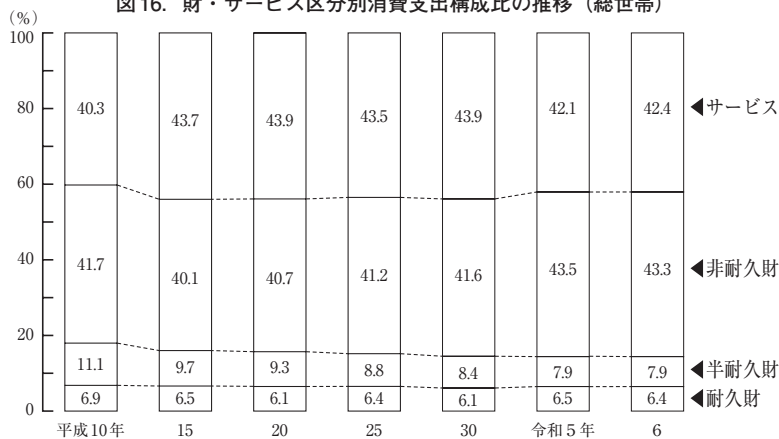
女性の雇用者数は着実に増加しており、年齢 5 歳階級別の労働力率は、2015 年に比べすべての年齢階級で上昇している（令和 2 年国勢調査）。こうした女性の社会進出の積極化は、共働き世帯の所得増加をもたらし、家事代行サービスや外食等のサービス関連支出増につながり、経済のソフト化、サービス化を促進する要因となっている。

(3) 消費構造の変化

総務省の調査によれば、全就業者数に占める第三次産業のウエイトはほぼ一貫して上昇を続けており、1965 年（昭和 40 年）には 44.0%であった占率が、2009 年（平成 21 年）には 69.5%を占めるに至っている（総務省：平成 21 年「労働力調査（年平均）」）。

2010 年（平成 22 年）以降の上記調査では、産業分類の変更により第 1 次から第 3 次産業の就業者区分がなくなっているが、従来の第 1 次産業に相当する「農業・林業」等の就業者数は、その後も引き続き減少傾向となっている。最近では「情報・通信」、「医療・福祉」等の新分野サービス業が増加傾向にある（総務省：令和 6 年「労働力調査年報」）。このようなサービス産業への就業者のシフトは、消費構造の変化を反映している。

図16. 財・サービス区分別消費支出構成比の推移（総世帯）



資料：総務省「家計調査年報（令和6年）」

近年の家計消費支出構成（総世帯）は、財（商品）とサービスの構成比が約6対4の割合で推移している（図16）。それぞれの消費支出の内訳が季節的（行政措置等含）要因によって変動しているものの、消費構造はかつての「物（財）」主体からサービス消費が拡大した消費構造へ変化している。

こうした“モノ離れ現象”は、人々の所得が増大し主要な耐久消費財を買い揃えた結果、物に対する充足感が高まったためと考えられる。

消費者のニーズも、これらの変化を大きな要因としてますます個性化、多様化してきている。1つの商品を選択するに当たっても、従来であれば、「周りの人が持っているから」とか「テレビのコマーシャルで見たから」といった外的要素に左右される面が多かったのであるが、今日では、自分の好みに合っているか、本当に必要か、価格は適切かななどを判断し、自分で納得のいく商品を購入する方向に変わってきている。

消費者の購入態度が、このように変化する中で、企業としても従来の画一的商品を大量生産、低価格で販売するという戦略だけでは対応し切れなくなってきた面もあり、どの業界、どの企業にとっても、いかにニ-

ズを先取りし、他に先駆けて新製品を市場に提供できるかが、重要な課題となっている。

(4) IT技術の進展によるネットワーク社会の到来

パソコンやインターネット、高速・安価なブロードバンドネットワーク等の急速な普及・技術進展に伴い、企業内および企業間、社外（代理店や顧客等）とのネットワークが拡大し、情報サービスの高度化が進められている。

企業内のネットワークとして生保各社では、大型コンピュータと全国の営業店舗の端末を結ぶ、大規模なオンラインネットワークシステムを構築している。また、インターネット技術を企業内情報システムに活用したイントラネットも普及し、企業内の情報の共有化やコミュニケーションの円滑化が図られている。

企業間のネットワーク化として生保業界においても、1986年（昭和61年）5月、「LINC（Life Insurance Network Center）」と呼ばれる生保業界共同のネットワークシステムを構築した。このシステムは複数システムからなる多目的VAN（付加価値情報網）である。具体的には、①団体保険の共同引受契約の決済等を行う各社間決済システム、②医療保障保険における同一被保険者の重複契約を確認するための医療保障保険契約内容登録システム、③入院給付金及び高額保険金の重複加入状況を確認する契約内容登録システム、④生命保険募集人登録システム、⑤月払団体扱生命保険データ集配信システム、⑥財形保険データ集配信システム、⑦国民年金基金データ集配信システム、⑧事業統計データ集配信システム、⑨統合レポートデータ交換システム、⑩支払査定時照会システム、⑪企業年金幹事間データ集配信システム、⑫死亡率等統計システムである。業界の共通基盤として、「LINC」の果たす役割は非常に大

きいといえる。

代理店とのネットワーク化として、多くの生保会社がWeb型の代理店システムの構築を進めている。代理店はパソコンからインターネットを介して、取扱契約内容の照会、見積書の作成などの機能を利用している。また、2001年（平成13年）には生保損保業界共通で代理店ネットワークシステムの標準仕様を策定し、代理店システムの利便性向上が図られた。

顧客とのネットワーク化では個別金融機関とのATM提携の進展とともに、電話による自動取引サービスも提供しており、1990年（平成2年）6月より、業界各社利用の自動照会応答システム「生保ANSERシステム」を稼動させた。

インターネットを利用したサービスについては、単なる会社情報や商品関連情報の提供から拡大してきており、住所変更等の事務受付、ATM同様の自動取引サービス、保険設計・見積り、保険申込・初回保険料の払込まで提供している例があり、規制緩和・技術革新の動向を踏まえ、更なるサービスの向上が図られている。

生保各社では、更なる顧客サービスの充実、業務・システムの効率化を目指した情報サービスの高度化が不可欠である。技術進展や各種法制度の整備等を通じてセキュリティ面での対応も進み、インターネット技術を活用した企業内や企業間、社外とのネットワークの強化が進んでいる。

（５）金融の自由化・国際化

日本における金融自由化は、プレイス（場所）、プライス（価格＝金利）、フィールド（業務分野）という3つの領域で進んでいる。国債の大量発行、経済・金融の国際化の2つの「コクサイ」化と、機械化の進展下において、最初に自由化されたのはプレイスで、1980年（昭和55年）12月の外国為替管理法の改正により、日本の金融機関の海外進出や外国金

融機関の対日進出が原則自由となった。

日本の預金金利は、1947年（昭和22年）に制定された臨時金利調整法により、長い期間にわたりその上限が規制されてきた。規制金利は、預金金利を人為的に低水準に抑えることにより銀行の資金調達コストを低減し、貸出金利を低く抑えるという効果を生み、戦後の経済復興、高度成長を下支えする主因となった。しかし、国債の大量発行や外為法の改正により、公社債市場や海外市場を中心に自由金利市場が拡大した結果、大口資金を中心に金利が人為的に低く抑えられていた預金から自由金利商品への資金シフトが顕在化した。

このような現象を踏まえて、1979年（昭和54年）5月にはその金利が臨時金利調整法の対象外とされた譲渡性預金（CD）が創設され、1985年（昭和60年）3月には市場金利連動型預金（MMC）が登場し、10月には、大口定期預金も導入された。これらの自由金利預金は順次最低受入金額が引き下げられ、1993年（平成5年）6月には定期性預金金利が完全に自由化されるに至った。また、流動性預金（当座預金を除く）についても、1994年（平成6年）10月に金利が自由化され、日本の預金金利自由化は完了した。

一方、業務分野についても自由化が進められており、1982年（昭和57年）4月の銀行法改正を契機としたディレギュレーション（規制緩和）の動きに歩調を合わせ、銀行、証券を中心に様々な新しい業務が展開されてきた。

まず、証券会社では、中期国債ファンド、MMF、証券総合口座等、投資信託機能を活用した高利回りで流動性の高い商品が次々に開発され、実質的に預金類似業務への参入が進んだ。さらに、国債担保金融も実施し、貸付業務にも進出している。

これに対し、銀行も国債の窓販やディーリング等を通じて、証券業務へ進出することにより、証券会社との競合の度合いを強めてきた。また、1998年（平成10年）12月より、銀行による投信の窓口販売が解禁された。

流通業界の動きも活発となっており、消費者金融分野にとどまらず、生損保分野にまで進出し、金融サービスの拡大を図っている。

ところで、金融の国際化が進む中で、外国生命保険会社、銀行、証券会社等の動きが活発化している。これらの会社は独自の販売手法や特徴のある商品で業績を伸ばしており、生命保険業界の多様化を反映している。

従来、年金資産の運用は信託銀行と生命保険会社が行っていたが、日米円ドル委員会報告書の公表を契機に外銀系信託銀行が日本市場に進出したほか、国内の銀行、証券会社も1990年度（平成2年度）以降系列投資顧問会社を通じて年金運用業務に参入している。

上記のような業務の部分的・段階的自由化が進みその限界に直面したことから、1985年（昭和60年）より金融制度全般の見直しが金融制度調査会・証券取引審議会を中心に検討されるに至った。

1994年（平成6年）の保険審議会報告では、保険業界と、銀行・証券業界との参入については、保険業界内での生・損保の相互参入やその他の自由化の進展・定着を見極めた後に段階的に行うこととされた。その結果、2001年（平成13年）に銀行による住宅ローンの団体信用生命保険、長期火災保険の販売が認められて、さらに、2002年（平成14年）10月より個人年金保険や財形保険、2005年（平成17年）12月より一時払終身保険、一時払養老保険等、2007年（平成19年）12月より全ての商品の販売が認められている。

1996年（平成8年）11月、総理大臣より大蔵大臣に、2001年（平成

13年）までに日本の金融市場をニューヨーク・ロンドンに並ぶ国際金融市場とすることを目指す、金融システム改革（日本版ビッグ・バン）が指示された。この改革は、フリー、フェア、グローバルの3原則に則り、①参入・商品・価格等の自由化、②ルールの明確化・透明化、投資家保護、③グローバル化に対応した法制度、会計制度、監督体制の整備、を実現することを目的としている。日本版ビッグ・バンについては第2章4（8）で述べたとおりである。

（注）上記改革は順次進行中であり、また保険会社の健全性確保や有効な監督・規制等の国際的な基準に関しても検討が進められている。

2. 新たな対応に向けて

（1）商 品

生命保険会社の販売する商品種類の構成は、伝統的商品である養老保険、定期保険特約付養老保険中心から、終身保険、定期保険特約付終身保険、一時払養老保険、医療保険、変額保険へ広がり、さらに若者、女性、中高齢者向けの商品というように多様化が進んでいる。また、販売チャンネルに関しても、従来の営業職員販売のみならずインターネット・通信販売や銀行での窓口販売等多様化してきている。

ア）伝統的商品の内容充実

生命保険文化センターが、2024年（令和6年）に実施した「生命保険に関する全国実態調査」によると、生命保険加入金額は世帯主の普通死亡保険金で、1,258万円となっている。しかし、万一の場合に必要な遺族の必要資金額は6,283万円であり、実際に加入している金額との隔たりは大きい。成熟化が進んでいるとはいえ、生命保険の基本的機能である死亡保障ニーズは潜在的にはまだ

まだ掘り起こすことが可能なのである。

一方、同調査の生命保険の加入目的を時系列でみると、長い間、加入の最大目的であった「万一のときの家族の生活保障のため」は頭打ちとなり、「医療費や入院費のため」が増加してきた。2024年（令和6年）調査でも「医療費や入院費のため」は57.5%と、「万一のときの家族の生活保障のため」の50.0%を超えており、最大の加入目的となっている。生命保険の加入目的は、死亡時の遺族の生活保障のみから、医療費や入院費の保障なども含む幅広いものとなってきた。また、最近は死亡保険金を一時金のほか、遺族年金として受け取るタイプの商品や入出金可能な貯蓄機能、終身にわたる医療保障、介護保障などの生前給付型の保障を組み合わせた商品も開発されている。このように伝統的商品であるこれらの保険については、死亡保障をメインにしつつ、消費者の多様化・高度化するニーズに対応しうよう、機能の拡充、高付加価値化を図っていくことが必要である。

イ) 年金型商品の充実

高齢社会を迎える中で、生命保険業界をはじめ損保、銀行、信託、証券等あらゆる金融機関が各種の年金型商品を開発し販売している。その中で、生命保険の取り扱う個人年金保険には年金支払期間を一生涯とすることができる点、各種の医療関係特約を付加することができる点等において他の金融機関の年金型商品と比べて優れた特色がある。

近年の商品開発という面では、夫婦二人を被保険者として、夫婦いずれかが生存している限り年金を支払う「連生年金」、年金の受け取りが始まる前の被保険者の死亡保障を既払保険料相当額に抑

え、その分長生きした人の年金受取額を多くして生存保障性を強めた年金などが開発されている。さらに、特別勘定資産の運用実績により受け取る年金額が変動する「変額年金」も開発された。

なお、変額年金については、従来より取り扱っていた証券会社に加え、銀行での窓口販売も解禁となり、販売チャネルも多様化してきている。

ウ) 医療保障商品

健康保険制度の改正に伴い、1997年（平成9年）9月に、医療費について本人1割負担から2割負担に変更され、さらに2003年（平成15年）4月には3割負担に変更されたことなどにより、医療保障ニーズは一段と高まっている。従来、医療保障商品は、外資系生命保険会社、中堅生命保険会社のみに単品での販売が認められていたが、2001年（平成13年）1月より大手の生命保険会社や損保系生保に医療・がん保険の販売が解禁され、次いで同年7月から損保本体による販売も解禁された（第三分野全面解禁）。また、がん・脳卒中・急性心筋梗塞に罹患した場合（脳卒中・急性心筋梗塞については、所定の後遺症が継続することが条件となる）に、死亡保険金と同額の保険金を支払う特定疾病保障保険も開発された。

一方、高齢化の進行に伴い大きな社会問題となっている認知症や寝たきりなどの老人問題についても、認知症や、寝たきりによる要介護状態を保障する保険が販売されるなど、介護保障分野へも積極的に開拓を行っている。

また、生命保険業界においては、従来の入院医療特約や医療保障商品に加え、特定疾患の治療・療養時の給付、精神疾患に対するリハビリ、寝たきり老人のケア等、現金の給付だけではなく、施設やサービスを現物支給するタイプの保険商品の可能性の検証も検討課

題の一つである。

(注) 保険金等のサービス提供者への直接支払い（キャッシュレス）や不妊治療に係る商品等の開発検討も金融審議会（平成25年）で報告され、その後、法的措置が施され取扱いが可能となったため、既に一部の保険会社では同サービスや当該商品の提供を開始している。

エ) カード

生命保険は、従来一般的に、加入すると満期の時まで期間が長いことから、加入実感に乏しく、他の金融商品に比べ顧客に対する利便性の付与という点で必ずしも満足のいくものではなかった。

カードの開発は、こうした問題点を解決し、契約者サービスの充実を図るものである。具体的にはATM、CDによる契約者貸付や積立配当金の引き出し等の保険取引等が行われている。また、カードによるサービス提供を行う生保会社が増加しているという背景の下、1992年（平成4年）10月より生保共同ATM、1995年（平成7年）10月からは生命保険会社のATMの相互利用がスタート（現在はいずれも廃止）したが、現在では郵貯ATM（1999年（平成11年）1月より）をはじめ、銀行のATMやコンビニエンスストアのATMと提携する生保会社も多く、他業態との提携により、顧客の利便性の向上を図っている。

(2) サービス

前述のような変貌する経営環境の中で、今後の生命保険会社には、生命保険商品を提供するだけでなく、生活設計や生活保障に関する情報提供、各種の金融知識や税務知識の提供、保険金の運用アドバイスなど、FP（ファイナンシャル・プランニング）といわれるコンサルティングサービスが求められている。

銀行・証券業界でも、近年盛んにファイナンシャル・プランニング・サービスが行われているが、生命保険商品の特性から顧客の将来にわた

る生活設計を前提にプランニングを行う生命保険会社のFP（いわゆる生保FP）はFPの代表的存在といえよう。

このような環境から、生命保険各社ではファイナンシャル・プランナー等の名称を付した多様かつ高度な知識を有した担当者の育成に積極的に取り組んでいる。

本格的な高齢化社会の到来を間近に控え医療・介護等に関するサービスへのニーズが高まっているが、生命保険会社においても、従来の保険商品による金銭給付のみならず、これまで蓄積された高齢者の生活設計に関する知識・ノウハウや経営資源等を活用して、健康、介護、福祉、住宅等各種サービスの提供を通じ、高齢者の生活の安定に貢献していくことが重要な課題の一つとなっている。

こうしたニーズに応えるため、生命保険会社は早くから医療や健康問題に関心を持ち、人間ドック紹介、健康相談サービス、介護事業者の紹介等を行っている。

生活水準の向上、人口の高齢化等社会構造の成熟化が進展し、生命保険事業の役割が見直される中、生活関連サービス分野は、今後更に、経営資源を生かしつつ積極的、多面的に取り組むべき分野となろう。

（注）2014年（平成26年）11月には、保険会社の子会社の範囲に老人福祉施設等に加えて保育所等の運営業務も新たに追加された（保険業法施行規則）。

また2007年度（平成19年度）、多くの会社で保険金の不払いが発生していることが明らかになった。このため、生保各社および生命保険協会では、顧客の視点に立った意識改革を進め、契約から保険金の請求・支払段階に至るまでの各段階において保険金等を適切に支払うための態勢整備を行い、信頼を回復できるよう取り組んでいる。

生命保険協会では、①生命保険事業の社会的責任・使命を踏まえた行

動規範の見直し、②実務上の留意点をまとめたガイドラインの見直し、③募集人教育の充実・支払査定担当者に対して「生命保険支払専門士試験」の実施、④苦情・相談体制の強化、⑤診断書の標準化・電子化等、具体的な取り組みを実践している。さらに、契約者・被保険者の平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等に、生命保険契約の有無についての照会を受け付け、一括して各生命保険会社に調査依頼を行い、その調査結果をとりまとめて照会者に回答する「生命保険契約照会制度」を2021年（令和3年）7月に創設した。

（３）販売体制

これからの生命保険商品の販売を予測すると、生命保険の世帯加入率が約9割（生命保険文化センター：「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査」）に達している成熟市場の中で、消費者のニーズはますます多様化、高度化しており、それに対応できるような仕組みを持つ高付加価値商品の開発が相次ぐものと思われる。このため、生命保険募集人は、これまで以上に幅広い知識に基づく総合的なコンサルティング力を要請されることになろう。そのためには、生命保険業界にとって今後とも優秀な資質を持った営業職員を採用するとともに、教育体制を充実させることによって従来以上にレベルの高い、ライフ・コンサルタントとしての営業職員を多数育成していくことが不可欠である。このため、生命保険協会において業界共通教育制度を見直し、1992年度（平成4年度）より現課程名称の新制度（生保大合格＝生保FP（TLC）を目指す）を実施している。なお、2009年度（平成21年度）には継続教育制度をスタートしてコンプライアンスの徹底を図り、また、2011年度（平成23年度）には大学課程カリキュラムの全面改訂を行った。また最近では、各社とも、顧客のニーズに対応する必要性の高まりから、

ファイナンシャル・プランナーを旨とする教育には、極めて積極的である。例えば、自社開発のテキストによる通信教育方式の研修を行ったうえで、社内修了試験を実施し、社内認定する方法で教育を展開したり、民間団体のファイナンシャル・プランナー資格や厚生労働省認定のFP技能検定資格取得制度を準用することで、社内認定する方法なども採用されている。

その教育内容は、保険商品に関する知識だけでなく、金融、税務、不動産等幅広い知識修得を要求する等、各社の工夫が見られる。

現在各社で取り組んでいる、職域専門や高額保険をターゲットとする営業職員の育成は、そうしたライフ・コンサルタントとしての営業職員の更なる高度化の一つの方向といえよう。しかし、このような営業職員体制の強化は、教育の充実や相対的に高い水準の給与支給が前提となるため、経営コスト面での問題を抱えているのも事実であり、販売支援の強化による営業職員の生産性向上や機械化等による事務コスト、管理コストの圧縮等を図る必要がある。

そして、今後ますます激しくなると予想される隣接業界との競争の鍵を握るのがコストの問題であることを考えれば、市場の状況や商品によっては低コストの新たな販売対応が必要となってこよう。

日本においても、既に一部の生命保険会社では、通信販売や店頭販売を実施している。今後は、コスト面からの要請に加え、消費者への生命保険に関する知識の普及、浸透が進んできたことを考え、商品特性に応じた販売チャネルの効率化、多様化についても検討を進めていく必要があろう。

営業職員以外の販売チャネルの例としては、一社専属の営業職員とは異なり、複数の保険会社の商品を取り扱うことのできる代理店チャネル、及び人的チャネルを介在しないダイレクトチャネルが挙げられる。

代理店チャネルについては、1996年（平成8年）4月の改正保険業法施行（子会社による生損保の相互参入解禁）を機に市場参入した損害保

険会社の子会社生保が、メイン販売チャネルとしたことにより急速に市場シェアを拡大した。近年では、内国生保においても、営業職員チャネルと代理店チャネルとのチャネルミックス販売体制が定着してきている。また、2002年（平成14年）10月より、銀行窓口による一部生命保険商品（個人年金保険）の販売が、2005年（平成17年）12月より、一時払終身保険等、一部の貯蓄性商品の販売が解禁され、生命保険市場全体に占める銀行窓口における新契約の占率は、大幅に増加した。さらに2007年（平成19年）12月には全ての商品の販売が解禁され、徐々に定着しつつある。

一方、ダイレクトチャネルについては、欧州で盛んな自動車保険のテレマーケティングを中心に、日本でも普及してきた。また、インターネットの利用により、商品や決算等の情報提供をはじめ資料請求や各種手続の受付を行う等、利便性は向上している。一部生保では、医療保険などについて、ダイレクトチャネルで申込手続を完結できるようになっていたり、インターネットを主たる販売チャネルとする生保会社も現われてきており、インターネットの普及を背景としたダイレクトサービスについても今後の展開が注目される。

（注）投資信託や市場リスクを有する貯蓄性保険の主な販売チャネルである銀行等に対しては、販売手数料の開示が求められており、現在、自主的な取り組みの中で可能な範囲での顧客への情報提供が始まっている。今後の大きな課題である。

（４）生保業界におけるシステム動向

IT技術の進展により、新技術の有効活用による商品・顧客サービスの充実、営業職員・代理店への販売支援強化等を図ることが必要になってきている。

具体的には、①携帯用端末等を利用した各種情報提供による顧客サービスの充実、②視聴覚メディア活用（通信衛星等）による営業教育の充

実、③情報伝送量の飛躍的拡大およびイメージ処理の導入による事務生産性の向上、④生保業界の共同VANの構築による企業関連サービスの充実、⑤インターネットを活用した代理店での営業活動・事務への支援などが実施されている。

もう一つの大きな動きは、IT技術の進展に伴うシステムの高度化とそれによる事務革新のうねりである。

銀行業界では、昭和40年代に事務作業の合理化、省力化を目指した第1次オンライン化を実施し、昭和50年代には銀行間ネットワーク、ATM、CDの導入等を内容とした第2次オンライン化を行い、内部事務の合理化を促進してきた。そして昭和60年代以降には、金融の自由化・国際化の中で、新商品、新サービス競争、金利競争等様々なニーズを踏まえて、各行とも巨額なシステム投資を行い、高度情報技術を取り入れた収益志向型の情報システム（いわゆる第3次オンライン）の構築を行った。近年は、より高度な金融商品やサービスを迅速かつ低コストで提供できるシステム基盤の整備が求められており、一部の銀行ではポスト第3次オンラインシステムへの移行を進めている。

生保業界も昭和40年代から50年代にかけて、本部支社事務の機械化を中心に全国規模のオンライン化を進めてきた。そして、昭和60年代以降、顧客サービスの充実、営業活動の強化、現地完結による効率化を目的とした総合情報システムとして、複数の大型コンピュータを中心に全拠点の数千台規模の端末を網羅した巨大オンラインネットワークシステムを構築してきた。

生保各社のコンピュータ適用分野は、①個人保険、②団体保険、③資産運用、④営業支援、⑤経営情報、⑥総務等、⑦業界共通、⑧イントラネット、⑨顧客サービスに大きく分類できる。中でも、個人保険分野が、

最初に機械化された分野である。それは、個人保険の膨大な契約量と長い保険期間により、生命保険事務の中で最も事務量が多く、機械化のメリットが高いためである。一方、団体保険は、契約毎に制度内容が異なるため機械化が遅れたが、現在では多くの会社で積極的な対応が行われている。資産運用分野は、個人保険や団体保険等の契約管理システムに比べ新しい分野であるが、金融の自由化・国際化の中で、急速に進展している。また、営業支援分野も、総合情報システムの重要な分野であり、セールスマンが訪問先で小型・軽量の携帯用端末を利用して、保険料・配当金計算などの保険設計や将来に向けての必要保障額計算などの生活設計を行うことも可能となっている。経営情報についても、情報資産の活用という観点からシステム化が進められており、総務等についても全社的なシステムが構築されている。業界共通のシステムは、団体定期保険の共同契約等生保各社が共同で契約を結ぶ場合に必要であり、生保共同センター（LINC）が設置され、業界内ネットワークの共通基盤となっている。近年、パソコン等の技術の進展がめざましく、オフィスに多数のパソコン等の情報機器が導入されており、個々の機器をLAN等でネットワーク化してイントラネットシステムを構築し、社内の情報連携の効率化・情報の共有化を図っている会社もある。また、顧客サービス領域では、来店や電話等による顧客の申し出に対して迅速に対応できるシステムの構築や、インターネット・ATM等に代表される顧客ネットワークサービスの高度化と拡充が進められている。

近年の規制緩和による商品・サービスの高度化、販売チャネルの多様化に対応するため、戦略情報システムの構築が進められている。更なる事務・システムの効率化、サービス向上により、如何に競争力の維持・強化を図っていくかが今後の課題となっている。

近年では、事務・システムの効率化として、新契約時の第1回保険料や第2回以後の継続保険料の払込みやその手続きについて、キャッシュレス化やペーパーレス化が急速に普及しつつある。また、ホームページ上でのさまざまなお客さまサービスを提供する会社が増加している。

(注) 商品やサービスの高度化・複雑化、および国際化の中での経営再編やネットワーク化の拡大により「システムリスク管理体制」の充実・強化も重要な課題となっている。また、2015年（平成27年）10月に「マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）」が施行され、2016年（平成28年）1月からは個人番号（マイナンバー）の利用が開始されており、その管理・運営体制の構築も求められている。

（５）資産運用

① 本体での資産運用の今後のあり方

一般勘定における生命保険商品は長期にわたって予定利率を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる「逆ざや」が長期間続いてきた。生命保険会社によっては解消傾向にあるとはいえるものの、楽観できる状況にはない。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取り組むべきものがリスク管理体制と ALM（Asset Liability Management＝資産負債統合管理）体制の整備・充実である。

リスク管理体制面では、法令等の遵守（コンプライアンス）、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、信用リスク・市場

表 11. 関連会社で行うことができる主な資産運用関連業務

年 度	内 容
昭和 50 年	不動産管理業務
	信用保証業務(住宅ローン)
昭和 58 年	公共債投資代行業務
	信用保証業務(消費者ローン)
	リース業務
昭和 60 年	抵当証券業務
	投資顧問業務
昭和 62 年	ベンチャー・キャピタル業務
	消費者ローン業務
平成 7 年	証券投資信託業務
平成 12 年	不動産投資信託業務

リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながるごととなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。

次に ALM については従来より研究がなされてきたが、1996 年（平成 8 年）4 月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の負債特性を有するため、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。

② 子会社による金融関連業務への進出

生命保険会社本体では、保険業法により、保険業（保険の引受け、資産運用）及び保険業に付随する業務（国債窓販等）、法定他業（公共債ディーリング等）以外の業務（証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等）は営むことができない。

しかしながら、従来より、規制緩和の進展等に伴い、資産運用の効

率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社（本体の株式保有比率は10%以下）で営むことが認められてきた（表11）。

1998年（平成10年）12月の金融システム改革法の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社（本体が50%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が50%超の議決権を保有する会社）それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。

生命保険会社本体においては、証券投資信託受益証券の販売業務、デリバティブ取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。

今後は、業務の多様化が可能となった反面、競争の激化は避けられない。しかも、従来の金融機関間の競争のみならず、異業種・海外からの保険・銀行・証券業務への参入が活発となってきている。更に、大手都銀の再編を発端とする大規模な金融グループ化の進展に伴い、従来の自前を前提とした新規参入分野の選択に加え、思い切った業務提携による効率的な経営資源の配分が重要となろう。

（6）国際化

日本経済の国際化の進展に伴い、生命保険会社においても、情報収集、海外投融資の実行、海外における事業収益基盤の構築などのニーズが生じ、海外拠点の必要性が高まった。こうした状況下、生保各社は、情報収集・調査業務を目的とする海外駐在員事務所や、円ローン業務・証券投資業務・調査業務等を行う多目的現地法人、不動産現地法人、保険仲介現地法人、保険元受現地法人等海外現地法人の設立を行った。

また、生保会社のみならず業態・国境の垣根を越えた各金融機関との競争が激化してきており、内国生保同士の合併・統合ばかりでなく、外国生保の日本市場への本格参入も目立ってきている。そのため、生保会社の中には、海外金融機関との提携や合弁運用会社（投資顧問会社等）の設立を通じ、海外運用力の強化や日本市場での年金・投信商品の充実など海外市場のノウハウの取り込みを図っているところも現れている。

① 海外駐在員事務所

生保各社が海外駐在員事務所を開設し始めた当初は、金融・保険等各種の情報収集を目的としてニューヨークに開設するケースが多かったが、その後海外投融資の拡大・グローバル化の流れを受け、世界各地の情報収集の必要性が高まり、次第にヨーロッパ・アジア等各地域の主要都市にも開設された。

② 海外現地法人

ア) 多目的現地法人

資産運用環境の国際化に対応し、投資運用業務の現地化を推進する観点から、従来海外駐在員事務所で行ってきた情報収集・調査業務に加え投資運用業務も併せて行う、多目的現地法人を設立している生保会社もある。

イ) 不動産現地法人

大手各社は80年代初頭より不動産現地法人を設立し、米国および欧州を中心に不動産投資を拡大した。しかし90年代に入ると各国不動産市況の悪化により業績は低迷、また、急速な円高も進行したことから、多くの会社が投資の見直しを行った。一方、90年代中頃より欧米不動産市況は回復、また米国については、不動産保有、商業用不動産モーゲージ貸付、証券型不動産投資

(REIT,CMBS)等、商品・市場の多様化が進んだことから、更なる投資機会を追求する会社もある。

ウ) 保険事業

これまでの生保会社の海外での保険事業展開は、

(a) 海外進出日系企業に対する保険サービスの提供

(b) 海外における元受保険会社経営

の2つの活動に大別出来る。

(a) については、現地法人を設立して現地保険会社商品の仲介を行う活動が行われてきた。また、現地法人は持たなくとも、海外の生保会社と国際的な提携関係を結ぶことにより、海外進出企業に対し団体保険を相互に紹介し合うという国際保険提携も一般化している。(b)については、保険元受現地法人の設立に加え、現地保険会社への出資により経営に参画する事例も出ている。

③ 海外金融機関等との提携

規制緩和による業態を越えた競争、さらにはグローバルな運用力や先進的な商品開発力を携えた外資系金融機関との競争が激しさを増してきた。こうした状況下、欧米等海外の金融機関や資産運用会社、保険会社と提携する生保会社が出てきた。こうした提携の中には、合弁運用会社の設立を通じて、グローバルな資産運用力の向上、年金運用分野・投資信託分野における商品ラインアップの充実を図るものや、提携先との投信商品の共同開発、または提携先から商品の提供を受ける形で商品ラインアップの充実を図るもの等がある。

また、団体保険販売に関する海外保険会社との提携や、個人保険での提携先との商品の共同開発等、保険分野においても同様に海外金融機関との提携を行うケースが出てきている。

④ 今後の国際化の方向

今後の生命保険業界の国際化の方向については、日本の生保会社の海外進出と国内市場の国際化が考えられる。

生保会社の海外進出については、少子高齢化など、日本市場の成長に対する一定の制約要因が出てくる中、事業収益基盤の確保を海外に求め、海外進出を行うことも一つの方向であると考えられる。欧米保険会社の中には、既に自国の保険マーケットの成熟に伴い、アジア・ラテンアメリカ等海外成長市場へ積極的な進出を図っている会社もある。日本の保険会社においても、生命保険市場として長期的な成長が期待できるアジア諸国をはじめオセアニアやヨーロッパ等で、個別会社の買収や合併等様々な形態により保険事業参入を行っている会社がある。一方で、生保会社各社をめぐる経営環境が厳しさを増す中、海外展開戦略を見直し、海外拠点の統廃合等を進める会社も出てきている。

日本の国内市場については、規制緩和による商品・価格の自由化が本格的に進むにつれ、高齢者を中心に国民が保有する金融資産をターゲットとして外資系金融機関の日本市場への参入が続いている。生保会社がそのようなマーケットで生き残っていくためには、商品開発力や運用力の強化・向上が不可欠であり、その観点から、上述のように優れた商品開発力や運用ノウハウを有する海外金融機関との提携や協力関係を模索する動きが今後も出てくるものと予想される。

〔参考〕 生命保険募集人に関する諸制度等

項 目	内 容
行動規範	生命保険会社やその役職員がお客さまの視点に立った業務運営を徹底し、生命保険事業が社会から信頼されるよう遵守すべき基本的な事項・方針を取りまとめています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/>
業界共通教育制度	生命保険業界では、昭和49年に業界共通の生命保険募集人教育制度を確立しており、現在、一般、専門、応用、生命保険大学の各課程試験、ならびに変額保険、外貨建保険の販売資格試験を段階的・体系的な教育制度（業界共通教育課程）として実施しています。 ※試験の意義・役割はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/curriculum/> ※その他詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/education/>
継続教育制度	生命保険募集人が、募集活動を行うにあたって「お客さま重視、法令遵守」の視点を持ち続けていくために、「継続教育制度」を実施しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/continue/>
募集人登録情報照会制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、協会のデータベースに登録され、または保管・管理されている募集人の登録申請等に関する情報を、本制度において共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/solicitor/>
合格情報照会制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、協会のデータベース内で保管・管理されている受験申込者に関する情報を、本制度において共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/acceptance/>
変額保険販売資格者登録制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、個人情報の保護に配慮しつつ、変額保険の募集を行わせる者に関する情報を、変額保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/variable/>
外貨建保険販売資格者登録制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、個人情報の保護に配慮しつつ、外貨建保険の募集を行わせる者に関する情報を、外貨建保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/foreign/>
廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度	一般社団法人生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会、生命保険会社、損害保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報を共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/retire_sharing/>
社会貢献活動	一般社団法人生命保険協会では、生命保険商品・サービスを通じて社会公共の福祉の増進に努めることを第一としつつ、契約者をはじめとする国民のみなさまからの理解や信頼の向上が広く国民生活の安定に貢献するとの考えのもと、全国各地においてさまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/activity/social/>

- 業界共通教育課程試験等のテキストおよび試験問題の取扱方針について
- ・業界共通教育課程試験，生命保険講座試験，法令等遵守責任者等資格試験，継続教育制度（以下，業界共通教育課程試験等という）のテキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）の著作権は，生命保険協会に属します。
 - ・テキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）は業界共通教育課程試験等の教育および受験の目的にのみ利用するものとします。
 - ・テキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）の一部または全部を無断で複写・複製・転載・頒布・販売すること，ならびに磁気または光記録媒体，コンピューターネットワーク上等へ入力することは，法律で認められた場合を除き固く禁じます。なお，生命保険協会が許可した場合または法律で認められた場合であっても，当該行為により生じた結果について，生命保険協会は故意または重大な過失がある場合を除き一切の責任は負わないものとします。

生命保険総論

昭和54年4月1日第1版発行

令和 8 年5月1日第48版発行

不 許
複 製

編集発行人

東京都千代田区丸の内3の4の1



一般社団法人

生命保険協会

9040



* 9 0 4 0 *

